Projeto Pedagógico do Curso

de

Enfermagem



Porto Velho-RO,
2014

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

Titulares:
Msc. Daniela Oliveira Pontes
Msc. Mônica Pereira Lima Cunha
Drª. Kátia Fernanda Alves Moreira
Drª. Maria do Socorro Bandeira de Jesus
Drª. Rosely Valéria Rodrigues

Suplentes:
Msc. Priscilla Perez da Silva Pereira
Msc. Daiana Evangelista Rodrigues Fernandes
Esp. Adriana Tavares Hang
Msc. Sônia Dias Lima

Organização do projeto
Msc. Elen Petean

Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Fundação Universidade Federal de Rondônia.

Porto Velho – RO
2015

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR

REITORIA
Reitora: Drª. Maria Berenice Alho da Costa Tourinho
Vice-Reitor *Pro-tempore*: Dr. Ari Miguel Teixeira Ott

PRÓ-REITORIAS
Pró-Reitor de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis: Msc. Rubens Vaz Cavalcante
Pró-Reitor de Graduação: Dr. Jorge Luiz Coimbra de Oliveira
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação: Dr. Ari Miguel Teixeira Ott
Pró-Reitora de Administração: Msc. Ivanda Soares da Silva
Pró-Reitor de Planejamento: Dr. Osmar Siena

NÚCLEOS
Núcleo de Ciências Exatas e da Terra: Dr. Marcelo Vergotti
Núcleo de Tecnologia: Dr. Carlos Alberto Tenório de Carvalho Júnior
Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas: Drª. Glemiria Batista da Costa
Núcleo de Ciências Humanas: Dr. Júlio César Barreto Rocha
Núcleo de Saúde: Dr. José Juliano Cedaro

CAMPI UNIVERSITÁRIOS
Campus de Ariquemes: Dr. Gerson Flores Nascimento (Diretor)
Campus de Ji-Paraná: Dr. Arivelton Cosme da Silva (Diretor)
Campus de Cacoal: Drª. Eleonice de Fátima Dal Magro (Diretora)
Campus de Guajará-Mirim: Dr. George Queiroga Estrela (Diretor)
Campus de Rolim de Moura: Drª. Daiza Gomes da Silva (Diretora)
Campus de Vilhena: Drª. Loidi Lorenzzi da Silva (Diretora)
Campus Presidente Médici: Dr. Marlos Oliveira Pontes (Diretor)

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

Profª. Msc. Daiana Evangelista Rodrigues Fernandes – Chefe de Departamento
Profª. Drª. Maria do Socorro Bandeira de Jesus – Vice-chefe de Departamento
Profª. Esp. Adriana Tavares Hang
Profª. Msc. Adriana Dias Silva
Prof. Msc. Aldrin de Sousa Pinheiro
Prof. Cristiano Lucas de Menezes Alves
Profª. Esp. Daniela Ferreira Borba Cavalcante
Profª. Msc. Daniela Oliveira Pontes
Profª. Msc. Elen Petean
Profª. Esp. Fabíola Mara Gonçalves de Siqueira Amaral
Profª. Drª. Jeanne Lúcia Gadelha Freitas
Profª. Drª. Kátia Fernanda Alves Moreira
Prof. Msc. Mauricio Viana Gomes de Oliveira
Profª. Msc. Mônica Pereira Lima Cunha
Profª. Msc. Priscilla Perez da Silva Pereira
Profª. Msc. Sonia Maria Dias de Lima
Profª. Drª. Soraia Nedeff de Paula
Profª. Drª. Vivian Susi de Assis Canizares

Campus de Porto Velho: Sede (BR 364, km 9,5, sentido Acre, zona rural

Endereço da sede administrativo: Avenida Presidente Dutra, 2965, Centro.

76.801-059 - Porto Velho - Rondônia

Telefone: (69) 2182-2020/2182-2018

Fax: (69) 2182-2019

E-mail: reitoria@unir.br

URL da homepage: http://www.unir.br

URL da homepage: http://www.denf.unir.br/ - E-mail: denf@unir.br

LISTA DE ABREVISTURAS

ABNT	–	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ACC	–	Atividades Curriculares Complementares
AGEVISA	–	Agência Estadual de Vigilância Sanitária
CAPES	–	Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior
CAPS	–	Centro de Atenção Psicossocial
CFE	–	Conselho Federal de Educação
CONDEP	–	Conselho de Departamento
CONDEP/DENF	–	Conselho de Departamento do Curso de Graduação em Enfermagem
CONSAD	–	Conselho Superior de Administração
CONSEA	–	Conselho Superior Ensino Pesquisa e Extensão
CONSUN	–	Conselho Superior Universitário
DATASUS	–	Departamento de Informática do SUS
DCN	–	Diretrizes Curriculares Nacionais
DGP	–	Diretório de Grupos de Pesquisa
DO	–	Disciplinas Optativas
DOU	–	Diário Oficial da União
DSEI	–	Distrito Sanitário Especial Indígena
EAD	–	Educação a Distância
EIA-RIMA	–	Ambiental -Relatório de Impacto do Meio Ambiente
ENEM	–	Exame Nacional do Ensino Médio
FIOCRUZ	–	Fundação Osvaldo Cruz
IBGE	–	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IES	–	Instituição de ensino superior
IFES	–	Instituição Federais de Ensino Superior
LDB	–	Lei de Diretrizes e Bases
NDE	–	Núcleo Docente Estruturante
NUSAU	–	Núcleo de Saúde
PAE	–	Plano de Acompanhamento do Egresso

PIBEX	–	Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária
PIBIC	–	Programa Institucional de Bolsas, Trabalho Voluntário de Iniciação Científica e Apoio
PIBID	–	Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência Indígena
DIVERSIDADE		
PMA	–	Programa de Monitoria Acadêmica
PME	–	Programa de Mobilidade Estudantil
PRAGEP	–	Pró-Reitoria de Administração e Gestão de Pessoas
PROCEA	–	Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis
PROGRAD	–	Pró-Reitoria Graduação
PROPESQ	–	Pró-Reitoria Pós-Graduação
PROPLAN	–	Pró-Reitoria Planejamento e de Pesquisa
SUS	–	Sistema Único de Saúde
TCC	–	Trabalho de Conclusão do Curso
UFMS	–	Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
UNIR	–	Fundação Universidade Federal de Rondônia
UPA	–	Unidade de Pronto Atendimento

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Quadro 1 – Distribuição de horas das atividades complementares da enfermagem (ACG)..... 49

Quadro 2 – Matriz Curricular do Curso de Graduação em Enfermagem da UNIR..... 51

Quadro 3 – Periódicos científicos de interesse para o curso de graduação em enfermagem da UNIR..... 122

Figura 1 – Representação gráfica geral do perfil de formação do curso de graduação em enfermagem da UNIR..... 127

Figura 2 – Representação gráfica do perfil de formação do curso de graduação em enfermagem da UNIR por eixo temático de aprendizagem..... 127

Quadro 4 – Dados da Chefia e Vice Chefia do Departamento de Enfermagem..... 137

Quadro 5 – Relação dos docentes do Departamento de Enfermagem da UNIR, dados pessoais, formação e regime de trabalho..... 140

Quadro 6 – Relação dos docentes do Departamento de Enfermagem da UNIR, atuação no curso e experiência profissional..... 141

Quadro 7 – Relação dos técnicos de laboratório do DENF/UNIR..... 147

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 10

2 CONTEXTUALIZAÇÃO 11

2.1 Contextualização da Fundação Universidade Federal de Rondônia 11

2.1.1 Dados da Universidade Federal de Rondônia 12

2.1.2 Cursos de graduação 13

2.1.3 Cursos de pós-graduação 14

2.1.4 Programas e projetos 14

2.1.5 Grupos de pesquisa 15

2.2 Contextualização da realidade econômica e social da região de abrangência do campus 16

3 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 18

3.1 Objetivos 18

3.1.1 Geral 18

3.1.2 Específicos 18

3.2 Concepção do curso 19

3.2.1 Da missão e dos fundamentos do curso 19

3.2.2 Bases teórico conceituais 19

3.2.3 Bases teórico instrumentais 21

3.3 Justificativa 21

3.4 Legislação 24

3.5 Perfil do egresso 26

3.5.1 Continuidade de estudos para os egressos do curso 27

3.5.2 Mercado de trabalho 27

3.6 Perfil do curso 28

3.6.1 Apresentação, contextualização e funcionamento do curso 29

3.6.2 Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 33

3.6.3 Competências, habilidades e atitudes 37

3.7 Estrutura curricular 41

3.7.1 Conteúdos curriculares e estrutura curricular 42

3.7.2 Disciplinas optativas 48

3.7.3 Atividades curriculares complementares 48

3.7.4 Matriz curricular em tabela ou quadro 51

3.7.5 Ementário 57

3.7.6 O trabalho de conclusão de curso 124

3.7.7 Os estágios curriculares obrigatórios 125

3.8 Representação gráfica de um perfil de formação 127

3.9 Avaliação e metodologias de ensino 129

3.9.1 Metodologias de ensino 129

3.9.2 A avaliação do desempenho 131

3.9.3 A prática como componente curricular 133

3.9.4 Ações implementadas em função dos processos de autoavaliação e de avaliação externa 135

3.9.5 Plano de acompanhamento de egresso 136

4 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO 137

4.1 Gestão administrativa e acadêmica do curso 137

4.1.1 Composição do núcleo docente estruturante do curso de graduação em enfermagem da UNIR 138

4.1.2 Corpo Docente 139

4.2 Recursos humanos 146

4.2.1 Corpo discente 146

4.2.3 Técnicos administrativos 146

5 INFRAESTRUTURA 147

5.1 Descrição da estrutura administrativa do curso 147

5.2 Descrição do suporte administrativo do núcleo 152

5.3 Equipamentos e laboratórios 154

5.4 Biblioteca 157

5.5 Infraestrutura básica utilizada no ensino 157

5.6 Acessibilidade 159

REFERÊNCIAS 159

APÊNDICES 164

Apêndice 1 – Plano de adaptação curricular ao novo currículo do curso de graduação em enfermagem da UNIR 165

Apêndice 2 – Regulamentação do trabalho de conclusão de curso – TCC 171

Apêndice 3 – Regulamento do estágio curricular obrigatório 194

Apêndice 4 – Questionário do plano de acompanhamento de egresso DENF/UNIR 206

ANEXOS 209

1 INTRODUÇÃO

A enfermagem é uma profissão que tem como fundamento o cuidado integral ao ser humano em suas várias etapas de vida, atuando na promoção, proteção, prevenção e recuperação da saúde. O enfermeiro pode atuar no campo da saúde tanto como profissional generalista, quanto como especialista, mas sempre tendo como meta a melhoria da qualidade de vida do usuário/família/comunidade.

O Curso de Graduação em Enfermagem da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) nos seus 26 anos de existência, tem dirigido seus esforços para a formação de profissionais competentes e aptos a atuarem de modo a transformar o cenário de saúde atualmente existente em Rondônia e no Brasil.

A formação dos enfermeiros está alicerçada na qualidade técnica e ética com vistas ao atendimento humanizado, centrado nas necessidades individuais e familiares de cada usuário. A estrutura principal de apoio na formação desse profissional é a inserção dele no contexto social e político para que a prática de sua profissão possa ser, em primeiro lugar, um exercício de cidadania.

Com a intenção de adequar a matriz curricular às novas metodologias de ensino-aprendizagem, aos novos recursos técnico-científicos da profissão e visando atender a Resolução nº 04/09/CES/CNE/MEC que preconiza a integralização do Curso de Graduação em Enfermagem em cinco anos foi elaborado este projeto pedagógico. Sua construção ocorreu por meio de diversas etapas, entre elas encontros de estudo e discussão realizados pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) com a presença de docentes e discentes do curso. Ao final o projeto foi apreciado e aprovado em 24 de setembro de 2014 pelo Conselho do Departamento de Enfermagem (CONDEP/DENF).

Acredita-se que com este novo “olhar” o Curso de Graduação em Enfermagem oferecido por esta instituição federal de ensino superior (IFES) estará apto a formar enfermeiros que além de detentores do conhecimento específico à profissão, sejam capazes de atuar como defensores e fortalecedores do Sistema Único de Saúde (SUS), atuando como agentes multiplicadores das estratégias que objetivam a promoção e prevenção da saúde, base para a qualidade de vida e desenvolvimento de um país.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO

2.1 Contextualização da Fundação Universidade Federal de Rondônia

A UNIR, sediada no endereço: Av. Presidente Dutra, 2965 – Centro. CEP: 76801-974 - Porto Velho – RO. Fone: (69) 2182-2000, foi criada pela Lei de n.º 7.011 de 08 de Julho de 1982. É uma instituição que tem como finalidade precípua a promoção do saber científico puro e aplicado, atuando em sistema indissociável de ensino, pesquisa e extensão. Tem como missão produzir e difundir conhecimento, considerando as peculiaridades amazônicas, visando o desenvolvimento da sociedade. Sua visão é ser referência em educação superior, ciência, tecnologia e inovação na Amazônia, até 2018.

O estado de Rondônia foi criado em 22 de dezembro de 1981, mediante a Lei Complementar nº 41 sancionada pelo Presidente João Batista Figueiredo. Sua transposição de território federal para estado foi uma resposta ao vertiginoso crescimento populacional, motivado pelo contínuo fluxo migratório proveniente de todas as regiões do Brasil, quer para o eixo da BR-364 - núcleos de colonização agrícola, quer para o vale do Alto Madeira - garimpo de ouro. Apesar da promessa de uma terra de promissão, fartura e progresso o que se encontrou foi um intenso movimento migratório com problemas principalmente de ordem social, de saúde, política e de infraestrutura (OLIVERIA, 2005).

Atualmente, Rondônia conta com cinquenta e dois (52) municípios e uma população de 1.503.911 habitantes com dois municípios acima de 100 mil habitantes, cinco municípios entre 50 e 100 mil habitantes, cinco municípios entre 30 e 50 mil habitantes e os demais abaixo de 30 mil habitantes, sendo que o maior município tem população próxima dos 500 mil e o menor próximo de 2,7 mil. Deste total populacional, 76% da população está concentrada em apenas 18 municípios com população maior de 18 mil habitantes. Destacam-se também os mais de 10.000 indígenas do estado de Rondônia.

Em pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (BRASIL, 2010), Rondônia apresentou um índice de 27% de pobreza. A taxa de analfabetismo funcional tem valor próximo de 25%, sendo que 37% dos jovens de 18 a 19 anos trabalham e estão fora da escola e 51 % das crianças que tem até seis anos vivem em famílias com renda *per capita* inferior a meio salário mínimo mensal. O IDH de Rondônia, no ano de 2010, foi 0,756 considerado o 14° estado brasileiro, no ranking nacional (ONU, 2010).

2.1.1 Dados da Universidade Federal de Rondônia

A UNIR é a única instituição de ensino superior (IES) pública do estado, um dos marcos histórico de transformação do Território Federal para o Estado de Rondônia, agindo como agente estratégico do desenvolvimento da região amazônica. É uma instituição oficial que integra o Sistema Federal de Ensino, nos termos da Lei 9.394/96, tendo sede na cidade de Porto Velho e atuação em todo o Estado de Rondônia. É regida pela legislação vigente, por Estatuto, pelo Regimento Geral e pelas resoluções e normas emanadas pelos Conselhos Superiores: Universitário (CONSUN); Ensino Pesquisa e Extensão (CONSEA) e o de Administração (CONSAD).

Tem como função pública o livre exercício da docência, pesquisa e da extensão, que deve ser mantida dentro do contexto das exigências da comunidade, tendo sempre como foco o desenvolvimento regional. A Estrutura Organizacional foi alterada/consolidada pela Resolução nº 014 /CONSUN de 18 de maio de 2012 com publicação no Diário Oficial da União (DOU) em 11 de Junho de 2012, adequação do Estatuto pela Resolução 015/CONSUN de 19 de setembro de 2012, e Resolução nº 111/CONSAD de 25 de setembro de 2013 que redimensiona cargos de direção, funções gratificadas e funções comissionadas de coordenação de cursos.

A sede administrativa da UNIR fica na cidade de Porto Velho, onde estão a Reitoria e as Pró-Reitorias de Administração e Gestão de Pessoas (PRAGEP), de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis (PROCEA), de Graduação (PROGRAD), de Planejamento (PROPLAN) e de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESQ). Atualmente, a UNIR possui sete *campi* em Rondônia localizados nos municípios de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, Rolim de Moura e Vilhena.

Conforme o Estatuto da UNIR esta é uma instituição pluridisciplinar de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, tendo como finalidade precípua a promoção do saber científico puro e aplicado, e, atuando em sistema indissociável de ensino, pesquisa e extensão. Esta instituição têm os seguintes objetivos que se caracterizam por:

- promover a produção intelectual institucionalizada, mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional;

- formar profissionais que atendam aos interesses da região amazônica;

- estimular e proporcionar os meios para criação e a divulgação científica, técnica, cultural e artística, respeitando a identidade regional e nacional;

- estimular os estudos sobre a realidade brasileira e amazônica, em busca de soluções para os problemas relacionados com o desenvolvimento econômico e social da região;

- manter intercâmbio com universidades e instituições educacionais, científicas, técnicas e culturais nacionais ou internacionais, desde que não afetem sua autonomia, obedecidas as normas legais superiores.

O quadro de funcionários da UNIR em 2013 alcançou 323 técnicos administrativos e 630 docentes, destes, 255 são doutores; 303 mestres; 64 especialistas; oito graduados.

2.1.2 Cursos de graduação

Atualmente, a UNIR oferece 55 cursos distribuídos em seus sete *campi*, contribuindo para o enriquecimento da ciência, da tecnologia e dos vários outros setores responsáveis pelo desenvolvimento da sociedade rondoniense. O número de alunos matriculados nas graduações e pós-graduações em 2013 eram 8.268 e 211, respectivamente. O campus Porto Velho oferece 28 cursos, entre eles, quatro cursos da área de saúde. Nos demais campi são: dois cursos de graduação em Ariquemes; cinco em Cacoal; quatro em Guajará Mirim; seis em Ji-Paraná: quatro em Rolim de Moura e cinco em Vilhena. Ao final da década de 1980, iniciou-se a criação de cursos que visavam a atender recursos humanos para a área de saúde, tendo em vista a precariedade do estado nessa área. Criaram-se, então, inicialmente o curso de licenciatura em educação física e, posteriormente, os cursos de enfermagem (1988), psicologia (1988), curso de medicina (2002).

A UNIR conta com cinco núcleos, dentre estes, o Núcleo de Saúde (NUSAU) responsável pela coordenação das funções de ensino, pesquisa e extensão, tanto em termos de planejamento, como de execução e avaliação dos seguintes cursos de graduação da UNIR: educação física, enfermagem, medicina e psicologia. Os demais núcleos são: Ciências Exatas e da Terra, Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Humanas; e Tecnologia.

2.1.3 Cursos de pós-graduação

Atualmente, a UNIR oferece 14 programas de pós-graduação *stricto sensu*, todos devidamente aprovados pelas agências de financiamento. Entre os programas da área de saúde estão:

- Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde: autorizado em 2010 com 30 vagas, tem por objetivo formar profissionais que atuam nos serviços de saúde e no ensino para docência e pesquisa, para que passem a produzir conhecimento técnico-científico, a bem de contribuir para a solução de problemas existentes nos diferentes níveis do SUS. Oferece as seguintes linhas de pesquisa: integração ensino-serviço, processos saúde-doença e o SUS;

- Mestrado/Doutorado Acadêmico em Biologia experimental: em ambas as modalidades possuem área de concentração experimental em patologias infecciosas e parasitarias com ênfase nas relações Patógeno/Hospedeiro, entendendo-se Parasitologia em seu sentido *lato* de agentes patogênicos dos grupos de vírus, bactérias, fungos, protozoários e helmintos, assim como seus vetores artrópodes e/ou moluscos além de toxinas e venenos animais;

- Mestrado/Doutorado Acadêmico em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente: o programa pretende rastrear e discutir os impactos que os sucessivos projetos oficiais de integração regional têm causado ao meio amazônico. Ações como a implantação de grandes eixos fluviais e rodoferroviários, hidrelétricas, mineração e madeireiras desfiguram a ecologia natural amazônica. Além dos projetos agropecuários que promovem gigantescos desmatamentos. Como também toda a questão fundiária e agrícola que tem sido o corolário da implantação dos referidos projetos. Possui duas linhas de pesquisa: ambiente, saúde e sustentabilidade e políticas públicas e desenvolvimento sustentável;

- Mestrado Acadêmico em Psicologia: possui como meta oferecer subsídios teórico-metodológicos que possibilitem a formação de profissionais para o exercício da docência em nível superior e da pesquisa científica no campo da Psicologia, de forma a contribuir para a construção do conhecimento na área e, ao mesmo tempo, responder às demandas da realidade da Região Norte. As pesquisas englobam as seguintes linhas: psicologia escolar e processos educativos e saúde e processos psicossociais.

2.1.4 Programas e projetos

A UNIR possui bolsas de pesquisas implantadas, nas modalidades Programa Institucional de Bolsas, Trabalho Voluntário de Iniciação Científica e Apoio (PIBIC), Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária (PIBEX), Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência Indígena (PIBID DIVERSIDADE) e Programa Conexões de saberes. O PIBIC é um programa que visa ao estabelecimento de políticas para a iniciação científica de alunos de graduação universitária. O PIBEX objetiva contribuir para a formação profissional e cidadã por meio da participação de docentes e discentes de graduação em programas e projetos de extensão. O PIBID DIVERSIDADE é oferecido para alunos do Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural do campus Ji-Paraná.

Além dos programas voltados para pesquisa, a UNIR dispõe também de outros para a comunidade acadêmica, entre eles o Programa de Mobilidade Estudantil (PME) que propicia aos estudantes de qualquer curso das IFES a possibilidade do vínculo temporário com outra instituição federal, cursando uma ou mais disciplinas importantes para a complementação de sua formação.

Outro programa é o de Monitoria Acadêmica (PMA) criado com o objetivo de possibilitar uma maior participação do aluno na realização de trabalhos práticos e experimentais, a partir de experiências auxiliando o professor na preparação de material didático e em participações de atividades de classe e/ou laboratório, colaborando ainda, na orientação de alunos, esclarecendo e tirando dúvidas em atividades de classe e/ou laboratório e participando de atividades que propiciem o seu aprofundamento na disciplina, como revisão de texto, resenhas bibliográficas e outras. E, por fim, o Programa de Educação Tutorial desenvolvido em grupos organizados a partir de cursos de graduação das IFES do país, orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

2.1.5 Grupos de pesquisa

A UNIR possui cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (DGP/CNPq) cinquenta e quatro grupos de pesquisa em funcionamento, devidamente homologados, sendo deste total, seis grupos de área predominante: Ciências da Saúde e Saúde Coletiva. São eles:

- Centro de Estudos em Saúde do Índio de Rondônia – CESIR, formado em 1997 com as seguintes linhas de pesquisa: Antropologia em Saúde; Demografia; Epidemiologia de

Doenças Transmissíveis; Ética em Saúde; Saúde de Populações Indígenas; Saúde do Trabalhador;

- Centro Interdepartamental de Biologia Experimental e Biotecnologia criado em 1999 com as linhas de pesquisa: Citogenética; Farmacogenética; Genética Animal; Genética Humana; Genética, Microbiologia e Microrganismos; Microbiologia; Parasitologia Animal; Química de Produtos Naturais;

- Grupo de estudos do desenvolvimento e da cultura - criado no ano 2000 com as linhas Corporeidade e desenvolvimento humano; Educação Física Escolar; Estudos dos padrões corporais, motores e culturais relacionados à saúde; Políticas públicas para Educação Física Escolar, Desporto, Lazer e Saúde;

- Centro de Estudo e Pesquisa em Saúde Coletiva – CEPESCO criado em 2002 com as seguintes linhas de pesquisa: A saúde nos diversos ciclos de vida (criança, adolescente, mulher, adulto, idoso) e as práticas sanitárias em saúde; Políticas Públicas, Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde Mental; Vigilância em Saúde;

- Centro de Toxicologia e Saúde Ambiental – CETSA criado em 2008 com as seguintes linhas de pesquisa: Exposição humana a poluentes ambientais; Saúde, Ambiente e Trabalho; Toxicologia Experimental;

- Grupo de Estudos e Pesquisas em Psicologia e Educação na Amazônia criado em 2011, linhas de pesquisa: A condição feminina na Amazônia; Infância e Educação Infantil; Processos de escolarização de crianças e adolescentes.

2.2 Contextualização da realidade econômica e social da região de abrangência do campus

O estado de Rondônia nos últimos anos vem passando por mais um processo migratório, desta feita, em decorrência da construção do complexo hidrelétrico do Rio Madeira, com a implantação de duas usinas hidrelétricas – uma em Jirau e outra em Santo Antônio. Estudos de impacto ambiental realizado pelo consórcio responsável pela construção das usinas indicaram que Porto Velho receberia 40 mil novos habitantes, em função das obras. Entretanto, outro estudo contratado pela prefeitura de Porto Velho estimou que o número de pessoas atraídas por empregos chegaria a 140 mil, isto é, cem mil pessoas a mais que a

previsão descrita no Relatório de Impacto do Meio Ambiente (EIA-RIMA) do Consórcio Santo Antônio Energia.

Tal realidade contribuiu para imprimir ao meio urbano, rural e ribeirinho de Rondônia uma nova reconfiguração, atingindo também o âmbito da saúde. A intensa migração ocorrida mais precisamente para Porto Velho causou repercussões sociais e ambientais significativas, desencadeando demandas para organização de serviços de atendimento em saúde e articulação de políticas pública.

Atualmente, as doenças crônicas não contagiosas assumem, em termos de dimensão e amplitude, posições antes ocupadas pelas doenças infectocontagiosas. Porém, devido ao grande empreendimento das usinas hidrelétricas encontra-se um campo vasto para estudos sobre as doenças relacionadas ao trabalho e o alto índice de doenças infecciosas, como por exemplo, a malária e doenças sexualmente transmissíveis.

Assim, há uma demanda que remete à necessidade de preparo dos profissionais de saúde que realizam os atendimentos e a necessidade de execução de pesquisas que acompanhem os impactos sociais e na saúde advindos do intenso fluxo migratório motivados pela instalação das usinas do rio Madeira.

Segundo o Relatório do Departamento de Informática do SUS (DATASUS) (BRASIL, 2009a) a rede do SUS de Rondônia possui 30 unidades de vigilância em saúde, 185 unidades básicas de saúde, 19 clínicas especializadas, 18 hospitais gerais, um laboratório central de saúde pública, cinco policlínicas, 157 postos de saúde, um pronto-socorro geral e 36 unidades mistas. Em, 2009, eram 2.673 médicos (1,8/1.000 hab.), 896 enfermeiros (0,6/1.000 hab.) 139 psicólogos (0.1/1.000 hab.) 185 fisioterapeutas (0,1/1.000 hab.) 59 nutricionistas (0,0/1.000 hab.) e 367 farmacêuticos (0,2/1.000 hab.). A proporção de leitos hospitalares era de 1,7 para cada 1.000 habitantes.

Entre as informações de morbidade destaca-se a taxa de 16,3% casos de internação por doenças infecciosas e parasitárias chegando a 31,4% em crianças de 1 a 4 anos. Também do total de casos de morbidade, encontrou-se a proporção de 15% das internações por doenças do aparelho respiratório chegando a 44,4% em crianças de um a quatro anos por grupo de 1.000 hab. Do total de óbitos – 5.834, entre as causas de morte 30,3% devido a acidentes e 29,5% por agressões (BRASIL, 2009a).

Muitos são os desafios no campo da saúde no estado de Rondônia e o Curso de Graduação Enfermagem da UNIR, é comprometido com o seu desenvolvimento sustentável e entende que é indispensável à formação de profissionais enfermeiros que intervenham na realidade local por meio de ações de saúde que atendam as comunidades da zona urbana, rural, indígena e ribeirinha. Tal curso deve proporcionar aos acadêmicos uma formação de qualidade, generalista e buscando atender as necessidades do mercado de trabalho e sua inserção em quaisquer que sejam suas exigências.

3 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

3.1 Objetivos

3.1.1 Geral

Promover a formação profissional de nível superior em enfermagem, dentro dos princípios éticos e humanísticos, numa proposta de atuação nos processos biopsicossociais, culturais e ambientais.

3.1.2 Específicos

Proporcionar fundamentação técnica, científica e humanística ao aluno, necessárias para desenvolver competências e habilidades voltadas para a prática do cuidado ao indivíduo, família e comunidade nos diversos setores profissionais da sociedade brasileira, bem como na gestão dos serviços, programas e sistemas de saúde.

Promover o processo ensino-aprendizagem de forma a subsidiar o aluno a perceber-se como sujeito crítico/reflexivo e agente de transformação da realidade social.

Promover extensão, visando à integração da sociedade com a academia, bem como a difusão das conquistas e benefícios da pesquisa científica e tecnológica apreendidas na instituição dialogando com o saber popular e demais conhecimentos gerados na sociedade.

Realizar trabalho de pesquisa e investigação científica visando o avanço da ciência e da tecnologia voltado para a melhoria da qualidade de vida da população, contribuindo para o desenvolvimento sociopolítico, econômico e cultural da região e do país.

3.2 Concepção do curso

3.2.1 Da missão e dos fundamentos do curso

O Curso de Graduação em Enfermagem da UNIR tem como missão oferecer uma formação que garanta aos enfermeiros competência técnica, ética e política para atuarem no processo de trabalho em Enfermagem e na saúde, em todos os pontos da rede de atenção integral à saúde, com resolutividade, qualidade e humanidade.

O fundamento epistemológico do processo ensino-aprendizagem para a formação do Enfermeiro traz pressupostos que se fundamentam numa aprendizagem humanística, emancipatória e significativa, que se relacionam com a estrutura do conhecimento da pessoa que aprende. Assim, a formação deste profissional deverá resultar em um fazer significativo e que tenha uma intervenção efetiva na saúde das comunidades.

3.2.2 Bases teórico conceituais

O Curso de Bacharelado em Enfermagem prioriza na formação do enfermeiro questões relativas ao exercício da cidadania, a consciência crítica da realidade, a valorização do conhecimento científico-humanístico na relação educação/saúde, capacitando ao atendimento do ser humano, como centro de todas as atenções e para quem se dirige o objeto e essência da profissão, que é o cuidado humano em todas as suas dimensões.

Os referenciais orientadores do processo de construção do projeto pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem da UNIR levam em consideração os pressupostos teórico-metodológicos da Reforma Sanitária no Brasil, a qual tem influenciado a formação profissional na área da saúde, e consequentemente a do enfermeiro, posteriormente expressos nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os Cursos de Graduação em Enfermagem.

Neste contexto, a enfermagem é entendida como uma prática social, historicamente construída, compreendida como uma profissão dinâmica sujeita a transformações permanentes e que está continuamente incorporando reflexões sobre novos temas, problemas e ações. Entender a enfermagem como prática social é considerá-la como um trabalho necessário e de interesse da sociedade, inserido no processo de trabalho que produz ações e

serviços de saúde, cujo produto final é o cuidado de enfermagem à pessoa no seu processo saúde/doença (TREZZA; SANTOS; LEITE, 2008).

Com o movimento da Reforma Sanitária no Brasil, fica assegurada na Constituição Federal Brasileira de 1988, a necessidade de termos um novo perfil de profissional enfermeiro, que saiba articular a sua prática à realidade social, sustentada pelos princípios e diretrizes do SUS. Nesta perspectiva, o enfermeiro desenvolve suas atividades essenciais, quais sejam: assistencial, gerencial, educativa e de pesquisa, de forma criativa, buscando aliar a autonomia e o compromisso social à solução de problemas da população, e desta forma, contribuindo para a efetivação do SUS.

Essas proposições são igualmente defendidas nas DCN do Curso de Graduação em Enfermagem (BRASIL, 2001a), cuja ênfase está em permitir que os currículos propostos possam construir um perfil acadêmico e profissional com competências, habilidades e conteúdos, dentro de perspectivas e abordagens contemporâneas de formação pertinentes e compatíveis com referenciais nacionais e internacionais, capazes de atuar com qualidade, eficiência e resolutividade, no SUS, considerando o processo da Reforma Sanitária.

Neste sentido, o projeto pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem da UNIR visa contemplar estas questões, entendendo que o ensino em enfermagem vive as contradições próprias de um momento de transição de paradigmas, na qual enfrentar as mudanças necessárias a fim de concretizar um novo modelo de saúde, não constitui uma questão de "opção" e sim de compromisso. Nesta perspectiva, o processo de ensino-aprendizagem adotado possibilitará uma atuação educativa comprometida com a mudança social e a construção da cidadania, o que poderá ser alcançado mediante de trocas de experiências entre professor-aluno-comunidade, em que o fluxo de informações e conhecimentos necessita circular de forma espontânea, porém crítica e reflexiva.

Por conseguinte, o processo educativo voltado para estas mudanças apresenta características transformadoras, ou seja, de superação do ensino tradicional, estático, acrítico e mecanicista, preocupado unicamente com a transmissão de conhecimento, ignorando a singularidade e a realidade de cada indivíduo. Experiências desta natureza lançam os docentes do Curso de Graduação em Enfermagem da UNIR ao desafio de implantar e implementar estratégias pedagógicas, que sustêm uma aprendizagem significativa, transformadora e adequada às demandas sociais e profissionais.

Frente ao exposto, torna-se necessário que a efetivação do processo ensino-aprendizagem no referido curso seja centrado no aluno apoiado pelo professor, como facilitador deste processo, o qual deverá ser constantemente avaliado, visando permitir que ajustes sejam realizados. Pensando numa forma mais flexível, humanizada e compartilhada de se organizar o ensino na enfermagem, podemos encontrar alternativas às consequências negativas impostas pelo modelo tradicional de saúde e educação.

3.2.3 Bases teórico instrumentais

Frente as constantes mudanças sociais e do conhecimento científico, a educação dos profissionais de saúde exige das instituições formadoras um perfil profissional que inclua visão sistêmica, capacidade de comunicação e negociação, habilidades para gerenciar serviços, hábito de autoaprendizagem e um olhar bem mais preparado para lidar com a complexidade e a incerteza.

A fim de promover a formação do profissional enfermeiro, o conhecimento teórico adquirido deve ter um enfoque interdisciplinar e inter-relacionado com os saberes práticos. A articulação teórico-prática é implementada e estimulada precocemente em atividades, tais como: práticas em laboratórios, visitas técnicas, ensino teórico-práticos e ensinos práticos, estágios curriculares e extracurriculares, monitorias, iniciação científica, trabalhos de extensão, viagem de estudo e momentos de atualização, com a participação em eventos científicos.

3.3 Justificativa

Buscar caminhos e pistas para a construção de um currículo interdisciplinar nos remete à necessidade de uma formulação teórica capaz de dar sustentação às proposições... As incertezas interpostas nos levam a Edgar Morin (1988) que em sua obra "O Paradigma perdido: a natureza humana" integrou e articulou biologia, antropologia, etnologia, história, sociologia, psicologia, dentre outras ciências para construir a ciência do homem. Nesta obra o autor traz a confrontação que vem sendo feito entre o mundo das certezas, herdado da tradição e o mundo das incertezas, gerado pelo nosso tempo de transformações. Dessa forma, propõe entender o homem como uma unidade biopsicossociológica, caminhando de uma concepção

de matéria viva para uma concepção de sistemas vivos e, desses, para uma concepção de organização.

O pensamento complexo proposto por Morin pressupõe a busca de uma percepção de mundo, a partir de uma nova ótica: a da complexidade. A complexidade do real, como um novo paradigma na organização do conhecimento, abala os pilares clássicos da certeza: a ordem, a regularidade, o determinismo e a separabilidade.

A educação, nessa perspectiva, se configura como uma função global que atravessa o conjunto dos campos das ciências dos homens e da sociedade, interessando tanto ao psicólogo social, ao economista, ao sociólogo, ao filósofo ou a historiador, dentre outros (ARDOINO; BARBIER; GIUST-DESPRAIRIES, 1998). A incorporação da diversidade do coletivo e a potencialização das experiências multirreferenciais dos sujeitos requer não somente a concepção de um currículo que privilegie a dialogicidade, a incerteza e certeza, a ordem e desordem, a temporalidade e espacialidade dos sujeitos, mas, também, a utilização de dispositivos comunicacionais que permitam a criação de ambientes de aprendizagem capazes de subverter as limitações espaço-temporais da sala de aula.

Esse novo currículo pode ser considerado como práxis interativa, como sistema aberto e relacional, sensível à dialogicidade, à contradição, aos paradoxos cotidianos, à indexalidade das práticas, como instituição eminentemente relevante, carente de ressignificação em sua emergência (FAGUNDES; BURNHAM, 2001).

Sob esse olhar, o currículo se configura como um campo complexo de contradições e questionamentos. Configura-se como um sistema aberto, dialógico, recursivo e construído no cotidiano por sujeitos históricos que produzem cultura e são produzidos pelo contexto histórico-social (FAGUNDES; BURNHAM, 2001; MACEDO, 2002). Nessa nova teia de relações estão inseridos os processos educativos, que se tornam influenciáveis por determinantes do global, do nacional e do local baseada na exploração de novos tipos de raciocínio, na construção cotidiana, relacionando os diversos saberes.

Nesse sentido, adotar a interdisciplinaridade como metodologia no desenvolvimento do currículo implica a confrontação de olhares plurais na observação da situação de aprendizagem para que os fenômenos complexos sejam observados. O conhecimento passa, portanto, a se configurar como uma rede de articulações desafiando nosso imaginário

epistemológico a pensar com novos recursos, reencantando o ato de ensinar e aprender (ASMANN, 1998).

Nosso desafio mais impactante na implementação desse novo currículo do Curso de Graduação em Enfermagem na UNIR está na mudança desejada de avançar, e talvez, até superar o enfoque disciplinar das nossas construções curriculares para a concepção de currículos integrados, através e por meio de seus eixos temáticos e interdisciplinares, caminhando na busca de alcançarmos a transdisciplinaridade. Além disso, promover atualização do PPC com vistas a garantir a efetivação de práticas inovadoras na formação, fazendo-se cumprir a meta do Plano Diretor Institucional da UNIR. Considerando que desejar é o passo inicial para se conseguir, apostamos que é possível abordar, dispor e propor aos nossos alunos uma "relação com o saber" (CHARLOT, 2000, p. 13), em sua totalidade complexa, multirreferencial e multifacetada.

Nesse fazer, os caminhos já abertos e trilhados não serão descartados e abandonados. As rupturas, as brechas, os engajamentos conseguidos são importantíssimos e nos apoiarão no reconhecimento da necessidade de inusitadas pistas. Portanto, a solução de mudança não está em tirar e pôr, podar ou incluir mais um componente curricular, uma matéria, um conteúdo, e sim, em redefinir e repensar o que temos, com criatividade, buscando o que pretendemos. Essa caminhada será toda feita de ir e vir, avanços e recuos e, nesse movimento de ondas, é possível vislumbrarmos o desenho de um currículo em "espiral", ou seja, um trabalho que articula e abrange a dinamicidade dos saberes, organizado nos eixos de formação.

Curricularmente, essa matriz se implementa por meio de um trabalho coletivo e solidário em que o planejamento reconhece como importante deste fazer o princípio da auto-organização da teoria da complexidade. A dialogicidade é fundamental para evitarmos que a própria crítica torne-se hegemônica e maquiada. Desassimilação de hábitos e mudanças de estruturas não são fáceis. É frustrante o esforço que leva a produções sem sentido. Entretanto, não se muda sem alterar concepções, destroçar profundamente conteúdos e rotinas curriculares costumeiras. Portanto, este PPC procura atender as peculiaridades amazônicas com vistas ao desenvolvimento regional.

O modelo disciplinar linear ou o conjunto de disciplinas justapostas numa 'grade curricular' de um curso têm tido implicações pedagógicas diversas e deixado marcas nada

opcionais nos percursos formativos. O currículo centrado na matéria e salivado nas aulas magistrais tem postado o conhecimento social de forma paralela ao conhecimento acadêmico.

Nesse sentido, "o conhecimento aparece como um fim a-histórico, como algo dotado de autonomia e vida própria, à margem das pessoas" (SANTOMÉ, 1998, p. 106), perpassa a ideia de que nem todos os alunos têm condições de serem bem sucedidos em algumas disciplinas, legitimando o próprio fracasso acadêmico. Como consequência, as contradições são relegadas e as dimensões conflituosas da realidade social refutadas, como se fosse possível sua ocultação.

Nosso currículo desejado é um convite a mudanças e afeta, é claro, as funções dos professores que trabalham em um mesmo curso. Distancia-se, pois, do currículo disciplinar em que é possível o trabalho isolado, o eu-sozinho e incomunicável. No qual, encontram-se professores que são excelentes em suas disciplinas, mas que por estarem, muitas vezes, preocupados somente com suas matérias, chegam a induzir os alunos a acreditarem e se interessarem por esta ou aquela disciplina em detrimento de outras, por acreditarem que há "disciplinas mais importantes" e outras "menos importantes".

Pode-se falar, (SANTOMÉ, 1998, p. 206) em quatro formatos de integrar currículos: a) integração correlacionando diversas disciplinas; b) integração através de temas, tópicos ou ideias, c) integração em torno de uma questão da vida prática e diária; d) integração a partir de temas e pesquisas decididos pelos estudantes. Além dessas, há a possibilidade de: integração através de conceitos, integração em torno de períodos históricos e/ou espaços geográficos, integração com base em instituições e grupos humanos, integração em torno de descobertas e invenções e integração mediante áreas de conhecimento.

A construção da realidade social e histórica depende de seus sujeitos, de seus protagonistas. Este projeto e a matriz curricular terá a "cara" ou será o "monstro" que os desenhistas conseguirem pintar a partir da identidade possível construída. Destaca-se nesse contexto, a importância de se valorizar as peculiaridades amazônicas na produção e difusão do conhecimento tornando-o referência no desenvolvimento loco regional.

3.4 Legislação

A construção do projeto pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem da UNIR encontra sustentação legal nos seguintes documentos:

- Constituição Federal Brasileira de 1988;

- Lei nº 7498/86 – Lei do Exercício de Enfermagem;

- Decreto nº 94.406/87, que regulamenta a Lei 7498/86;

- Lei nº 8080/90 – Lei Orgânica da Saúde;

- Lei 8142/90 – Lei Orgânica da Saúde;

- Lei 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

- Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 - Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências.

- Lei nº11.788 de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes;

- Leia nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista;

- Parecer Conselho Nacional de Educação (CNE)/CES Nº1133/2001 – dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Enfermagem, Medicina e Nutrição;

- Resolução CNE/CES nº 03/2001 – Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Enfermagem;

- Resolução CNE/CP n° 01 de 17 de junho de 2004 - Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana;

- Resolução CNE/CES n° 02/2007 - Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial;

- Resolução CNE/CES nº 4, de 6 de abril de 2009 que dispõe sobre a carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos da saúde.

- Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010 - Normatiza o Núcleo Docente Estruturante e dá outras providências;

- Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de maio de 2012 - Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos.

- Decreto Nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004 - Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098,

de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.

- Decreto N° 5.626 de 22 de dezembro de 2005 - Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000.

- Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002 - Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências.

3.5 Perfil do egresso

O Bacharel em Enfermagem formado na UNIR é o portador de diploma de enfermeiro, com formação generalista e capacidade crítica, reflexiva, e criativa, que por meio de uma formação no campo das ciências humanas, sociais e biológicas e no campo de conhecimentos próprios da enfermagem, desenvolve competências técnicas, políticas, educativas e éticas. As competências humanas do saber, saber-fazer, saber ser e saber conviver, lhe possibilita saber agir profissionalmente, como coordenador do processo de trabalho da enfermagem, com base nos princípios da universalidade, equidade, integralidade e solidariedade, no processo coletivo de trabalho em saúde, e demais espaços de inserção.

O enfermeiro egresso da UNIR deverá estar habilitado para o trabalho de enfermagem nas dimensões do cuidar, gerenciar, educar e pesquisar, com base em princípios éticos bem como em conhecimentos específicos e interdisciplinares, considerando o perfil epidemiológico e o contexto sociopolítico, econômico e cultural da região e do país.

Suas atividades profissionais poderão ser desenvolvidas em distintos cenários, como hospitais gerais e especializados, secretarias de saúde, unidades básicas de saúde, unidades de saúde da família, centros de reabilitação, clínicas especializadas, instituições de longa permanência, vigilância em saúde, escolas, creches, presídios, empresas, atendimento domiciliar, bem como na área da pesquisa e de formação de recursos humanos da enfermagem.

Poderá também ampliar seu campo de atuação com atividades relacionadas a auditorias, consultorias e assessorias. Na modalidade autônoma, é possível constituir redes,

cooperativas ou centros de atendimento, realizando consultas de enfermagem, atividades assistenciais e educativas, no âmbito da promoção da saúde, prevenção de doenças e reabilitação.

Deverá ser capaz de trabalhar em equipe e de conhecer e intervir no processo de viver, adoecer e ser saudável, individual e coletivo, com responsabilidade e compromisso com as transformações sociais, a cidadania e a promoção da saúde, contribuindo para a concretização dos princípios e diretrizes do SUS.

3.5.1 Continuidade de estudos para os egressos do curso

O egresso do Curso de Graduação em Enfermagem poderá dar continuidade aos seus estudos, se assim achar necessário e o desejar, uma vez que a UNIR contempla cursos de pós-graduação nos níveis *lato sensu* e *stricto sensu*.

Em relação à pós-graduação *lato sensu*, a UNIR irá implementar a Especialização em Enfermagem Obstétrica, convênio com a Escola de Enfermagem da UFMG, o curso de especialização Educação a Distância (EAD) em Saúde da Família em convênio com a Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ) e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e, recentemente cadastrada a Universidade Aberta do SUS da UNIR (UNA-SUS/RO), poderá ofertar outros cursos de interesse à qualificação do enfermeiro em Rondônia.

No que se refere à pós-graduação *stricto sensu* na área da saúde, a Instituição oferece cursos de mestrado e doutorado em Biologia Experimental; mestrado e doutorado Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente; curso de mestrado em Psicologia, e o Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde.

3.5.2 Mercado de trabalho

O enfermeiro egresso do Curso de Graduação em Enfermagem é generalista, trazendo em si a compreensão de que ele também tem responsabilidade com o seu desenvolvimento profissional.

As constantes mudanças e transformações sociais que inferem na política de saúde exigem um profissional comprometido com sua implementação de forma a assegurar ações produtivas que levem à concretização da modalidade que concretizem o atendimento das necessidades individuais e coletivas.

A enfermagem atua com visão dialética no setor saúde, buscando a integralidade na assistência e primando por um cuidado humanizado. O enfermeiro como profissional de saúde, precisa conhecer a sua comunidade, não se limitando a simples aplicação de técnicas de enfermagem, mas, buscando outras maneiras e possibilidades de atuação. Dentro destas considerações o mercado de trabalho para a enfermagem está cada vez mais em evidência devido a fatores, tais como a priorização pelos órgãos governamentais de saúde de ações no campo da saúde pública com ênfase no desenvolvimento de práticas que proporcionem a promoção e proteção da saúde, especialmente a Estratégia Saúde da Família e Programas Agentes Comunitários de Saúde; assistência de saúde nos níveis de atenção secundário e terciário especializado do ponto de vista tecnológico e de conhecimento científico; o desenvolvimento de uma atitude investigativa que possibilite uma prática criativa e propositiva e a crescente qualificação dos Cursos de Graduação em Enfermagem abrem espaço para profissionais de enfermagem com especialização na área da educação.

3.6 Perfil do curso

Ancorado no tripé ensino-pesquisa-extensão, fundamentado na realidade brasileira, e com especial destaque na Região Norte e em DCN para os cursos de graduação em enfermagem (BRASIL, 2001a), o Curso de Graduação em Enfermagem da UNIR direciona sua prática pedagógica no conjunto de conhecimentos, tendo como objetivos:

- Formar profissional enfermeiro generalista com capacidade crítica, reflexiva e criativa, habilitado para o trabalho de enfermagem nas dimensões do cuidar, gerenciar, educar e pesquisar, com base em princípios éticos, conhecimentos específicos, interdisciplinares, considerando o perfil epidemiológico e o contexto sociopolítico, econômico e cultural da região e do país, contribuindo para a concretização dos princípios e diretrizes do SUS. Com versatilidade para a adaptação às inovações científico-tecnológicas e às transformações no mercado do trabalho, de forma crítica, reflexiva e sistemática;

- Propiciar condições para o desenvolvimento de competências e habilidades gerais e específicas que permitam ao educando atuar nos diferentes cenários da prática profissional do enfermeiro, considerando os princípios e diretrizes das políticas públicas de educação, saúde e meio ambiente;

- Desenvolver uma formação acadêmica/profissional que contemple a articulação do ensino, pesquisa e extensão/assistência, tendo como elemento nuclear o processo saúde/doença e seus determinantes políticos, econômicos, sociais, culturais e ecológicos;

- Relacionar a dimensão teórica à prática durante o processo de formação acadêmica, incentivando a construção do conhecimento pelo aluno;

- Propiciar vivências acadêmicas em que os alunos participem efetivamente de situações reais, assegurando a aprendizagem pelas experiências;

- Estimular a iniciativa para a tomada de decisões e a capacidade para provocar mudanças, de forma articulada com outros profissionais e com a comunidade;

- Preparar o aluno para atuar como membro qualificado e competente na equipe multiprofissional de saúde e educação em saúde;

- Propiciar o desenvolvimento de habilidades para o gerenciamento, o planejamento e a realização de ações em saúde, construídas de forma articulada com a comunidade e pautadas em suas necessidades;

- Despertar o interesse pela pesquisa, incentivando a capacidade reflexiva, criativa, o desenvolvimento científico e tecnológico e a difusão do conhecimento;

- Estimular o interesse pela educação permanente, demonstrando ao aluno que a formação profissional é um processo contínuo.

3.6.1 Apresentação, contextualização e funcionamento do curso

Curso: Bacharelado em Enfermagem.

Currículo: Resolução nº 72/CONSEA/2002. Última reformulação da matriz curricular foi em 2007, aprovada pela Resolução nº 181/CONSEA/2007, com adequação pela Resolução nº 376/CONSEA/2015. Proposta atual para 2015.

Documentação: Curso reconhecido pela Portaria n.º 604 de 31 de maio de 1995, com renovação de reconhecimento pela Portaria 01, de 6 de janeiro de 2012.

Titulação: Enfermeiro (a).

Diplomado em: Bacharel em Enfermagem.

Regime: Crédito semestral.

Admissão do aluno: Processo seletivo regular, com entrada no segundo semestre de cada ano, além de processo seletivo complementar por meio do Vestibulinho, transferência compulsória, regime especial e programa de Mobilidade Acadêmica Interinstitucional e

Intrainstitucional. Outras formas de ingresso, quando autorizadas pelo Conselho Universitário são previstas, como políticas de ações afirmativas indígenas e afrodescendentes, cujos estudantes ingressarão no curso via Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Número de Vagas: 30 anual.

Modalidade e Turno de funcionamento: Presencial e integral (matutino e vespertino) com 100 dias de aula no semestre letivo.

Período de Integralização: Mínimo 10 semestres em cinco anos e máximo 12 semestres em seis anos.

Conceito preliminar do curso e nota no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE): quatro e cinco, respectivamente.

Carga Horária Obrigatória[1]:

- Carga Horária Total – 4.820 horas;
- Carga Horária do Curso – 3.980 horas;
- Carga Horária das Disciplinas Teóricas – 2.360 horas;
- Carga Horária das Disciplinas Práticas (teórico-prática) – 2.460 horas;
- Carga Horária Estágios – 840 horas;
- Carga Horária de Trabalho de Conclusão de Curso I e II – 40 horas total;
- Carga Horária de Atividades Complementares – 200 horas;
- Carga Horária de Disciplinas Optativas – 140 horas.

O Curso de Graduação em Enfermagem da UNIR vem ao longo dos seus 26 anos de existência empreendendo ações no sentido de cada vez mais melhorar a qualidade da formação profissional. Teve sua implantação em 1988, ofertado pela UNIR no campus José Ribeiro Filho, localizado na BR 364, Km 9,5 CEP: 76801-059 - Porto Velho – RO Fone: (69)2182-2100 e com aprovação pela Portaria nº 604 de 21 de maio de 1995, com data de início de funcionamento em 01 de agosto de 1988.

O Currículo do Curso de Graduação em Enfermagem, quando da sua implantação em 1988, obedeceu às determinações do Ministério da Educação (MEC), contidas no Parecer n° 163/72 e na Resolução n° 04/72 do Conselho Federal de Educação (CFE). Em 1989, com a contratação da primeira docente enfermeira pela UNIR e, com a posterior contratação de mais

[1] Essa carga horária refere-se à proposta atual do currículo para 2015 e não ao que se encontra regulamentado pelas resoluções acima citadas.

três enfermeiros docentes, até janeiro de 1990, iniciou-se os debates acerca do Currículo do Curso, tendo em vista as discussões em nível nacional sobre o currículo mínimo para enfermagem brasileira, condizente com os novos conceitos em saúde, os avanços científicos e tecnológicos e a formação profissional adequada à prática de enfermagem.

Neste sentido, o Currículo de Enfermagem implantado sofreu uma primeira reformulação curricular, em 1991, com o objetivo de formar enfermeiros na UNIR, com o Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem, o qual foi aprovado pela Resolução n° 078/CONSEPE, de 18 de dezembro de 1991. Vale salientar que a reformulação curricular foi objeto de inúmeras contribuições críticas, as quais foram amplamente discutidas com a comunidade em seminários, encontros, oficinas de trabalho, inclusive com a participação de assessoria externa, no ano de 1990.

Com a aprovação do Parecer/CFE n° 314/94, por meio da Portaria MEC n° 1.721, de 15 de dezembro de 1994, o Curso de Graduação em Enfermagem, frente à nova determinação do MEC, viu-se na necessidade de rever sua estrutura curricular para atender tais princípios, distribuindo os seus conteúdos por áreas e enquadrando cada área em percentuais de carga horária: 25% para as áreas Biologias e Sociais da Enfermagem, 25% para os Fundamentos de Enfermagem, 35% para Assistência de Enfermagem, 15% para Administração em Enfermagem, além dos estágios curriculares obrigatórios. Após dois semestres, nos quais se procederam várias discussões acadêmicas para atender e/ou incorporar as críticas e necessidades discente e docentes ao currículo, passou a vigorar a nova estrutura curricular do Curso, aprovada pela Resolução n° 188/CONSEPE, de 14 de dezembro de 1995.

Até então, o Curso de Graduação em Enfermagem da UNIR, a exemplo dos demais cursos de nível superior do País, se caracterizou pela ênfase no perfil profissional dos egressos, objetivos e grade curricular, não apresentando explicitamente os princípios básicos que norteiam um Projeto Pedagógico, a considerar: as competências e os objetivos a serem alcançados, as estratégias educacionais e metodológicas e o sistema de acompanhamento e avaliação da aprendizagem.

Com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) (Lei n° 9.394/96), em dezembro de 1996 e após a edição do Edital n° 04/97 pelo MEC, o Curso de Graduação em Enfermagem, realizou várias discussões com os docentes do departamento e externos ao mesmo e com os discentes, no sentido de debater sobre o perfil do graduado, suas

competências e habilidades, a descrição dos procedimentos de atuação, os conteúdos de estudo, a duração do curso, os estágios, as atividades complementares e a estrutura geral do curso.

Surgiram propostas de reformulação de ementas inclusive de cargas horárias e de diminuição de pré-requisitos das disciplinas do Curso, de junção de disciplinas que fragmentavam e dificultavam o processo ensino-aprendizagem, da inclusão de disciplinas optativas e, também sobre o desenvolvimento dos Estágios Curriculares, que teriam de perfazer uma carga horária total de 500 horas distribuídas em dois semestres letivos. Nesta perspectiva, as disciplinas Práticas Desportivas I e II foram suprimidas do currículo em 1998, reduzindo a carga horária do Curso estabelecida pela Resolução n° 188/CONSEPE/95, que era de 4.425 horas, em 60 horas, naquele momento.

Até o início do ano 2000 o ensino de enfermagem na UNIR permanecia assim, marcadamente orientado pela visão tecnicista, cuja competência exigia o domínio no manuseio de equipamentos e máquinas hospitalares, habilidades e destreza manual na execução das tarefas (das mais simplificadas até as mais complexas), planejamento e racionalização de recursos, de tempos e de movimentos. A técnica era a expressão do saber científico, a qual conferia ao enfermeiro o status de intelectual da enfermagem e uma relativa autonomia científica, dentro dos limites da profissão.

Os princípios científicos direcionados, principalmente para o atendimento da "eficiência técnica", asseguravam não só a instrumentalização e as habilidades manuais na execução eficiente dos procedimentos, como possibilitavam o seu controle, tornando-os passíveis de mensuração, supervisão e previsão de resultados. O enfermeiro, formado para o ensino, para a assistência tecnicista e para a administração dos serviços de Enfermagem, monopolizava o trabalho intelectual e as posições de decisão e comando na profissão.

Em 2001, após a homologação do Parecer CNE/CES n° 1133/2001 em 31 de outubro de 2001 e da Resolução CNE/CES n° 3, de 7 de novembro de 2001, o Conselho de Departamento do Curso aprovou, em abril de 2002, a constituição de uma Comissão, composta por quatro docentes enfermeiros e dois discentes do curso para estruturar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), visando reformular a Estrutura Curricular para entrar em vigência a partir do segundo semestre de 2002.

Observou-se, durante o processo de discussão do novo PPC do curso, em 2002 e após

sua vigência, um maior envolvimento de professores e estudantes na implementação, acompanhamento e avaliação da proposta. Entre os docentes, constatou-se o crescente interesse pelas oportunidades de capacitação e pós-graduação, realizadas seja em áreas específicas do trabalho da Enfermagem, em áreas pedagógicas e em áreas afins; a adoção de modelos mais integrados na abordagem dos temas, e uma aproximação maior das atividades pedagógicas com demandas reais do setor saúde.

Entretanto, é um projeto que, por sua ousadia, enfrentou dificuldades. A começar pela própria estrutura acadêmico-administrativa da universidade, cuja organização em unidades departamentais ainda dificulta a tomada de decisões, minimiza o compromisso do professor com áreas que não estão diretamente relacionadas à sua formação básica e limita as possibilidades de mudanças e encaminhamentos que favoreçam o PPC do Curso de Graduação em Enfermagem.

Os aspectos infraestruturais, ainda permanecem insatisfatórios como: a insuficiência do número de professores, de equipamentos e materiais didáticos, a insuficiência do acervo e biblioteca; a escassez de recursos, o sucateamento e a superlotação dos campos de ensino prático - impostas tanto pela política de distribuição e alocação de recursos para o ensino superior, quanto pela forma como a instituição de ensino se relaciona com o SUS, em que se evidencia a falta de uma política de preceptoria de alunos em estágios.

Essas dificuldades, dentre outros aspectos, nos levaram a revisão da matriz curricular, em 2007, para não prejudicar a formação dos alunos que se encontrava em um processo de atrasos por falta de docentes e de campos práticos. Com isso, aprovou-se na UNIR, a Resolução 181/CONSEA/2007, que alterou a matriz curricular do PPC de 2002, vigente até então. Consta no Apêndice 1 o plano de adequação curricular para os alunos remanescentes de matriz curricular anterior.

O novo PPC do Curso de Graduação em Enfermagem visa à formação de bacharéis em enfermagem, retirando a componente licenciatura do seu currículo. Na nova proposta curricular, atendemos as recomendações das DCN, conforme a Resolução nº3/CES/CNE/MEC/2001, favorecendo a reflexão sobre a realidade social, integrando seus conteúdos e práticas ao longo processo de formação.

3.6.2 Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão

Compreendendo a extensão universitária como um campo político, como um espaço relacional e plural, onde se estruturam visões, ideias, ideologias, saberes, projetos e políticas, as práticas acadêmicas tornam-se indissociáveis da realidade social, rompendo com as estruturas de pensamento predominantes passando a definir-se não apenas como terceira função, concorrente com o ensino e a pesquisa, mas, como um paradigma, um modo de ser e fazer universitários, um espaço estratégico para a ampliação da qualidade acadêmica e do papel social da universidade, como um bem público. Desta forma, a metodologia de pesquisa-ação é desenvolvida no processo de construção dos conteúdos (teóricos e práticos) e a extensão universitária está incorporada como um modo de ser e fazer, ou seja, um modo de fazer o ensino, a pesquisa e a produção cultural, numa relação dialógica, entre o saber universal e a realidade cotidiana local, fazendo com que a universidade e os demais setores da sociedade impliquem-se e fomentem-se mutuamente.

Quanto à política de ensino: São realizados estímulos para a participação docente, discente e de profissionais do serviço (preceptores) nas atividades de ensino no que concerne ao fortalecimento e disseminação da flexibilidade curricular nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação e pós-graduação; criação de espaços diversificados de formação, nesse sentido, tem-se na graduação e na pós-graduação práticas em laboratórios, comunidades urbanas e rurais, escolas, cooperativas, organizações não-governamentais, unidades básicas e hospitalares de saúde e centros de atenção psicossocial; desenvolvimento de práticas pedagógicas com a utilização de recursos das novas tecnologias de apoio ao ensino e à aprendizagem, com o uso de computadores, laboratório de informática, projetor multimídia, rodas de conversa, estudos de caso e simulações em laboratórios, ambientes virtuais de ensino; estímulo à mobilidade estudantil, mediante o aproveitamento da carga horária e do conhecimento adquirido com a circulação de estudantes entre cursos, programas e instituições de educação superior nacionais e estrangeiras. Além dos editais de Monitoria. Na pós-graduação são oferecidos cursos de especialização, visando desenvolver a profissão, principalmente em âmbito local. Ressalta-se que no estado de Rondônia não há um programa de pós-graduação stricto sensu na área da enfermagem, o que poderia ampliar os potenciais de formação dos profissionais de enfermagem, bem como de outras áreas da saúde.

Quanto à política de pesquisa: Visando a consolidação dos grupos de pesquisa ligados ao DENF, os docentes submetem seus projetos de pesquisa a agências de fomento

e/ou ao PIBIC institucional, com o envolvimento de alunos do curso na iniciação científica. Atualmente, os docentes do DENF estão envolvidos nos seguintes projetos de pesquisa:

- Avaliação da Política Nacional de Atenção Integral à População Indígena no Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Porto Velho/RO no âmbito das situações especiais. Profª. Msc. Priscilla Perez da Silva Pereira;

- Morbimortalidade em Porto Velho-RO: população do entorno das Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau. Financiamento: CHAMADA PPSUS Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde PPSUS – FAPERO/SESAU/MS/CNPq. Profª. Drª. Kátia Fernanda Alves Moreira, Profª. Drª Maria do Socorro Bandeira de Jesus e Profª. Drª Soraya Nedeff de Paula;

- A Educação Permanente e a integração ensino-serviço em Porto Velho-RO: uma análise qualitativa. Financiamento: Chamada MCTI/CNPq/MS-SCTIE-Decit Nº 08/2013. Profª. Drª. Kátia Fernanda Alves Moreira e Profª. Drª Maria do Socorro Bandeira de Jesus;

- Conhecimento sobre DST/Aids e outros agravos: atitudes e práticas preventivas entre universitários, Porto Velho-RO (Casadinhos). Profª. Drª. Jeanne Lucia Gadelha Freitas e Profª. Msc. Adriana Dias Silva;

- A espiritualidade na experiência de adoecimento e cuidado de famílias em situação crônica. Estudo desenvolvido no âmbito da pesquisa matricial "As instituições de saúde e do poder judiciário como mediadores na efetivação do direito à saúde: análise de itinerários terapêuticos de pessoas/famílias no SUS/MT (Pesquisa DITSUS)", vinculada ao "Grupo de Pesquisa Enfermagem, Saúde e Cidadania" (GPESC) da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso (FAEN/UFMT), financiada pelo Edital de apoio a pesquisa da UFMT – Campus sede/ Edição 001. Profª. Msc. Elen Petean.

Quanto à política de extensão: As diretrizes da UNIR visam à expansão e qualificação das ações de extensão, o fortalecimento e ampliação de interfaces com os movimentos sociais, segmentos produtivos e institucionais, a ampliação e diversificação da produção artístico-cultural, o aprimoramento de gestão e da avaliação dos projetos e a adoção de mecanismos para maior visibilidade das ações institucionais. Seguindo tais diretrizes, o Curso de Graduação em Enfermagem tem concorrido aos editais de extensão, no período 2009-2012, em âmbito nacional: PRO-SAÚDE/PET-SAÚDE e no Programa de Extensão Nacional

(PROEXT). Além das participações do Curso em ações de extensão na comunidade, dentre outras.

São desenvolvidos, pelos professores do DENF, dois projetos de extensão, sendo eles:

- Promovendo a saúde da pessoa idosa na comunidade projeto de extensão universitária. Profª. Drª. Maria do Socorro Bandeira de Jesus, com o envolvimento de nove discentes;

- Saúde Sexual e Reprodutiva Feminina: Saberes e Práticas na Universidade (Casadinhos). Profª. Drª. Jeanne Lucia Gadelha Freitas e Profª. Msc. Adriana Dias Silva. Participam do projeto 21 acadêmicos de enfermagem voluntários;

- Implantação do Programa de Saúde Mental Indígena no DSEI Porto Velho/RO. Profª. Msc. Priscilla Perez da Silva Pereira, com a participação de cinco bolsistas da enfermagem.

O Programa Educação pelo Trabalho para a Saúde – PET-Saúde que valoriza a integração ensino-serviço valoriza a integração ensino-serviço, a educação permanente e a integração docente/assistencial, constituído, portanto, dos três componentes: ensino, pesquisa e extensão indissociáveis. No DENF, sete docentes estão envolvidos nesse Programa:

- PET Saúde da Família – Profª. Drª. Vivian Susi de Assis Canizares desenvolve o projeto de Saúde da Mulher na APS, com o envolvimento de 12 alunos bolsistas entre os cursos de Enfermagem e Medicina, além de seis preceptores das equipes de saúde da família;

- PET Vigilância à Saúde – Profª. Drª. Maria do Socorro Bandeira de Jesus desenvolve um projeto vigilância das doenças transmissíveis, com o envolvimento de oito alunos bolsistas entre os cursos de enfermagem e medicina e duas preceptoras do serviço e da gestão municipal de saúde de Porto Velho;

- PET REDES de ATENÇÃO, coordenado pela Profª. Drª Soraya Nedeff de Paula e desenvolvido em áreas específicas, sendo elas: PET Rede de Atenção Indígena, em que a Profª. Drª. Katia Fernanda Alves Moreira desenvolve o projeto PET Saúde da Mulher Indígena, com o envolvimento de 12 alunos bolsistas dos cursos de enfermagem e medicina e seis profissionais da rede de atenção à mulher nos três níveis de complexidade do sistema, tanto no âmbito estadual quanto municipal; Prof. Msc. Maurício Viana Gomes de Oliveira desenvolve o projeto PET Saúde da Criança Indígena, com o envolvimento de 12 alunos bolsistas dos cursos de enfermagem e medicina, além de seis preceptores nos três níveis de complexidade do sistema do âmbito estadual; Prof. Cristiano Lucas de Menezes Alves

desenvolve o projeto PET Saúde Indígena, com o envolvimento de 12 alunos bolsistas dos cursos de enfermagem e medicina, além de seis preceptores entre o DSEI Porto Velho e a CASAI Porto Velho. E o PET REDE URGÊNCIA e EMERGÊNCIA (RUE), desenvolvido pela Profª. Msc. Daiana Evangelista Rodrigues, com o envolvimento de 12 alunos bolsistas dos cursos de enfermagem e medicina, além de seis preceptores distribuídos entre o Hospital e Pronto Socorro João Paulo II (HPJPII) de âmbito estadual e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zona Sul, de âmbito municipal.

3.6.3 Competências, habilidades e atitudes

Na área da enfermagem, os desafios da realidade social são diversos e por isso requerem competências, habilidades e atitudes profissionais que implicam em compreender o processo saúde/doença como fenômeno socialmente determinado, e atuar como promotor da integralidade da atenção à saúde, entendida como conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos.

Nessa perspectiva há a necessidade da formação de enfermeiros com iniciativa, capacidade para mobilizar conhecimentos e habilidade para tomar decisões na perspectiva do atendimento integral e de qualidade, competências essas necessárias à formação profissional do enfermeiro, compreendendo e incluindo as competências e habilidades gerais de: atenção à saúde, comunicação, liderança, administração e gerenciamento, bem como as competências e habilidades específicas. Assim sendo, estabelecemos para este momento que o enfermeiro formado por este curso desenvolverá as seguintes competências, as quais apresentamos sob a forma de tópicos.

Para assistir/cuidar:

- Atua profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões, em suas expressões e fases evolutivas;

- Incorpora a arte de cuidar como instrumento de interpretação profissional;

- Estabelecem novas relações com o contexto, reconhecendo as estruturas e as formas de organização social, suas transformações e expressões;

- Reconhece a saúde como direito e condições dignas de vida e atua de forma a garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e continuo das

ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;

- Assume o compromisso ético, humanístico e social com o trabalho multiprofissional em saúde;

- Responde às especificidades regionais de saúde mediante intervenções planejadas estrategicamente, em níveis de promoção, prevenção e reabilitação à saúde, dando atenção integral à saúde dos indivíduos, das famílias e da comunidade;

- Utiliza o trabalho em equipe e articulação das práticas de cuidado à saúde individual e coletiva para obter vínculo, responsabilidade, eficiência e eficácia no atendimento;

- Utiliza recursos, instrumentos e métodos de trabalho para orientar e sistematizar a sua prática;

- Compreende as políticas, a organização, a gestão e o financiamento dos sistemas de saúde, comprometendo-se com a superação dos desafios para uma assistência à saúde integral, resolutiva, equânime, humanizada e de qualidade;

- Estabelece relações de trabalho pautadas em atitudes e princípios éticos, humanísticos e sociais com os trabalhadores e comunidade favorecendo o trabalho e a tomada de decisões em grupo e facilitando o enfrentamento crítico-criativo das situações cotidianas de trabalho e problemas de saúde;

- Gerencia o processo de cuidar em enfermagem, considerando os diferentes contextos e demandas de saúde, reconhecendo-se como coordenador do trabalho da equipe de enfermagem e utilizando adequadamente novas tecnologias e instrumentos que promovam a qualidade e a humanização da atenção à saúde;

- Valoriza o trabalho multiprofissional/interdisciplinar em saúde, sendo capaz de atuar em equipe integrando as ações e conhecimentos de enfermagem às ações multiprofissionais em saúde;

- Planeja, executa e avalia ações de educação e promoção da saúde, considerando a especificidade dos diferentes grupos sociais, condições de vida e trabalho às quais estão expostos, bem como dos distintos processos de saúde-doença-cuidado;

- Presta cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades de indivíduos, famílias e comunidades considerando o contexto socioeconômico, político e cultural em que estão inseridos;

- Desenvolve ações de atenção integral à saúde da criança, do adolescente, do adulto, do idoso e da mulher primando pela integralidade e resolutividade, tanto em nível individual como coletivo, em todos os âmbitos de atuação profissional.

Para investigar/ensinar e atuar na Educação Permanente:

- Atua como sujeito no processo de formação de recursos humanos;

- Desenvolve formação técnico científica que confira qualidade ao exercício profissional;

- Compreende a política de saúde no contexto das políticas sociais, reconhecendo os perfis epidemiológicos das populações;

- Atua como sujeito no processo de formação profissional voltada ao desenvolvimento de competência e ao trabalho em equipe, considerando o processo de trabalho como eixo norteador desse processo;

- Planeja, executa e participa dos programas de formação e qualificação contínua dos trabalhadores de enfermagem e de saúde, de modo a favorecer o desenvolvimento de competência profissional para o cuidado, na perspectiva da integralidade;

- Desenvolve, participa e aplica pesquisa e ou outras formas de produção de conhecimento que objetivem a qualificação profissional com crescente domínio e autonomia, segundo o padrão de excelência ético-social;

- Reflete acerca da prática profissional, analisando seu contexto de trabalho, com senso crítico-reflexivo, criatividade e sensibilidade, comprometendo-se com as transformações necessárias e reconhecendo-se como cidadão e sujeito desse processo;

- Desenvolve, participa e aplica pesquisas e/ou outras formas de produção de conhecimento visando aprimorar a prática profissional e promover a superação de desafios dos serviços, das práticas e de problemas de saúde, individual e coletiva;

- Participa da composição das estruturas consultivas e deliberativas do sistema de saúde;

- Reconhece e respeita a diversidade de aspectos sociais, culturais e físicos de usuários dos serviços de saúde, família, comunidade, trabalhadores e alunos com os quais o profissional se articula, combatendo quaisquer formas de discriminação sexual, étnica e social, valorizando a vida em uma lógica de inclusão social.

Para gerenciar, tomar decisões, comunicar e liderar:

- É capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de se comunicar, de tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe, gerenciar conflitos e situações de crise de forma estratégica e que possibilite aprendizagem dos sujeitos envolvidos no processo;

- Interfere na dinâmica de trabalho institucional reconhecendo-se como agente desse processo;

- Reconhece-se como coordenador do trabalho da equipe de enfermagem;

- Gerencia o processo de trabalho em enfermagem com princípios de Ética e de Bioética, com resolutividade tanto em nível individual como coletivo em todos os âmbitos de atuação profissional segundo relevância e impacto na transformação da realidade institucional e social;

- Utiliza os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem e da assistência à saúde;

- Coordena e participa ativamente do processo de cuidar em enfermagem, levando em conta contextos e demandas de saúde da população;

- Exerce a profissão reconhecendo-se como cidadão comprometido e ativador de mudanças das práticas de saúde e do processo de formação profissional;

- Reconhece o papel social do enfermeiro, instrumentalizando-se para atuar em atividades de política, planejamento e gestão em saúde participando da composição de estruturas consultivas e deliberativas do sistema de saúde, bem como fomentando a participação popular e o controle social.

Para associar-se:

- Participa da composição das estruturas deliberativas e executivas do sistema de saúde;

- Assessora órgãos, empresas e instituições em projetos de saúde.

- Reconhece o papel social do enfermeiro para atuar em atividade política e de planejamento em saúde;

- Reconhece a necessidade de organizar-se como trabalhador de saúde, tem disponibilidade interna e participa das lutas por melhores condições de vida e trabalho, comprometendo-se a participar das entidades de classe.

3.7 Estrutura curricular

A organização curricular do Curso de Graduação em Enfermagem segue o disposto nas DCN para os Cursos de Graduação em Enfermagem. Neste sentido, abrange um conjunto de componentes curriculares ordenados por meio de pré-requisitos que constituem um corpo de conhecimentos organizados em três eixos: Domínio Comum, Domínio Conexo e Domínio Específico.

O Domínio Comum representa um corpo de conhecimentos comuns a todos os cursos da UNIR para a formação científica e cidadã dos discentes. Já o **Domínio Conexo** representa um corpo de conhecimento comum a Grande Área das Ciências da Saúde comuns aos cursos de graduação vinculados ao NUSAU da UNIR. E o **Domínio Específico** diz respeito aos conhecimentos voltados à área de formação profissional do aluno.

Essa estruturação contempla conteúdos essenciais ligados às áreas de Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e Sociais, Ciências Exatas e Ciências da Enfermagem, tal como preconiza as DCN para os Cursos de Graduação em Enfermagem.

Em relação às **Ciências Biológicas e da Saúde**, a matriz curricular inclui os conteúdos teórico-práticos referentes a bases moleculares e celulares dos processos normais e alterados da estrutura e da função dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, aplicados a situações decorrentes do processo saúde/doença no desenvolvimento da prática de assistência de enfermagem.

Nas **Ciências Humanas e Sociais**, são inclusos os conteúdos referentes às diversas dimensões da relação indivíduo/sociedade, contribuindo para a compreensão dos determinantes sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, ambientais, éticos e legais no âmbito individual e coletivo do processo saúde/doença. Destacando-se também, aspectos relacionados aos direitos humanos, com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948).

Quanto às **Ciências Exatas** são ensinados conteúdos referentes à Matemática, Informática e Bioestatística.

A respeito das **Ciências da Enfermagem**, são contemplados conteúdos referentes a Fundamentos de Enfermagem, Assistência de Enfermagem, Administração de Enfermagem e Ensino de Enfermagem, tanto individual como coletivamente.

Na **Assistência de Enfermagem** serão abordados conteúdos teóricos e práticos que compõe a assistência de enfermagem individual e coletiva prestado à criança, ao adolescente, ao adulto, à mulher, ao idoso, considerando os determinantes socioculturais, econômicos e ecológicos do processo saúde/doença, bem como os princípios éticos, legais e humanísticos inerentes ao cuidado de enfermagem.

Na **Gerência de Enfermagem** os conteúdos teóricos e práticos contemplarão a gerência do processo de trabalho e da assistência de enfermagem, além do Planejamento e Avaliação em Saúde. E no Ensino de Enfermagem serão abordados conteúdos pertinentes à capacitação pedagógica do enfermeiro.

Para a plena efetivação desta organização curricular, contamos com o apoio de diferentes Laboratórios da Universidade e dos serviços de saúde do município de Porto Velho e do Estado de Rondônia para o desenvolvimento das aulas teórico-práticas e práticas dos diferentes componentes curriculares. Serão viabilizadas pelo curso as realizações do Estágio Curricular Supervisionado, do Trabalho de Conclusão de Curso e das Atividades Curriculares Complementares.

3.7.1 Conteúdos curriculares e estrutura curricular

O currículo é uma instância reprodutora de valores. Na modernidade o conhecimento tem sido fragmentado, sob a justificativa da necessidade de aprofundamento. Porém, após o conhecimento aprofundado das partes, não se tem assistido à recomposição do objeto do conhecimento, num movimento necessário para se processar a síntese, e com isso há uma valorização da restrição do conhecimento à restrição da especialidade (ANASTASIOU, 2006).

O PPC do Curso de Graduação em Enfermagem desenvolverá as disciplinas com componentes de cargas horárias: teórico, prático e teórico-prático. A integração de conteúdos das várias disciplinas ministradas por docentes do DENF ocorrerá em uma disciplina denominada “Prática Integrativa” de modo compartilhado. Estas serão oferecidas em cada período letivo com conteúdos oferecidos por meio de estratégias, como aulas dialogadas, aulas em laboratórios, visitas técnicas, seminários e estudos de caso, portfólios reflexivos, a partir de estratégias problematizadoras de ensino, que requerem movimentos de idas à

realidade para observação; vindas à sala de aula, para teorização; idas à realidade, para intervenção, podendo-se utilizar também da plataforma Moodle.

As práticas integrativas, cujos conteúdos são teórico-práticos e práticos (ensino prático ou clínico) serão identificadas na Matriz Curricular por um asterisco e com uma chamada em cada final de semestre para caracterizar essa modalidade do componente prático como (T-P). As "Práticas Integrativas" serão desenvolvidas do II ao VIII período de forma interdisciplinar e/ou interdepartamental. As disciplinas compartilhadas terão, conforme a Resolução nº 313/CONSEA/2013, um coordenador com 2h/a semanais, computadas na carga horária docente.

A inserção dos acadêmicos de enfermagem nos cenários de aprendizagem ocorre desde o início do curso. Os Estágios Curriculares Supervisionados ocorrem no IX e X períodos, momento em que os acadêmicos, já munidos de conhecimentos teóricos, teórico-práticos e práticos relacionados aos diferentes eixos temáticos do currículo, exercitam a prática profissional do enfermeiro.

A hora-aula dos componentes teóricos, práticos e teórico-práticos de cada disciplina será desenvolvida em 50 minutos sem prejuízo do total da carga horária do curso. Ressalta-se que todas as disciplinas deverão ser desenvolvidas com carga horária distribuída ao longo do semestre letivo, cumprindo o calendário acadêmico em todos os períodos.

Serão reservadas as sextas feiras visando à participação dos acadêmicos em atividades culturais, de pesquisa, extensão e complementares previstas no PPC.

Os conteúdos curriculares dos Domínios Comum, Conexo e Específico estão agrupados em 10 eixos temáticos, favorecendo sucessivas aproximações dos discentes com problemas/temas, a partir de diferentes cenários e níveis de complexidades, os quais mobilizam os processos mentais, socioafetivos, psicomotores e intelectuais, conforme preconizam as DCN para o Curso de Graduação em Enfermagem. Além disso, contempla alguns conteúdos curriculares que atendem aos requisitos legais e normativos do MEC no que concernem as Políticas de Educação Ambiental, as DCN para a Educação das Relações Étnico-Raciais, diretrizes para a Educação em Direitos Humanos e a Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, especialmente nas disciplinas: saúde ambiental, saúde indígena, enfermagem, educação e saúde, libras, legislação e ética em enfermagem, saúde mental. Assim como, em todas as disciplinas de conteúdo específico da enfermagem,

nas quais são abordados os diferentes ciclos de vida, os direitos humanos e educação ambiental são abordados transversamente em seus conteúdos de modo contínuo e permanente.

A estrutura curricular do Curso de Graduação em Enfermagem da UNIR apresenta carga horária total de 4.820 horas, sendo 140h de componentes optativos e 200h de atividades complementares à formação, integralizados em cinco (5) anos (10 períodos).

A carga horária do Curso de Graduação em Enfermagem da UNIR é assim distribuída: 3.640h de disciplina obrigatórias, 140h de disciplinas optativas e 200h de atividades complementares, onde são incluídas 20% da CH total em Estágio Curricular Supervisionado I (420h) e Estágio Curricular Supervisionado II (420h), o Trabalho de Conclusão de Curso I (20h) e Trabalho de Conclusão de Curso II (20h).

As disciplinas optativas de graduação podem ser cursadas em outros cursos da UNIR ou em outras IES, desde que tenham relação com a formação generalista do enfermeiro prevista neste PPC e sua realização seja aprovada pelo CONDEP/DENF. A seguir apresentamos os eixos temáticos e suas respectivas cargas horárias.

EIXO TEMÁTICO 1 – Homem, ambiente e cultura (580h)

Estuda as relações que o homem, historicamente, estabeleceu com a natureza, analisando as implicações decorrentes dessa condição para a vida no planeta e para a vida em sociedade. Integra os conteúdos das ciências humanas, sociais e filosóficas às ciências biológicas e aos conhecimentos específicos da saúde e da enfermagem, contextualizando o aluno nos processos políticos e culturais que envolvem as condições de vida e de saúde da população mediante de disciplinas obrigatórias.

É formado por disciplinas integrando os conteúdos da: Anatomia Humana (80h); Processos Bioquímicos Vitais (60h); Citologia e Embriologia (60h); Psicologia em Saúde (60h); Leitura e produção textual (40h); Introdução à Filosofia (60h); Sociologia Geral (60h); Histologia (60h); Enfermagem em Saúde Coletiva I (60h); Saúde Ambiental (40h).

EIXO TEMÁTICO 2 – O homem e o processo saúde-doença (520h)

Busca favorecer a compreensão do aluno acerca da complexidade do ser humano, a partir das suas múltiplas dimensões - biológica, psíquica, social, ética, política, cultural, entre outras - que interferem no modo de viver e de ser humano em sociedade. Para tanto, utiliza-se dos conhecimentos das ciências humanas, sociais e tecnológicas que, associadas às ciências biológicas e aos conhecimentos da Enfermagem, introduz o aluno no mundo da complexidade

da condição humana, da história da profissão e da educação em saúde. Leva à reflexão crítica e à compreensão do mundo natural e da produção social, e à análise da posição dos sujeitos frente aos condicionantes e determinantes das condições de vida e de saúde da população. Esse eixo é composto por componentes que abordam conteúdos de disciplinas obrigatórias e optativas da: Fisiologia (80h); Biofísica (40h); Parasitologia (60h); História e Introdução à Enfermagem (60h); Informática Aplicada à Saúde (40h); Enfermagem, Educação e Saúde (20h); Fundamentos e Práticas para o Cuidado de Enfermagem I (60h); Introdução à Metodologia Científica (40h); Saúde Indígena – Optativa (40h); Prática integrativa em Enfermagem I (80h).

EIXO TEMÁTICO 3 – O ser e o viver em contextos sociais (560h)

Favorece o estabelecimento de articulações entre os modos de ser e viver do ser humano, em suas múltiplas e complexas dimensões. Estuda as interações e processos, intrínsecos ou extrínsecos ao indivíduo e à produção social do processo saúde-doença. Fundamenta-se nos conhecimentos e técnicas aplicadas na saúde/Enfermagem e modelos teóricos que orientam as práticas de saúde, mediante de disciplinas obrigatórias e optativas. Esse eixo aborda os conteúdos de: Farmacologia (80h); Processos Patológicos (60h); Microbiologia/Imunologia (80h); Fundamentos e práticas para o cuidado de Enfermagem II (60h); Matemática Aplicada à Enfermagem (20h); Legislação e Ética em Enfermagem (20h); Bases Teóricas da Gestão de Saúde e da Enfermagem nos Serviços de Saúde I (40h); Inglês Instrumental (40h); Libras - optativa (60h); Prática integrativa em Enfermagem II (100h).

EIXO TEMÁTICO 4 – Enfermagem e o cuidado em saúde (480h)

Possibilita a intervenção no processo saúde-doença no âmbito individual e coletivo. O aluno desenvolve habilidades no campo do saber, do saber-fazer e ser da Enfermagem. Esse eixo contempla os componentes curriculares obrigatórios: Fundamentos e práticas para o cuidado de Enfermagem III (80h); Pesquisa em Saúde e na Enfermagem (20h); Bases Teóricas da Gestão de Saúde e da Enfermagem nos Serviços de Saúde II (40h); Enfermagem em Saúde Coletiva II (20h); Epidemiologia (40h); Prevenção e Controle de infecções em Saúde (20h); Estatística aplicada à Saúde (60h); Prática integrativa em Enfermagem III (200h).

EIXO TEMÁTICO 5 – Enfermagem e o processo saúde-doença (480h)

Possibilita a compreensão ampliada do processo saúde/doença, das relações intra e extracorpóreas, psicossociais, culturais e demais interações que se realizam no âmbito da coletividade e dos processos individuais. O discente desenvolve habilidades no campo do saber, do saber-fazer e ser da Enfermagem, nos diversos processos de trabalho e campo de atuação, considerando o enfoque da promoção, prevenção tratamento e recuperação da saúde e a ética profissional. Esse eixo contempla os componentes curriculares obrigatórios: Enfermagem na Atenção à Saúde do Adulto I: abordagem clínica (60h); Enfermagem na Atenção à Saúde do Adulto II: abordagem cirúrgica (80h); Enfermagem no processo de cuidar em urgência e emergência (60h); Enfermagem e a Saúde do Trabalhador – Optativa (40h); Prática integrativa em Enfermagem IV (240h).

EIXO TEMÁTICO 6 – Enfermagem na rede de atenção à saúde à mulher, à criança e ao adolescente (460h)

Aprofunda os conhecimentos, desenvolvendo competências/habilidades para desenvolver a atenção integral nas redes de atenção à saúde da mulher, à criança e ao adolescente. Visa articular o conhecimento da gerência do cuidado, com as especificidades da atenção aos agravos à saúde individual/coletiva. Formado por disciplinas obrigatórias: Enfermagem à saúde da mulher I (40h); Enfermagem à saúde da mulher II (100h); Enfermagem na Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente (40h); Prática integrativa em Enfermagem V (280h).

EIXO TEMÁTICO 7 – Enfermagem na rede de atenção ambulatorial e hospitalar (440h)

Proporciona ao aluno aprofundar conhecimentos e desenvolver habilidades e competências para a compreensão da realidade de saúde, nas redes de cuidados para o exercício crítico da profissão. Esse eixo é formado por conteúdos pertinentes às disciplinas: Enfermagem na atenção Integral à Saúde do Idoso (40h); Enfermagem no cuidado a Saúde Mental (40h); Relações Humanas no Processo de Trabalho da Enfermagem (60h); Práticas Educativas em Saúde/Enfermagem (60h); Prática integrativa em Enfermagem VI (240h).

EIXO TEMÁTICO 8 – A Enfermagem e a gerência do cuidado nas redes de atenção à saúde (420h)

Oportuniza ao aluno aprofundar conhecimentos anteriormente adquiridos e desenvolver habilidades e competências para a compreensão da realidade de saúde no

contexto social, político e operacional da atenção integral à saúde. Tem como eixo orientador as redes de cuidado, para o desenvolvimento da reflexão crítica, da proposição criativa e da resolutividade das ações de Enfermagem. Desenvolve competências e habilidades do aluno para a promoção e a proteção à saúde da família, prevenção e controle de situações ou grupos de risco, e para a atenção básica integral à saúde nas diversas fases do ciclo vital humano. São desenvolvidos os conteúdos das disciplinas: Enfermagem em doenças tropicais e transmissíveis (40h); Enfermagem em Saúde Coletiva III (40h); A gerência do processo de trabalho da enfermagem na gestão, rede básica e rede hospitalar/ambulatorial (60h); Prática integrativa em Enfermagem VII (280h).

EIXO TEMÁTICO 9 – Gerência do processo de cuidar em enfermagem I (440h)

Assegura a vivência profissional ao concluinte do curso, cujas atividades são desenvolvidas na rede hospitalar e ambulatórios dos serviços de saúde. Prevê o acompanhamento de preceptores de campo (enfermeiros/gerentes do serviço) e equipe de tutores (à distância) formados por professores do DENF. Visa a possibilidade de consolidar competências e conferir um grau de autonomia relativa, integrando os processos de cuidar da Enfermagem aos processos de cura em saúde, promovendo a autoconfiança, coresponsabilização, vínculo, iniciativa e criatividade do formando, em vias de sua inserção no mercado no pleno exercício da profissão, nos processos de intervir/assistir/cuidar, gerenciar equipes e processos de trabalho, educar e investigar em saúde. Compõe esse eixo: Estágio Curricular Supervisionado I (420h); Trabalho de Conclusão de Curso I (20h).

EIXO TEMÁTICO 10 – Gerência do processo de cuidar em enfermagem II (440h)

Assegura a vivência profissional ao concluinte do curso, cujas atividades são realizadas em comunidades, na rede ambulatorial e hospitalar dos serviços de saúde. Prevê o acompanhamento de preceptores de campo (enfermeiros/gerentes do serviço) e equipe de tutores (à distância) formados por professores do DENF. Visa à possibilidade de consolidar competências e conferir um grau de autonomia, autoconfiança, responsabilização, vínculo, iniciativa e criatividade do formando, em vias de sua inserção no mercado, no pleno exercício da profissão, exercendo sua autonomia relativa nos processos de intervir/assistir/cuidar, gerenciar equipes e processos de trabalho, educar e investigar em enfermagem, no que

concerne a atenção individual e coletiva em saúde. Nesse eixo são desenvolvidos: o Estágio Curricular Supervisionado II (420h) e Trabalho de Conclusão II (20h).

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS = 3.640h

DISCIPLINAS OPTATIVAS = 140h

ESTÁGIOS (mínimo 20% disciplinas obrigatórias) = 840h

ATIVIDADES COMPLEMENTARES = 200h

TOTAL= 4.820h

3.7.2 Disciplinas optativas

Os discentes poderão realizar as Disciplinas Optativas (DO) externas à área da saúde, em qualquer um dos cursos oferecidos na UNIR ou fora da IFES, com a autorização do CONDEP/DENF. As DO específicas da área da saúde serão oferecidas pelo DENF ou outro departamento convidado a ministra-las. O total de horas obrigatórias exigidas pelo Curso de Graduação em Enfermagem como DO são 140 horas.

3.7.3 Atividades curriculares complementares

As Atividades Curriculares Complementares (ACC) constituem ações que visam à complementação do processo de ensino-aprendizagem, sendo desenvolvidas ao longo do Curso de Graduação em Enfermagem e equivalem a 200 horas/aula, distribuídas ao longo da matriz curricular. As ACC constituem mecanismo de aproveitamento dos conhecimentos adquiridos pelo estudante por meio de estudos e práticas independentes, presenciais ou à distância, realizadas na Universidade ou em outros espaços formativos, sendo consideradas obrigatórias para a integralização do currículo.

Na condição de requisito obrigatório, as ACC respondem ao princípio da flexibilidade, pelo qual o estudante tem a oportunidade de decidir sobre uma parte do currículo, sendo ordenadas por duas legislações específicas: pela determinação constante na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/1996, a qual estabelece, em seu artigo 3º, a "valorização da experiência extraclasse", e também pelo que estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem, bem como outras legislações em que esse projeto pedagógico se sustenta.

As atividades complementares constituem um conjunto de estratégias didático pedagógicas que permitem, no âmbito do currículo, a articulação entre teoria e prática e a complementação dos saberes e habilidades necessários, a serem desenvolvidas durante o período de formação do estudante. Para que as atividades complementares sejam validadas, é preciso que o acadêmico apresente à Chefia do DENF, no semestre em que o mesmo realizou a atividade ou no semestre subsequente, documentos formais, oriundos do local de desenvolvimento da atividade, comprovando o programa desenvolvido e a carga horária. As referidas atividades complementares e suas respectivas cargas horárias serão enviadas para a Diretoria de Registro e Controle Acadêmico (DIRCA). Para cada atividade, será designada uma carga horária máxima para fins de quantificação, distribuídas como se segue:

Quadro 1 - Distribuição de horas das atividades complementares da enfermagem (ACG)

Atividades relacionadas à área de conhecimento do curso	**Documentação /comprovante**	**Horas recebidas como Atividades Complementares**	**Carga horária máxima**
Apresentação de trabalho científico (tema livre) em congresso, seminário, simpósio, salão de iniciação científica e similar, local regional, nacional e internacional	Anais (publicação do resumo) e certificado	Cada publicação / certificado equivale para: Resumo simples: 5h Resumo expandido:10h Resumo completo: 15h	Máximo 40h
Apresentação de trabalho científico sem publicação de anais (pôster e apresentação oral)	Certificado	Cada certificado equivale para: Pôster: 5h Apresentação oral: 5h	Máximo 20h
Coautoria de trabalho cientifico em eventos	Certificado	Cada certificado equivale, em evento local, à 2,5 horas; nacional à 5 horas e internacional 7,5	Máximo 10h
Publicação de Artigo Científico completo em periódico especializado; Com comissão editorial, sem a necessidade de ser o primeiro autor	Artigo efetivamente publicado ou carta de aceite	Cada publicação equivale à 40 horas	Máximo 80h
Autoria ou Coautoria de capítulo de livro (relacionado ao objeto do curso)	ISNN, Ficha catalográfica, sumário e página inicial do capítulo	Cada publicação equivale à 20h	Máximo 40h
Participação, categoria ouvinte em eventos científicos: semana acadêmica, seminário, jornada, encontro, fórum, congresso.	Certificado de no mínimo 8 horas, contendo o número de horas ou o programa completo	Máximo 20 horas por evento	Máximo 40h

	com horários.		
Participação, categoria ouvinte em eventos científicos: apresentação e/ou defesa pública de trabalho de conclusão de curso, monografia, dissertação e tese.	Certificado por IES.	Monografias e trabalhos de conclusão de curso 1hora. Teses e dissertações 2 horas.	Máximo 10h
Atuação como monitor (com bolsa remunerada ou voluntário) em disciplinas do curso ou áreas afins	Atestado fornecido pela Unidade Acadêmica	Cada semestre de monitoria equivale a 20 horas.	Máximo 80h
Estágio extra-curricular reconhecido pela IES	Contrato e certificado/atestado (mínimo 120 horas) contendo descrição das atividades desenvolvidas, número de horas ou período e horário.	Cada certificado equivale a 40 horas.	Máximo 80h
Ministrar cursos e palestras em atividades discentes científicas	Certificado contendo o número de horas ou o programa completo com horários	Cada hora comprovada equivale às 5h de atividades Complementares	Máximo 40h
Participar de cursos e palestras em atividades discentes científicas	Certificado contendo o número de horas ou o programa completo com horários	Cada hora comprovada equivale às 5h de atividades Complementares	Máximo 40h
Participação em ações de extensão /cursos de extensão/ ação comunitária / campanha de vacinação (voluntariado)	Certificado de no mínimo 8 horas, contendo o programa completo com horários de participação	O estudante poderá acumular no máximo 40h por certificado	Máximo 80h
Participação em projetos institucionalizados e financiados pela UNIR ou outro órgão de fomento (PIBIC, PET Saúde, PROEXT, PIBEX).	Certificado / atestado com resumo da Pesquisa realizada, descrição das atividades	Soma das horas dos Certificados	Máximo 120h

	realizadas, período de realização, com horas ou horário de atividade.		
Participação em projetos de extensão institucionalizados na UNIR	Certificado / atestado com descrição das atividades realizadas, período de realização, com horas ou horário de atividade.	Soma das horas dos Certificados	Máximo 60h
Participação em comissões (organização de evento), representante de conselhos e turma, Diretório Discentes	Certificado / ata/atestado contendo a número de horas ou o período de atividades e horários	O estudante pode computar no máximo 10 horas mês	Máximo 60h
Cursos de língua estrangeira e de informática realizados durante a graduação; libras e outros de áreas afins.	Certificado emitido pela instituição com aprovação (ou documento comprobatório de desempenho).	Cada semestre de curso equivale a 10 horas	Máximo 60h
Cursos em EAD, na área de formação acadêmica	Certificado com no mínimo 5 horas, emitido pela instituição com aprovação (ou documento comprobatório de desempenho)	Soma das horas dos Certificados	Máximo 20h

3.7.4 Matriz curricular em tabela ou quadro

Quadro 2 - Matriz curricular do Curso de Graduação em Enfermagem da UNIR

I PERÍODO	**C. Horária**		**Créditos**		**Pré-requisitos**
	T	**T-P e/ou P**	**T**	**T-P e/ou P**	
1. Anatomia Humana	60	20	3	1	--

2. Processos Bioquímicos Vitais	60	__	3		--
3. Citologia, Embriologia	60		3		--
4. Psicologia em Saúde	60	___	3		--
5. Leitura e Produção Textual	40		2		--
6. Introdução à Filosofia	60	___	3		--
7. Sociologia Geral	60	___	3		--
8. Histologia	40	20	2	1	
9. Enfermagem em Saúde Coletiva I *	40	*20	2	1	--
10.Saúde Ambiental	40		2		--
SUB-TOTAL	**520**	**60**	**26**	**3**	

OBS: * modalidade teórico-prática (T-P)

CARGA HORÁRIA TOTAL = 580horas – 29h/a semanais

II PERÍODO	**C. horária**		**Créditos**		**Pré-requisitos**
	T	**T-P e/ou P**	**T**	**T-P e/ou P**	
1. Fisiologia	60	20	3	1	1.1; 1.2
2. Biofísica	40		2		
3. Parasitologia	40	20	2	1	--
4. História e Introdução à Enfermagem *	40	20	2	1	
5. Informática Aplicada à Saúde	___	40		2	--
6. Enfermagem, Educação e Saúde	20		1		
7. Fundamentos e práticas para o cuidado de Enfermagem I	60		3		
8. Introdução à Metodologia Científica	40	___	2		
9. Saúde Indígena (OPTATIVA)	40		2		
10. Prática integrativa em Enfermagem I *		*60 + 20		*3+1	1.1; 1.2
SUB-TOTAL	**340**	**180**	**17**	**9**	

OBS: * modalidade teórico-prática (T-P)

CARGA HORÁRIA TOTAL = 520h – 26h/a semanais

III PERÍODO	**C. horária**		**Créditos**		**Pré-requisitos**
	T	**T-P**	**T**	**T-P**	
1. Farmacologia	80		4		2.1
2. Processos Patológicos	60		3		1.3; 1.8; 2.1
3. Microbiologia/Imunologia	80		4		
4. Fundamentos e práticas para o cuidado de Enfermagem II	60		3		
5. Matemática Aplicada à Enfermagem	20		1		
6. Legislação e Ética em Enfermagem	20		1		
7. Bases Teóricas da Gestão de Saúde e da Enfermagem nos Serviços de Saúde I	40		2		
8. Libras (OPTATIVA)	60		3		
9. Inglês Instrumental	40		2		
10. Prática integrativa em Enfermagem II *		100		5	2.10
SUB-TOTAL	**460**	**100**	**23**	**5**	

OBS: * modalidade teórico-prática (T-P)

CARGA HORÁRIA TOTAL = 560h – 28h/a semanais

IV PERÍODO	**C. horária**		**Créditos**		**Pré-requisitos**
	T	**T-P**	**T**	**T-P**	
1. Fundamentos e práticas para o cuidado de Enfermagem III *	80		4		
2. Pesquisa em Saúde e na Enfermagem	20		1		
3. Bases Teórico-prática da Gestão de Saúde e da Enfermagem nos Serviços de Saúde II	40		2		

4. Enfermagem em Saúde Coletiva II	20		1		
5. Epidemiologia	40		2		
6. Prevenção e Controle de infecções relacionadas à assistência à saúde	20		1		
7. Estatística aplicada à Saúde	60		3		
8. Prática integrativa em Enfermagem III *		*80+120		10	3.9
SUB-TOTAL	**280**	**200**	**14**	**10**	

OBS: * modalidade teórico-prática (T-P)

CARGA HORÁRIA TOTAL = 480 h – 24h/a semanais

	Carga				
V PERÍODO	**Horária**		**Créditos**		**Pré-requisitos**
	T	**T-P+P**	**T**	**T-P+P**	
1. Enfermagem na Atenção à Saúde do Adulto I: abordagem clínica *	60		3		
2. Enfermagem na Atenção à Saúde do Adulto II: abordagem cirúrgica *	80		7		
3. Enfermagem no processo de cuidar em urgência e emergência *	60		3		
4. Enfermagem e a Saúde do trabalhador (OPTATIVA)	40		2		
5. Prática integrativa em Enfermagem IV *		*20+220		1+11	4.8
SUB-TOTAL	**240**	**240**	**12**	**12**	

OBS: * modalidade teórico-prática (T-P)

CARGA HORÁRIA TOTAL = 480 h – 24h/a semanais

	Carga				
VI PERÍODO	**Horária**		**Créditos**		**Pré-requisitos**
	T	**T-P+P**	**T**	**T-P+P**	

1. Enfermagem à saúde da mulher I	40		2		
2. Enfermagem à saúde da mulher II *	100		5		
3. Enfermagem na Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente	40		2		
4. Prática integrativa em Enfermagem V *		*80+200		4+10	5.5
SUB-TOTAL	**180**	**280**	**9**	**14**	

OBS: * modalidade teórico-prática (T-P)

CARGA HORÁRIA TOTAL = 460 h – 23h/a semanais

	Carga				
VII PERÍODO	**Horária**		**Créditos**		**Pré-requisitos**
	T	**T-P+P**	**T**	**T-P+P**	
1. Enfermagem na atenção Integral à Saúde do Idoso	40		2		
2. Enfermagem no cuidado a Saúde Mental	40		**2**		
3. Relações Humanas no Processo de Trabalho da Enfermagem	60		3		
4. Práticas educativas em Saúde/Enfermagem	60		3		
5. Prática integrativa em Enfermagem VI *		*80+160		*4+8	6.4
SUB-TOTAL	**200**	**240**	**10**	**12**	

OBS: * modalidade teórico-prática (T-P)

CARGA HORÁRIA TOTAL = 440 h – 22h/a semanais

	Carga				
VIII PERÍODO	**Horária**		**Créditos**		**Pré-requisitos**
	T	**T-P+P**	**T**	**T-P+P**	
1. Enfermagem em doenças tropicais e transmissíveis	40		2		

2. Enfermagem em Saúde Coletiva III	40		2		
3. A gerência do processo de trabalho da enfermagem na gestão, rede básica e rede hospitalar/ambulatorial *	60		3		
4. Prática integrativa em Enfermagem VII *		*40+240		*2+12	7.4
SUB-TOTAL	**140**	**280**	7	**14**	

OBS: * modalidade teórico-prática (T-P)

CARGA HORÁRIA TOTAL = 420h – 21h/a semanais

IX PERÍODO	**Horária**		**Créditos**		**Pré-requisitos**
	T	**P**	**T**	**P**	
1. Estágio Curricular Supervisionado I		420		21	8.4
2. Trabalho de Conclusão de Curso I		20		1	2.8,4.2, 8.4
SUB-TOTAL		**440**		**22**	

CARGA HORÁRIA TOTAL = 440h

X PERÍODO	**Horária**		**Créditos**		**Pré-requisitos**
	T	**P**	**T**	**P**	
1.Estágio Curricular Supervisionado II		420		21	9.1
2. Trabalho de Conclusão de Curso II		20		1	9.2
SUB-TOTAL		**440**		**22**	

CARGA HORÁRIA TOTAL = 440h

CARGA HORÁRIA DAS DISCIPLINAS TEÓRICAS = 2.360h

CARGA HORÁRIA DAS DISCIPLINAS PRÁTICAS (teórico-prática e prática) = 2.460h

CARGA HORÁRIA OPTATIVAS = 140 h

CARGA HORÁRIA ATIVIDADES COMPLEMENTARES = 200h

CARGA HORÁRIA DO CURSO = 3.980h

CARGA HORÁRIA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENFERMAGEM = 840h
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO=4.820h

3.7.5 Ementário

I PERÍODO

1. ANATOMIA HUMANA (80h)

EMENTA: Descrição da morfologia do corpo humano. Estudo macroscópico e inter-relação entre órgãos e sistemas. Nomenclatura anatômica, anatomia do sistema locomotor, sistema cardiovascular, respiratório, digestório, urinário, reprodutor, endócrino, tegumentar e nervoso.

OBJETIVOS: Compreender a estrutura do corpo bem como sua parte funcional, de uma forma que o acadêmico seja capaz de conceituar, descrever, caracterizar e reconhecer cada uma delas, as quais servirão de base para outras disciplinas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

CASTRO, S. V. **Anatomia fundamental**. 3. ed. Curitiba: Macgray Hill do Brasil Ltda., 1985.

NETTER, F. H. **Atlas de anatomia humana**. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A. **Anatomia básica dos sistemas orgânicos**. 2. ed. .Rio de Janeiro: Atheneu, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FREITAS, V. **Anatomia:** conceitos e fundamentos. São Paulo: Artmed, 2004.

MACHADO, A.; HAERTEL, L. M. **Neuroanatomia funcional**. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2013.

SOBOTTA, J. **Atlas de anatomia humana**. 23. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.

THIBODEAU, G. A.; PATTON, K. T. **Estrutura e funções do corpo humano**. 11. ed. São Paulo: Manole, 2002.

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. **Princípios de anatomia e fisiologia**. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.

SITE: Atlas 3D on-line MSD. Disponível em: <http://www.msdbrazil.com/msdbrazil/hcp/library/corpo_humano_interativo.html>.

2. PROCESSOS BIOQUÍMICOS VITAIS (60h)

EMENTA: Estudo bioquímico da célula. Estudo da importância química e biológica dos carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, enzimas e coenzimas. Estudo do metabolismo de Proteínas, Carboidratos, Lipídios. Equilíbrio ácido-base. Integração e controle do Metabolismo.

OBJETIVOS: Apresentar os princípios básicos e necessários para compreensão dos processos biológicos ao nível das transformações moleculares dos constituintes celulares como as biomoléculas (carboidratos, lipídeos, proteínas, aminoácidos, enzimas, vitaminas, hormônios) e as principais vias metabólicas relacionadas ao crescimento dos organismos vivos; Desenvolver conhecimentos básicos de que levem o acadêmico a perceber a relação entre as reações bioquímicas e a fisiologia; Propiciar ao acadêmico os conhecimentos necessários que a interdisciplinaridade da bioquímica exige; Desenvolver no acadêmico o conhecimento clínico de bioquímica; Propiciar o completo entendimento dos processos químicos associados às células.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

CAMPBELL, M. K. FARRELL, S. O. **Bioquímica**: combo. 5. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2007.

CHAMPE, P. C; FERRIER, D. R.; HARVEY, R. A. **Bioquímica**: ilustrada. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.

NELSON, D. L.; COX, M. M. **Princípios de bioquímica de Lehninger**. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DEVLIN, T. M. et al. **Manual de bioquímica com correlações clínicas**. 6. ed. São Paulo: Blucher, 2007.

RIEGEL, R. E. **Bioquímica**. 5. ed. São Leopoldo: Unisinos, 2012.

ROSKOSKI, R. **Bioquímica.** Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997.

BERG, J. M.; TYMOCZKO, J. L.; STRYER, L. **Bioquímica**. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

VOET, D.; VOET, J. G.; PRATT, C. W. **Bioquímica**. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.

3. CITOLOGIA E EMBRIOLOGIA (60h)

EMENTA: Estudo dos fundamentos de microscopia e das técnicas citológicas. Organização geral das células, fecundação, segmentação, placentação e membranas fetais. Período embrionário e início do período fetal.

OBJETIVOS: Proporcionar uma visão geral do desenvolvimento embrionário e da formação dos órgãos e sistemas que constituem o organismo humano.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

HYAMS, J. S.; BOLSOVER, S. R.; SHEPHARD, E. A. **Biologia celular**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.

MOORE, K. L.; PERSUAD, T. V. N.; TORCHIA, M. G. **Embriologia básica**. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

ROMERO, M. E. C.; SALCEDO, P. G.; HOFMANN, D. A. M. **Embriologia:** biologia do desenvolvimento. São Paulo: Iatria, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MAILLET, M. **Biologia celular**. 8. ed. São Paulo: Santos Editora, 2003.

MELO, R. A. **Embriologia humana**. São Paulo: Atheneu, 2002.

MOORE, C. C.; PERSAUD, T. V. N. **Embriologia clínica**. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

COOPER, G. M.; Hausman, R. E. **A célula**: uma abordagem molecular. 3. ed. São Paulo: Artmed, 2007.

THOMPSON, J. S.; THOMPSON, M. N. **Genética médica**. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.

4. PSICOLOGIA EM SAÚDE (60h)

EMENTA: Propiciar um espaço para discussão acerca da relação mente-corpo e a influência desta relação no processo saúde-doença. Identificar, caracterizar e analisar questões relacionadas à Psicologia e Saúde para subsidiar o aluno em sua relação com o indivíduo, família e comunidade, auxiliando-o na assistência de enfermagem.

OBJETIVOS: Breve contextualização histórica da Psicologia. Interdisciplinaridade. Formação da Personalidade. Teoria Psicanalítica de Freud. Crise/Conflito/Estresse. Psicossomática.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ATKINSON, R. et al**. Introdução à psicologia**. 11. ed. Porto Alegre: Artmed, 1995.

HALL, C. S. et al. **Teorias da personalidade**. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000.

MELLO, J. F. et al. **Psicossomática hoje**. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALAMY, S. **Psicologia hospitalar**: a ausculta da alma. Belo Horizonte: [s.n.], 2003.

ANGERAMI-CAMON, V. A. **Urgências psicológicas no hospital**. São Paulo: Pioneira, 1998.

DAVIDOFF, L. L. **Introdução à psicologia**. 3. ed. São Paulo: Makron Books, 2001.

PAPALIA, D. E.; OLDS, S. W. **Desenvolvimento human**o. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.

SKINNER, B. F. **Ciência e comportamento humano**. 11. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

5. LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL (40h)

EMENTA: Aspectos da Língua Portuguesa referentes à recepção e produção de diferentes tipos de textos.

OBJETIVOS: Ler e produzir textos, analisando as tipologias textuais e as características determinantes da textualidade.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ABREU, A. S. **Curso de redação**. São Paulo: Ática, 1997.

KOCH, I. V. **Argumentação e linguagem**. São Paulo: Cortez, 1987.

FAUSTTICH, E. L. **Como ler, entender e redigir um texto**. 9. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1998.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

CITELLI, A. **Linguagem e persuasão**. São Paulo: Ática, 1994.

GALVES, C. **O Texto**: leitura e escrita. Campinas: Pontes, 1998.

KOCH, I. V. **Desvendando os segredos do texto**. São Paulo. São Paulo: Cortez, 2002.

FRANCO, C. A. X.; TERRA, C. **Prática de texto**. Rio de Janeiro: Vozes, 1992.

TEZZA, C.; FARACO, C. A. **Oficina de texto**. Rio de Janeiro: Vozes, 2003.

6. INTRODUÇÃO À FILOSOFIA (60h)

EMENTA: Diferentes concepções de caráter filosófico acerca do ser humano e da sociedade: do lugar do ser humano como cidadão e como profissional da saúde à luz de uma fundamentação de natureza filosófica. Ética e Bioética.

OBJETIVOS: Propiciar ao estudante o conhecimento de conceitos básicos da Filosofia relacionados ao ser humano, à sociedade e à cidadania. Desenvolver o pensamento crítico acerca da Ética e Bioética.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ARANHA, M. L. **Filosofando**: introdução à filosofia. São Paulo: Moderna, 2003.

PEGORARO, O. A. **Ética e bioética**: da subsistência à existência. Rio de Janeiro: Vozes, 2002.

GELAIN, I. **A ética, a bioética e os profissionais de enfermagem**. 4. ed. São Paulo: EPU, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ENGELHARDT JUNIOR, H. T. **Fundamentos da bioética**. São Paulo: Loyola, 1998.

SINGER, P. **Ética prática**. Tradução Jeferson Luiz Camargo. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

ARANHA, M. L.; MARTINS, M. H. P. **Temas de filosofia**. São Paulo: Moderna, 2005.

CHAUÍ, M. **Convite à filosofia**. 14. ed. São Paulo: Ática, 2010.

PESSINI, L. **Distanásia**: Até quando prolongar a vida? São Paulo: Loyola, 2001.

_____. **Eutanásia**: por que abreviar a vida? São Paulo: Loyola, 2004.

7. SOCIOLOGIA GERAL (60h)

EMENTA: Significado e âmbito da Sociologia. Origem e desenvolvimento da sociedade. O indivíduo na sociedade. Diferentes concepções de Estado. Significado e funções das instituições (econômicas, governamentais, familiar, religiosas, grupos e classes sociais e processos sociais).

OBJETIVOS: Conhecer e analisar aspectos relevantes da Sociologia, relacionando-se com a Saúde; Aplicar o conhecimento sociológico ao campo da saúde e conhecer a realidade socioeconômica em que ocorre; Superar o senso comum e analisar a sociedade a partir de uma perspectiva crítica, adquirindo uma postura de ser crítico como futuro enfermeiro; Revisar os

principais paradigmas teórico-sociológicos, explicitando sua influência na saúde; Possibilitar a compreensão do acadêmico para realizar análise sociológica do contexto da saúde.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BOUDON, R. **Tratado de sociologia**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1995.

COSTA, C. **Sociologia**: introdução à ciência da sociedade. 4. ed. São Paulo: Moderna, 2010.

DOMINGUES, J. M. **Sociologia e modernidade**: para entender a sociedade contemporânea. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.

GIDDENS, A. **Sociologia.** Porto Alegre: Artmed, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

GUARESCHI, P. **Sociologia crítica**: alternativas de mudança. 63. ed. Porto Alegre: EDIPUCRS/JORNAL MUNDO JOVEM, 2011.

CARVALHO, M. **A família contemporânea em debate**. São Paulo: Cortez, 2000.

DELORS, J. et al. **Educação um tesouro a descobrir**. São Paulo: Cortez; Brasília: MEC: UNESCO, 1998.

HELLER, A. **A crise dos paradigmas em ciências sociais e os desafios para o século XXI.** Rio de Janeiro: Contraponto, 1999.

PASTORE, E.; TEDESCO, C. J. **Ciências sociais**: temas contemporâneos. Passo Fundo: Méritos Editora, 2005.

8. HISTOLOGIA (60h)

EMENTA: Estudo dos tecidos, suas características e funções, bem como sua microscopia.

OBJETIVOS: Reconhecer histologicamente os diversos tecidos que constituem os diferentes órgãos do corpo, bem como suas funções específicas; Identificar, na prática, a constituição histológica e citológica de órgãos e sistemas, utilizando a microscopia; Utilizar linguagem e terminologias próprias que possibilitem a descrição e compreensão das estruturas microscópicas dos tecidos e células, facilitando suas relações interdisciplinares.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

JUNQUEIRA, L. C; CARNEIRO, J. **Histologia básica**. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.

CORMACK, D. H. **histologia.** 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.

DI FIORE, M. S. H. **Atlas de histologia**. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

GENESER, F. **Atlas de histologia**. 3. ed. Buenos Aires: Guanabara Koogan, 2003.

GARTNER, L. P.; HIATT, J. L. **Tratado de histologia**. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.

GEORGE, L. L. **Histologia comparada**. 2. ed. São Paulo: Roca, 1998.

HAM, A. **Histologia**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1985.

HOSS, M. H.; WOJCIECH, P. **Histologia**: Texto e Atlas. 6. ed. São Paulo: Panamericana, 2012.

9. ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA I (60h)

EMENTA: Integrar o estudante à vida universitária, à formação profissional e à prática de enfermagem. Políticas públicas de saúde. Introdução ao estudo e aplicação de métodos de apreensão do processo saúde-doença mediante a identificação, análise e discussão das condições sociais, políticas e culturais de sua produção. Introdução às práticas educativas em saúde.

OBJETIVOS: Promover a capacitação técnica e senso crítico do aluno em relação à realidade de saúde e dos serviços de saúde, estimulando sua participação efetiva na prestação de assistência de enfermagem e no planejamento de saúde, compatíveis com as necessidades de saúde da população.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BRASIL. Relatório final da 8ª Conferência Nacional de Saúde. In: **Conferência nacional de saúde**, Brasília, 1986. Anais. Brasília: Ministério da Saúde/Ministério da Previdência e Assistência Social, 1987, p. 381-89.

CAMPOS, G. W. S. et al. **Tratado de saúde coletiva**. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 2012.

CZERESNIA, D. FREITAS, C. M. **Promoção da saúde**: conceitos, reflexões, tendência. 2. ed. 2. Reimpressão. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

LIMA, N. T. et al. **Saúde e democracia**: história e perspectivas do SUS. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005.

PAIM, J. S. **Saúde, política e reforma sanitária**. Salvador: CEPS – ISC, 2002.

ANDRADE, S. M.; SOARES, D. A.; CORDONI JÚNIOR, L. **Bases da saúde coletiva.** Londrina: UEL/Abrasco, 2001.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Carta dos direitos dos usuários da saúde.** 2006. Disponível em: <www.saude.gov.br>.

_____. **Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990**. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 de set. 1990. p. 018055.

10. SAÚDE AMBIENTAL (40h)

EMENTA: Esta disciplina visa à construção do conhecimento sobre as relações entre o homem e o meio ambiente enfocando, particularmente, o impacto deste último sobre a saúde e qualidade de vida da população. Pretende-se despertar no graduando a consciência ambiental propiciando a reflexão crítica sobre a importância do desenvolvimento sustentável e a necessidade de monitoração dos recursos naturais renováveis.

OBJETIVOS: Desenvolver conteúdos referentes a questões de Saúde Ambiental, que contribuam para o desenvolvimento de ações/praticas educativas para a saúde; Refletir sobre as principais situações que contribuem para o Equilíbrio e Desequilíbrio do Ambiente e seus reflexos na saúde dos indivíduos; Compreender a articulação entre o contexto econômico, particularmente padrões de produção e consumo, e a degradação da saúde e do meio ambiente; Discutir o papel das instituições públicas, privadas e dos movimentos sociais frente às questões ambientais no Brasil; Relacionar os principais problemas ambientais, sua abrangência e agravos decorrentes destas situações; Discutir a importância do desenvolvimento sócio-econômico-sustentável considerando suas premissas, factibilidade e aspectos éticos envolvidos; Identificar os principais indicadores utilizados em saúde ambiental.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

MINAYO, M. C. S.; MIRANDA, A. C. **Saúde e ambiente sustentável**: estreitando nós. Rio de janeiro: Fiocruz, 2002.

PELIZZOLI, M. L. **A emergência do paradigma ecológico**: reflexões ético-filosóficas para o século XXI. Petrópolis: Vozes, 1999.

SOUZA, R. S. **Entendendo a questão ambiental**: temas de economia, política e gestão do meio ambiente. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BRASIL. **Agenda 21**. Disponível em: <http://www.mma.gov.br>.

FÓRUM NACIONAL DE ONG E MOVIMENTOS SOCIAIS. **Construyendo el futuro – tratados alternativos de Rio 92**. Instituto de Ecologia Política. Santiago-Chile: REDES/FOE, 1993.

FREITAS, C. M.; PORTO, M. F. **Saúde, ambiente e sustentabilidade**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2006.

LEFF, E. **Epistemologia ambiental**. São Paulo: Cortez, 2001.

NAVARRO, M. B. M. A. Trabalho, saúde, ambiente, cognição e sustentabilidades. **Ciência e Cognição**, n. 4, p. 25-34, 2005.

II PERÍODO

1. FISIOLOGIA (80h)

EMENTA: Introduzir e capacitar o aluno no entendimento da Fisiologia Humana, suas aplicações nas diferentes áreas da Saúde.

OBJETIVOS: A Fisiologia é o alicerce para os profissionais da saúde. O objetivo desta disciplina é proporcionar aos acadêmicos uma compreensão sólida de seus princípios e uma visão integral das diferentes funções das células e dos diferentes sistemas orgânicos. É objetivo também, realizar relações entre os sistemas orgânicos destacando os mecanismos integrativos que determinam a homeostasia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

AIRES, M. M. **Fisiologia**. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

KOEPPEN, B. M.; STANTON, B. A. **Berne & Levy - fisiologia**. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.

BARMAN, S. M. et al. **Fisiologia médica de Ganong**. 24. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GUYTON, A.C.; HALL, J. E. **Tratado de fisiologia médica**. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

COSTANZO, L. S. **Fisiologia**. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

GUYTON, A. C. **Fisiologia humana**. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988.

HANSEN, J. T.; KOEPPEN, B. M. **Netter**: atlas de fisiologia humana. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

KOEPPEN, B. M.; STANTON, B. A. **Fisiologia**. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

2. **BIOFÍSICA (40h)**

EMENTA: A química da célula. Bioenergética. Energética da hidratação de solutos polares e apolares. Membranas biológicas: estrutura e função. Transporte através das membranas. Bioeletrogênese. Canais iônicos e Excitabilidade celular. Acoplamento excitação contração. Contração muscular. Princípios do eletrocardiograma. Princípios de hemodinâmica. Tamponamento dos sistemas biológicos. Transporte dos gases respiratórios. Radiações.

OBJETIVOS: Estudar as forças e movimentos em sistemas biológicos. Descrever a audição e a visão em termos de comportamento ondulatório. Descrever a biofísica dos sistemas circulatório e respiratório. Descrever fenômenos elétricos nas células. Descrever fenômenos de superfície. Estudar a física das radiações e os efeitos biológicos das radiações.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DURAN, J. E. R. **Biofísica fundamentos e aplicações**. 2. ed. São Paulo: Pearson Education 2011.

GARCIA, E. A. C. **Biofísica**. São Paulo: Sarvier, 2002.

HENEINE, I. F. **Biofísica básica**. São Paulo: Atheneu, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

OKUNO, E.; CALDAS, I. L.; CHOW, C. **Física para ciências biológicas e biomédicas.** São Paulo: Harbra, 1986.

OLIVEIRA, J.; WATCHER, P. H.; AZAMBUJA, A. A. **Biofísica para ciências biomédicas.** 3. ed. Porto Alegre: Edipucrs, 2008.

MALNIC, G.; MARCONDEZ, M. **Fisiologia renal**. São Paulo: Edart., 1972.

GUYTON, A.C.; HALL, J. E. **Tratado de fisiologia médica**. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

KOEPPEN, B. M.; STANTON, B. A. **Berne & Levy - fisiologia**. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.

3. PARASITOLOGIA (60h)

EMENTA: Estudo geral dos principais seres vivos que parasitam o homem, enfocando: classificação, morfologia, habitat, ciclo evolutivo, transmissão, patogenia, diagnóstico laboratorial, epidemiologia e profilaxia.

OBJETIVOS: Trabalhar os fundamentos básicos da Parasitologia, caracterizando as famílias parasitárias e os principais representantes de interesse regional, enfatizando suas estreitas relações com os homens; Habilitar o acadêmico no reconhecimento e identificação de espécies de importância médica e sanitária; Capacitar o acadêmico a atuar na promoção à saúde através da educação sanitária, baseado nos métodos para evitar a transmissão e proliferação de parasitas, com suporte no conhecimento dos ciclos biológicos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

NEVES, D. P. **Parasitologia humana**. 12. ed. São Paulo: Atheneu, 2011.

REY, L. **Bases da parasitologia médica**. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.

DE CARLI, G. A. **Diagnóstico laboratorial de parasitoses humanas**. Rio de Janeiro: MEDSI, 1994.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

VERONESI. **Doenças infecciosas e parasitárias**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1995.

NEVES, D. P. **Atlas didático de parasitologia**. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2008.

AMATO NETO, V. et al. **Parasitologia**: uma abordagem clinica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

FILIPPIS, T.; NEVES, D. P. **Parasitologia básica**. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2013.

ROCHA, A. **Parasitologia**. São Paulo: Rideel, 2013.

4. HISTÓRIA E INTRODUÇÃO À ENFERMAGEM (60h)

EMENTA: Evolução da prática de enfermagem no contexto histórico, político e social. Teorias de Enfermagem e sistematização da assistência de Enfermagem, baseada em pressupostos teóricos. Mostra os diversos órgãos que respaldam a legalidade e contribuem para o desenvolvimento científico da enfermagem.

OBJETIVOS: Possibilitar ao acadêmico um processo crítico e reflexivo sobre a Enfermagem desde os seus primórdios até o seu desenvolvimento como profissão, num contexto político,

socioeconômico e cultural; Reconhecer as teorias de enfermagem como elemento importante para a prática de enfermagem; Conhecer os pressupostos teóricos de Wanda Horta e a teoria das necessidades humanas básicas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

GEOVANINI, T. et al. **História da enfermagem**: versões e interpretações. 3. ed. Rio de Janeiro: REVINTER, 2010.

OGUISSO, T. **Trajetória histórica e legal da enfermagem**. 2. ed. Bauberi-SP: Manole, 2007.

PORTO, F.; AMORIM, W. **História da enfermagem brasileira**: lutas, ritos e emblemas. 2. ed. São Caetano do Sul-SP: Yendis Editora, 2013.

CARRARO, T. **Enfermagem e assistência**: resgatando Florence Nighingale. Goiânia: AB Editora, 1997.

GEORGE, J. B. **Teorias de enfermagem**: os fundamentos à prática profissional. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000.

HORTA, W. A. **Processo de enfermagem**. São Paulo: EPU, 1979.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GONZALES, R. M.; BECK, C. C.; DENARDIN, M. de L. **Cenários de cuidado**: aplicação de teorias de enfermagem. Santa Maria: Pallotti, 1999.

LEOPARDI, M. T. **Teorias de enfermagem**: instrumentos para a prática. Florianópolis: Papa Livros, 1999.

ALFARO-LEFEVRE, R. **Aplicação do processo de enfermagem**: um guia passo a passo. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000.

WALDOW, V. R. **Cuidar**: expressão humanizadora da enfermagem. 3. ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2010.

BOFF, L. **O cuidado necessário**: na vida, na saúde, na educação, na ecologia, na ética e na espiritualidade. Petrópolis-RJ: Vozes, 2012.

LOPES, L. M. M.; SANTOS, S. M. P. Florence Nightingale – apontamentos sobre a fundadora da enfermagem moderna. **Revista de Enfermagem Referência**, III Série, n. 2, dez. 2010.

PIRES, D. A enfermagem enquanto disciplina, profissão e trabalho. **Rev. Bras. Enferm.**, v. 62, n. 5, p. 739-744, 2009.

WALDOW, V. R. Atualização do cuidar. **Aquichan Chía**, Colombia, v. 8, n. 1, p. 85-96, abr. 2008.

5. INFORMÁTICA APLICADA À SAÚDE (40h)

EMENTA: Microinformática básica. Conhecimentos de sistemas operacionais. Ambiente de operação e interfaces com o usuário. Conhecimentos de editor de texto, planilha eletrônica e software de apresentação (textos, gráficos, tabelas, áudios, vídeos e imagens). Internet: fundamentos da rede mundial, pesquisa, comunicação, elaboração e publicação em ambiente de internet. Utilização da rede mundial de computadores. Acesso a ambientes virtuais de aprendizagem.

OBJETIVOS: Instrumentalizar o aluno na aquisição do conhecimento básico necessário para a utilização de informática no contexto da saúde. Fornecer subsídios para a utilização da informática em projetos e pesquisas voltados a área da saúde. Operar as ferramentas básicas de informática de forma a poder utilizá-las interdisciplinarmente, de modo crítico, criativo e pró-ativo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ANTONIO, J. **Informática para concursos**: teoria e questões. Rio de Janeiro: Campus-Elsevier, 2009.

CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. **Introdução à informática**. 8. ed. São Paulo: PearsonPrentice Hall, 2004.

NORTON, P. **Introdução à informática**. 1. ed. Rio de Janeiro: Makron Books, 2005. 640p.

VELLOSO, F. de C. **Informática**: conceitos básicos. 8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2011.

FEDELI, R. D.; POLLONI, E. G. P.; PERES, F. E. **Introdução à ciência da computação**. 2. ed. São Paulo: CENGAGE Learning, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

HILL, B. M.; BACON, J. **O livro oficial do Ubuntu**. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.

LANCHARRO, E. A.; LOPEZ, M. G.; FERNANDEZ, S. P. **Informática básica**. São Paulo: Pearson Makron Books, 2004.

MANZANO, A. L. N. G.; TAKA, C. E. M. **Estudo dirigido de MicrosoftWindows 7 Ultimate**. São Paulo: Érica, 2010.

MANZANO, A. L. N. G.; MANZANO, M. I. N. G. **Estudo dirigido de informática básica**. 7. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Érica, 2007.

MONTEIRO, M. A. **Introdução à organização de computadores**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

OLIVEIRA, R. **Informática educativa**. 12. ed. Campinas: Papirus, 2007.

6. ENFERMAGEM, EDUCAÇÃO E SAÚDE (20h)

EMENTA: Concepção de educação, saúde, sociedade, e cidadania, a partir das perspectivas educacionais existentes na saúde e na enfermagem. A educação em saúde no processo de trabalho como geradora de um ser saudável e comprometido com o autocuidado individual e coletivo.

OBJETIVOS: Problematizar a realidade da educação e saúde nos dias atuais como forma de entender, interagir e comprometer-se com a vida e o viver em comunidade; Proporcionar um ambiente de troca de conhecimentos acerca da educação e saúde na comunidade como forma de manutenção de um viver saudável; Refletir o processo de educação popular desde a infância até a fase adulta; Discutir a saúde popular e os mitos relacionados ao diagnóstico, tratamento e reabilitação e a reinserção social após a doença; Refletir sobre o processo de saúde no Brasil e sua dimensão social nas práticas de saúde; Analisar a saúde como problema complexo, como produção social, não simplesmente como evento biológico, combatendo-a e promovendo a vida com qualidade; Refletir sobre o processo de trabalho como processos de aprendizagem, enunciando situações e necessidades de ordem pedagógica; Refletir a produção do conhecimento para a mudança das práticas em saúde, bem como a educação popular para a gestão das políticas públicas de saúde.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ANDREOLA, B. **A Dinâmica de grupo**: jogo da vida didática do futuro. 28. ed. Petrópolis: Vozes, 2011.

DEMO, P. **Conhecimento moderno**: sobre ética e intervenção do conhecimento. Petrópolis: Vozes, 1997.

FREIRE, P. **Educação e mudança**. 34. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.

_____. **Pedagogia do oprimido**. 45. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.

_____. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários a prática educativa. 43. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.

GADOTTI, M. **Perspectivas atuais da educação**. Porto Alegre: Artmed, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BORDENAVE, J.; PEREIRA, A. M. **Estratégias de ensino e aprendizagem**. 20. ed. Petrópolis: Vozes, 1999.

CANDAU, V. M. et al. **Tecendo a cidadania**: oficinas pedagógicas de direitos humanos. Petrópolis, RJ: Vozes, 1996.

CAPONI, S. et al. **A saúde em questão**: um espaço para a reflexão. Florianópolis: Dos Autores, 1999.

LEOPARDI, M. T. **O Processo de trabalho em saúde**: organização e subjetividade. Florianópolis: Papa Livros, 1999.

VALLA, V. V. et al. 2. ed. **Educação, saúde e cidadania**. Petrópolis: Vozes, 1996.

7. FUNDAMENTOS E PRÁTICAS DO CUIDADO ENFERMAGEM I – 60h

EMENTA: Estudo teórico-prático em laboratório e na comunidade a partir dos princípios científicos que envolvem as técnicas básicas de enfermagem.

OBJETIVOS: Possibilitar ao aluno espaço para reflexão quanto às suas expectativas relacionadas ao curso de graduação em enfermagem e à inserção na Universidade facilitando o enfrentamento desse momento de inserção no cotidiano universitário; Introduzir conceitos relacionados ao cuidar/cuidado, às bases para o cuidado de enfermagem e os fundamentos do cuidado humano: conhecimento, relações humanas, necessidades humanas básicas e cidadania. Proporcionar ao aluno conhecimento científico sobre Fundamento e prática do cuidado. Possibilitar ao acadêmico conhecimento e habilidades para realização do exame físico; Criar condições para o aluno praticar e tornar-se hábil na execução das técnicas de menor e maior complexidade, por meio de aulas teórico-práticas em laboratório e na comunidade.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

POTTER, P. A.; PERRY, A. G. **Fundamentos de enfermagem**. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.

TANNURE, M. C.; PINHEIRO, A. M. **SAE**: sistematização da assistência de enfermagem – guia prático. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.

BARROS, A. L. B. L. et al. **Anamnese e exame físico**: avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

KAZANOWSKI, M. K. **Procedimentos e protocolos de enfermagem**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

SMELTZER, S. C. et al. **Brunner e Suddarth**: tratado de enfermagem médico-cirúrgica - 2 volumes. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

KAWAMOTO, E. M. **Fundamentos de enfermagem**. 2. ed. São Paulo: EPU, 1997.

NETTINA, S. M. **Prática de enfermagem**. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

CHAVES, L. C.; PASSOS, M. B. S. **Avaliação física em enfermagem**. São Paulo: Atheneu, 2012.

SOUZA, V. H. S.; MOZACHI, N. **O hospital**: manual do ambiente hospitalar. 2. ed. Curutiba: Os autores, 2005.

PORTO, C. C.; PORTO, A. L. **Exame clínico**. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

8. INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTIFICA (40h)

EMENTA: Preparar os discentes para desenvolver suas habilidades de pesquisa, escrita, análise e discussão de temas científicos e apresentá-los em forma de trabalhos (monografia, artigo, TCC), seguindo as normatizações acadêmicas; Normas Técnicas – ABNT.

OBJETIVOS: Fornecer subsídios para a elaboração de trabalhos discentes, instrumentalizar o discente para a utilização de bases de dados e para elaboração de currículo profissional, respeitando os princípios éticos da pesquisa.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

SEVERINO, A. J. **Metodologia do trabalho científico**. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2006.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

VIEIRA, S.; HOSSNE, W. S. **Metodologia científica para a área da saúde**. Rio de Janeiro: Campus, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ECO, H. **Como se faz uma tese**. 25. ed. Rio de Janeiro: Perspectiva, 2010.

MEDEIROS, J. B. **Redação científica**: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

DALBERIO, O. **Metodologia científica**: construção e apresentação de trabalhos acadêmicos, científicos e de projeto de pesquisa. 3. ed. Uberaba-MG: Vitória, 2004.

FREIXO, M. J. V. **Metodologia científica**: fundamentos métodos e técnicas. São Paulo: Piaget, 2009.

9. SAÚDE INDÍGENA – OPTATIVA (40h)

EMENTA: Estudo sobre a atenção integral à saúde das populações indígenas abordando dados históricos, demográficos e epidemiológicos das populações indígenas do Brasil e da região Norte. Preparar os discentes para desenvolver habilidades interculturais para o atendimento da população indígena no subsistema de Saúde Indígena e nos demais âmbitos do SUS.

OBJETIVOS: Desencadear um processo crítico e reflexivo sobre as condições de saúde dos povos indígenas no Brasil; conhecer e discutir os elementos estruturantes da política nacional de saúde para os povos indígenas; Estudar o perfil epidemiológico das populações indígenas no contexto étnico, demográfico e social. Descrever a estrutura do subsistema de saúde indígena, com ênfase no estado de RO, capacitando discentes do Curso de Graduação em Enfermagem para inserção neste campo de trabalho em saúde.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ATHIAS, R.; MACHADO, M. A saúde indígena no processo de implantação dos distritos sanitários: discursos antropológicos e médicos. **Cadernos de saúde pública**, Rio de Janeiro, v. 17, n. 2, p. 425-431, 2001.

BRASIL. **Lei nº 9.836/99, de 23 de setembro de 1999**. Estabelece o subsistema de atenção à saúde indígena no âmbito do SUS. Diário Oficial da União, Seção 1, p. 1, Brasília, DF, 24 set. 1999.

BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. **Política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas**. 2. ed. Brasília, DF, 2002.

COIMBRA JUNIOR, C. E. A.; SANTOS, R. V.; ESCOBAR A. L. **Epidemiologia e saúde dos povos indígenas no Brasil**. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

COIMBRA JUNIOR, C. E. A.; SANTOS, R. V.; ESCOBAR A. L. **Epidemiologia e saúde dos povos indígenas no Brasil**. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2003.

PEREIRA, P. P. S. et al. Política de Atenção a Integral a Saúde Mental das Populações Indígenas de Porto Velho/RO: a voz das lideranças. **Revista tempus actas de saúde coletiva**, v. 7 n.4, 2013.

SOUZA, M. C.; SCATENA, J. H., SANTOS, R. V. O Sistema de informação da atenção à saúde indígena (SIASI): criação, estrutura e funcionamento. **Cadernos de saúde pública**, v. 23, n. 4, p. 853-861, abr., 2007.

TEIXEIRA, C. C. Fundação Nacional de saúde. A política brasileira de saúde indígena vista através de um museu. **Etnográfica,** v. 12, n. 2, p. 323-351, nov. 2008.

GARNELO, L. **Saúde indígena:** uma introdução ao tema. Brasília: MEC-SECADI. 2012.

10. PRÁTICA INTEGRATIVA EM ENFERMAGEM I (80h)

EMENTA: Promove a integração teórico-prática e prática entre conteúdos de História e Introdução à Enfermagem, Enfermagem, Educação e Saúde e Fundamentos e práticas para o cuidado de Enfermagem I buscando identificar elementos relevantes a formação do enfermeiro.

OBJETIVOS: Apresentar conceitos básicos relacionados ao cuidar em enfermagem e à educação em saúde. Possibilitar aos acadêmicos de enfermagem uma visão global e integrada dos conteúdos e conhecimentos adquiridos no semestre. Contribuir para o desenvolvimento da capacidade crítica e reflexiva do aluno articulando os saberes científicos. Oportunizar o estudo teórico-prático e prático de temas que envolvam as vivências da Enfermagem.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ANDREOLA, B. **A**. **Dinâmica de grupo**: jogo da vida didática do futuro. 28. ed. Petrópolis: Vozes, 2011.

FREIRE, P. **Educação e mudança**. 34. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.

_____. **Pedagogia do oprimido**. 45. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.

GEORGE, J. B. **Teorias de enfermagem**: os fundamentos à prática profissional. 4. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.

GONZALES, R. M.; BECK, C. C.; DENARDIN, M. de L. **Cenários de cuidado**: aplicação de teorias de enfermagem. Santa Maria: Pallotti, 1999.

POTTER, P. A.; PERRY, A. G. **Fundamentos de enfermagem**. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.

TANNURE, M. C.; PINHEIRO, A. M. **SAE**: sistematização da assistência de enfermagem – guia prático. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.

BARROS, A. L. B. L. et al. **Anamnese e exame físico**: avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

KAZANOWSKI, M. K. **Procedimentos e protocolos de enfermagem**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.

NETTINA, S. M. **Prática de enfermagem**. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CARRARO, T. **Enfermagem e assistência**: resgatando Florence Nighingale. Goiânia: AB Editora, 1997.

HORTA, W. de A. **Processo de enfermagem**. São Paulo: EPU, 1979.

DEMO, P. **Conhecimento moderno**: sobre ética e intervenção do conhecimento. Petrópolis: Vozes, 1997.

PASSOS, M. B. S. **Semiologia e semiotécnica de enfermagem**. São Paulo: Atheneu, 2005.

CHAVES, L. C.; PASSOS, M. B. S. **Avaliação física em enfermagem**. São Paulo: Atheneu, 2012.

III PERÍODO

1. FARMACOLOGIA (80h)

EMENTA: Farmacologia, conceitos, situações especiais, tratamento dos distúrbios metabólicos, uso de analgésicos e anti-inflamatórios, fármacos e aparelho digestivo, uso de drogas em cardiologia, fármacos utilizados em pneumologia, antibióticos, drogas utilizadas em psiquiatria.

OBJETIVOS: Conhecimento dos fármacos utilizados no sistema público e privado de saúde, suas indicações e efeitos colaterais; Formar profissionais de enfermagem capazes de reconhecer as drogas mais utilizadas no sistema público de saúde, bem como no sistema privado e suas indicações; Reconhecer situações especiais para o uso de fármacos como gestação, idosos, crianças, entendendo e adequando os cuidados; Proporcionar aos alunos o conhecimento dos efeitos colaterais dos medicamentos permitindo uma atuação imediata e qualificada desse profissional em casos de possíveis intoxicações; Propiciar aos alunos do Curso de Graduação em Enfermagem, a conscientização da problemática da questão do uso indiscriminado de medicamentos e suas repercussões na saúde pública.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

FUCHS, F. D.; WANNMACHER, L. **Farmacologia clínica**: fundamentos da terapêutica racional. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.

LIMA, D. R. **Manual de farmacologia clínica, terapêutica e toxicologia**. São Paulo: Guanabara Koogan, 2002.

ZANINI, A. C.; OGA, S. **Farmacologia aplicada**. 5. ed. São Paulo: Livraria Atheneu, 1994.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

SOARES, N. R. C. G. **Administração de medicamentos na enfermagem**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

BARRETO, A. C. P. et al. **Manual de hipertensão**. São Paulo: Lemos Editorial, 2002.

JACOB FILHO, W. **Terapêutica do idoso**. São Paulo: Fundo Editorial BY, 2003.

MAGALHÃES, A. F. N. **Dispepsias e gastrites**. São Paulo: Lemos Editorial, 2002.

RANG, H. P. et al. **Farmacologia**. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

2. PROCESSOS PATOLÓGICOS (60h)

EMENTA: Oportunizar ao acadêmico subsídios e conhecimentos gerais sobre a origem das patologias humanas, as suas principais modificações funcionais, clínicas e morfológicas no organismo humano, com uma visão holística, preparando o aluno para a boa prática da profissão na área das ciências da saúde.

OBJETIVOS: Capacitar o aluno para a identificação de processos patológicos gerais, com vistas à compreensão da fisiopatologia das doenças mais prevalentes na população rondoniense e Brasileira.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BRASILEIRO FILHO, G. **Bogliolo patologia geral**. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

CONTRAN, R. S.; KUMAR, V. M. D.; COLLINS, T. **Robbins patologia geral e funcional**. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.

MONTENEGRO, M. R.; FRANCO, M. **Patologia:** processos gerais. 5. ed. São Paulo: Atheneu, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

KIERSZENBAUM, A. L. **Histologia e biologia:** uma introdução à patologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

KING, T. C. **Patologia.** Rio de Janeiro: Elsevier. 2007.

GEORGE, L. L. **Histologia comparada**. 2. ed. São Paulo: Roca, 1998.

HAM, A. **Histologia**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1985.

HOSS, M. H.; WOJCIECH, P. **Histologia**: texto e atlas. 6. ed. São Paulo: Panamericana, 2012.

3. MICROBIOLOGIA/IMUNOLOGIA (80h)

EMENTA: A disciplina de Microbiologia e Imunologia aborda as características imunológicas e patogenicidade das bactérias e vírus. O crescimento, a sobrevida e a morte de microrganismos e bacteriologia. Introdução ao estudo da imunologia básica. Anatomia do sistema imune. Antígeno. Anticorpo. Resposta imune inespecífica e resposta específica. Sistema complemento. Hipersensibilidade. Imunodeficiência.

OBJETIVOS: Caracterizar os principais grupos de microorganismos de importância médica e sanitária; Fornecer os fundamentos básicos da microbiologia aplicada às ciências da saúde; Descrever as principais técnicas laboratoriais utilizadas no Laboratório de Microbiologia. Proporcionar oportunidades para os acadêmicos, de compreensão do funcionamento do sistema imunológico humano, nas doenças e na saúde; Desenvolver a capacidade de interpretar resultados laboratoriais confrontando com a patologia do paciente.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H.; PILLAI, S. **Imunologia celular e molecular**. 7. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2010.

FERREIRA, A. W.; MORAIS, S. L. **Diagnóstica laboratorial das principais doenças infecciosas e autoimunes**. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.

FORTE, W. C. N. **Imunologia básica e aplicada**. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ALBERTS, B. et al**. Biologia molecular da célula**. 5. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2009.

ENGELKIRK, P. G.; ENGELKIRK-DUBEN, J. **Burton microbiologia para ciências da saúde**. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

STROHL, W. A.; ROUSE H.; FISHER, B. D. **Microbiologia ilustrada**. São Paulo: Artmed, 2004.

PELCZAR JUNIOR, M. J.; CHAN, E. C. S.; KRIEG, N. R. **Microbiologia**. 4. ed. São Paulo: Makron – Books, 2003.

TRABULSI, L. R. **Microbiologia médica**. 5. ed. São Paulo: Atheneu, 2008.

4. **FUNDAMENTOS E PRÁTICAS DO CUIDADO ENFERMAGEM II (60h)**

EMENTA: Estudo teórico e teórico-prático em laboratório e comunidade a partir dos princípios científicos que envolvem as técnicas de enfermagem de média complexidade.

OBJETIVOS: Proporcionar ao aluno conhecimento científico sobre Fundamentos e prática do cuidado de enfermagem II, com embasamento teórico e prático, fundamentados nos pressupostos da teoria de Horta, para desempenhar funções inerentes ao profissional de enfermagem; Capacitar o aluno por meio de fundamentação teórica e prática para a administração de medicamentos; Criar condições para o aluno praticar e tornar-se hábil na execução das técnicas de menor complexidade, por meio de aulas teóricas, teórico-práticas em laboratório e na comunidade.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

POTTER, P. A.; PERRY, A. G. **Fundamentos de enfermagem**. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.

NETTINA, S. M. **Prática de enfermagem**. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

SMELTZER, S. C. et al. **Brunner e Suddarth**: tratado de enfermagem médico-cirúrgica - 2 volumes. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

KAZANOWSKI, M. K. **Procedimentos e protocolos de enfermagem**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.

KAWAMOTO, E. M. **Fundamentos de enfermagem**. 2. ed. São Paulo: EPU, 1997.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

PASSOS, M. B. S. **Semiologia e semiotécnica de enfermagem**. São Paulo: Atheneu, 2005.

SOUZA, V. H. S.; MOZACHI, N. **O hospital**: manual do ambiente hospitalar. 2. ed. Curutiba: Os autores, 2005.

TANNURE, M. C.; PINHEIRO, A. M. **SAE**: sistematização da assistência de enfermagem – guia prático. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.

BARROS, A. L. B. L. et al. **Anamnese e exame físico**: avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

CHAVES, L. C.; PASSOS, M. B. S. **Avaliação física em enfermagem**. São Paulo: Atheneu, 2012.

5. MATEMÁTICA APLICADA À ENFERMAGEM (20h)

EMENTA: Estudo dos conteúdos: Operações com números decimais; Razão; Proporção; Regra de Três; Porcentagens; Sistema de Medidas; Diluição de Medicamentos; Preparo de soluções; Dosagem de Insulina e Heparina, Cálculo de Gotejamento em gotas, microgotas e bureta, Transformação de Soros, Cálculo de dosagens em pediatria, cálculo de equivalência de soluções.

OBJETIVOS: Desenvolver habilidades para execução de operações matemáticas para cálculos de dosagens de medicamentos; Reconhecer as operações matemáticas básicas, porcentagem, regra de três e sistema de medidas para cálculos de medicações; Conhecer as diferentes graduações de seringas; Conhecer os cálculos e diluições de medicamentos sólidos e líquidos; Aplicar as fórmulas de gotejamento de soluções injetáveis; Resolver situações da rotina hospitalar quanto à administração de medicamentos e suas diluições.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

SPRINGHOUSE CORPORATION. **Administração de medicamentos**: Série incrivelmente fácil. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.

SOUZA, D. C. **Enfermagem uma base de cálculo**. São Pulo: Legnar, 2003.

UTYAMA, I. K. A. et al. **Matemática aplicada à enfermagem**. São Paulo: Atheneu, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

GOLDENZWAIG, N. R. S. C. **Administração de medicamentos na enfermagem**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

SILVA, M. T.; SILVA, S. R. L. P. T. M. **Cálculo e administração de medicamentos na enfermagem**. 3. ed. São Paulo: Martinari, 2011.

GIOVANI, A. M. M.; **Enfermagem**: cálculo e administração de medicamentos. 11. ed. São Paulo: Scrinium, 2003.

_____. **Vamos calcular juntos**? Caderno de exercícios. São Paulo: Scrinium, 2004.

_____. **Medicamentos:** cálculo de dosagens. 2. ed. São Paulo: Scrinium, 2003.

6. LEGISLAÇÃO E ÉTICA EM ENFERMAGEM (20h)

EMENTA: Princípios e objetivos da Bioética. Estudo dos diversos aspectos da ética e deontologia de enfermagem, enfocando o compromisso e a postura profissional, as relações enfermeiro-paciente, a legislação aplicada ao exercício da enfermagem e as questões bioéticas. Reflexão sobre os aspectos éticos envolvidos nas questões relativas a privacidade, confidencialidade, aborto, eutanásia, problemas de início e final da vida, alocação de recursos, respeito à pessoa, tomada de decisões e pesquisas em seres humanos.

OBJETIVOS: Discutir a gênese, o desenvolvimento e o paradigma principialista da bioética: autonomia, justiça, beneficência e não maleficência; Refletir sobre as questões bioéticas no que diz respeito à saúde e a vida humana; Desenvolver a postura ética promovendo o aperfeiçoamento profissional e estimulando o aluno à reflexão ético-moral frente às questões que envolvem o exercício da enfermagem; Conhecer e analisar a legislação que rege o exercício profissional e os aspectos éticos da enfermagem.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

OGUISSO, T.; ZABOLI, E. L. C. P. **Ética e bioética**: desafios para a enfermagem e a saúde. São Paulo: Manole, 2006.

SILVA, G. B. **Análise crítica da enfermagem profissional**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1989.

GELAIN, I. **A ética, a bioética e os profissionais de enfermagem**. 4. ed. São Paulo: EPU, 2010.

PORTAL COFEN. **Legislações**. Disponível em <http://www.cofen.gov.br>.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

FORTES, P. A. C. **Ética e saúde**: questões éticas e deontológicas legais, autonomia e direitos do paciente - estudo de casos. São Paulo: EPU, 1998.

GARRAFA, V.; PESSINI, L. **Bioética, poder e injustiça**. São Paulo: Loyola, 2003.

HARADA, M. J. C. S. et al. **O erro humano e a segurança do paciente**. São Paulo: Atheneu, 2006.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012**. Brasília, 2012.

PESSINI, L; BARCHIFONTAINE, C. P. **Problemas atuais de bioética**. 7. ed. São Paulo: Loyola, 2005.

7. BASES TEORICAS DA GESTAO DE ENFERMAGEM EM SAUDE I: (40h)

EMENTA: Teorias Administrativas e sua aplicabilidade na Enfermagem. Terminologia Básica em Administração. Legislação para o Trabalho do Enfermeiro. Áreas de atuação e Mercado de Trabalho do Enfermeiro. Filosofia de Enfermagem. Processo de Trabalho do Enfermeiro. Processos de Intervenção em Enfermagem, visando iniciar a instrumentalização do aluno(a) para o exercício da função administrativa do enfermeiro(a) na unidade de trabalho.

OBJETIVOS: Espera-se que a unidade possibilite ao estudante identificar as principais teorias de administração e seu uso na Enfermagem; Entender a filosofia de enfermagem; Discorrer sobre os instrumentos de organização de Serviços de Enfermagem; Conhecer a legislação de enfermagem para suporte da prática; Entender o processo de trabalho do enfermeiro nas dimensões de ensino, pesquisa, assistência e administração; Conhecer as áreas de atuação do enfermeiro; e Reconhecer o planejamento e a tomada de decisão como ferramentas de intervenção do enfermeiro no gerenciamento da assistência de enfermagem.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ALMEIDA, M. C. P.; ROCHA, S. M. M. **O trabalho de enfermagem**. São Paulo: Cortez, 1997.

CARVALHO, I. A.; SANTOS, L. **Sistema único de saúde**: comentários à Lei Orgânica de Saúde. 4. ed. São Paulo: Hucitec, 2006.

CHIAVENATO, I. **Teoria geral da administração vol 1**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2014.

CHIAVENATO, I. **Teoria geral da administração vol 2**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR.

KURCGANT, P. **Gerenciamento em enfermagem**. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.

CHIAVENATO, I. **Introdução à teoria da administração**. 9. ed. São Paulo: Atlas. 2014.

CIANCIARULLO, T. **Teoria e prática em auditoria de cuidados**. São Paulo: Cone. 1997.

KURCGANT, P. et. al. **Administração em enfermagem**. São Paulo, EPU, 1991.

MAXIMIANO, A. C. A. **Introdução à administração**. São Paulo: Atlas, 2000

GIL, A. **Auditoria da qualidade**. São Paulo: Atlas. 1994.

8. LIBRAS – OPTATIVA (60h)

EMENTA: Introdução: aspectos clínicos, educacional e sócioantropológicos da surdez. A Língua de Sinais Brasileira – LIBRAS: características básicas da fonologia. Noções básicas de léxico, de morfologia e de sintaxe com apoio de recursos audiovisuais; Noções de variação. Prática de LIBRAS: desenvolver a expressão visual-espacial.

OBJETIVOS: Proporcionar uma inserção básica dos alunos nos aspectos culturais e linguísticos das pessoas surdas, enfatizando seu modo peculiar de comunicação. Pretende-se que esta discussão seja feita a partir do referencial teórico proposto, mas principalmente dos conhecimentos práticos adquiridos na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D. **Dicionário**: língua de sinais brasileira – LIBRAS. Vol. I e II. 2. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001.

STAINBACK, S. E.; STAINBACK, W. **Inclusão:** um guia para educadores. Porto Alegre: Artmed, 1999.

THOMA, A. S.; LOPES, M. C. **A invenção da surdez**: cultura, alteridade, identidade e diferença no campo da educação. 2. ed. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2005.

SÁ, Nídia R. Limeira de. **Cultura, poder e educação de surdos**. São Paulo: Paulinas, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MANTOAN, M. T. E. **A integração de pessoas com deficiência**: contribuições para uma reflexão sobre o tema. São Paulo: SENAC, 1997.

FELTRIN, A. E. **Inclusão social na escola**: quando a pedagogia se encontra com a diferença. São Paulo: Paulinas, 2004.

BRASIL. MEC. **Saberes e práticas da inclusão**: desenvolvendo competências para o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos surdos. SEEP/Brasília/DF, 2005.

SKLIAR, C. **A surdez**: um olhar sobre as diferenças. 3. ed. Porto Alegre: Mediação, 2005.

SÁ, N. R. L. **Cultura, poder e educação de surdos**. São Paulo: Paulinas, 2006.

9. INGLÊS INSTRUMENTAL (40h)

EMENTA: Estratégias de leitura. Técnicas de leituras. Estratégias de vocabulário.

OBJETIVOS: Trabalhar o ensino da Língua Inglesa buscando despertar o interesse por uma segunda Língua, através de leituras de textos direcionados ao respectivo curso. Além disso, proporcionar conhecimento na Língua Inglesa; valorizar o estudo de uma segunda Língua; incentivá-los a pesquisa para um estudo mais elevado na sua respectiva área.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ALLIANDRO, H. **Dicionário Escolar Inglês Português**. Ao livro Técnico, RJ 1995.

BERLITZ, CHARLES. **Inglês passo a passo**. Campina/SP: MARTINS FONTES, 2000.

GAIL, B. **Inglês para leigos**. São Paulo: ALTA BOOKS, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

MCKAY, S. L. **Teaching English as an International Language**. Oxford. 2002.

TAYLOR, J. **Gramática Delti da Língua Inglesa**. Ao Livro Técnico, RJ. 1995.

Schumacher, Cristina. **Pílulas de Inglês**. São Paulo: Editora campus.

SILVA, J. A. de C.; GARRIDO, M. L.; BARRETO, T. P. **Inglês Instrumental**: Leitura e Compreensão de Textos. Salvador: Centro Editorial e Didático, UFBA. 1994.

10. PRÁTICA INTEGRATIVA EM ENFERMAGEM II (100h)

EMENTA: Promove a integração teórico-prática e prática entre conteúdos Fundamentos e práticas para o cuidado de Enfermagem II, Matemática Aplicada à Enfermagem, Legislação e Ética em Enfermagem e Bases Teóricas da Gestão de Saúde e da Enfermagem nos Serviços de Saúde I buscando identificar elementos relevantes à formação do enfermeiro.

OBJETIVOS: Seminários integrados. Apresentar conceitos básicos relacionados ao cuidar e gerenciar em enfermagem. Possibilitar aos acadêmicos de enfermagem uma visão global e integrada dos conteúdos e conhecimentos adquiridos no semestre. Contribuir para o

desenvolvimento da capacidade crítica e reflexiva do aluno articulando os saberes científicos. Oportunizar o estudo teórico-prático e prático de temas que envolvam as vivências da Enfermagem.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

VIANA, D. L. **Boas práticas de enfermagem**. São Caetano do Sul, SP: Yedis Editora, 2010.

DOMANSKY, R. de C.; BORGES, E. L. Manual para prevenção de lesões de pele. Rio de Janeiro: Rubio, 2012.

PORTAL COFEN. **Legislações**. Disponível em <http://www.cofen.gov.br>.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012**. Brasília, 2012.

SPRINGHOUSE CORPORATION. **Administração de medicamentos**: Série incrivelmente fácil. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 364p.

ALMEIDA, M. C. P.; ROCHA, S. M. M. **O trabalho de enfermagem**. São Paulo: Cortez, 1997.

CHIAVENATO, I. **Teoria geral da administração vol 1**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2014.436p.

CHIAVENATO, I. **Teoria geral da administração vol 2**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2014.625p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

SMELTZER, S. C. et al. **Brunner e Suddarth**: tratado de enfermagem médico-cirúrgica - 2 volumes. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

OGUISSO, T.; ZABOLI, E. L. C. P. **Ética e bioética**: desafios para a enfermagem e a saúde. São Paulo: Manole, 2006.

GELAIN, I. **A ética, a bioética e os profissionais de enfermagem**. 4. ed. São Paulo: EPU, 2010. 113p. KAWAMOTO, E. M. **Fundamentos de enfermagem**. 2. ed. São Paulo: EPU, 1997.

NETTINA, S. M. **Prática de enfermagem**. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

KAZANOWSKI, M. K. **Procedimentos e protocolos de enfermagem**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.

POTTER, P. A.; PERRY, A. G. **Fundamentos de enfermagem**. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.

TANNURE, M. C.; PINHEIRO, A. M. **SAE**: sistematização da assistência de enfermagem – guia prático. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.

GUIMARÃES, M. C. **Feridas e curativos**: uma forma simples e prática de tratar. Rio de Janeiro: Rubio, 2011.

MALAGUTTI, W.; KAKIHARA, C; T;. **Curativo, estomias e dermatologia: uma abordagem multiprofissional**. São Paulo: Martinari, 2011.

IV PERÍODO

1. FUNDAMENTOS E PRÁTICAS PARA O CUIDADO DE ENFERMAGEM III (80h)

EMENTA: Estudo das técnicas complexas e especializadas do enfermeiro fundamentado nos princípios. Aula prática destas técnicas nas unidades hospitalares/ambulatoriais com ênfase à interdisciplinaridade.

OBJETIVOS: Proporcionar ao aluno conhecimento científico sobre fundamentos e prática do cuidado em enfermagem III, com embasamento teórico e prático na execução de técnicas específicas do enfermeiro; Capacitar o acadêmico prestar cuidados de enfermagem de acordo com as necessidades humanas básicas de forma crítica reflexiva; Refletir sobre os aspectos gerais que envolvem o cuidar em enfermagem; Criar condições para o aluno praticar habilidades técnicas de maior complexidade, específicas do profissional enfermeiro, através de aulas teórico-práticas no laboratório e práticas nas unidades hospitalares/ambulatoriais; Orientar o aluno para criar agilidade e destreza nos procedimentos de enfermagem, do mais simples ao mais complexo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

POTTER, P. A.; PERRY, A. G. **Fundamentos de enfermagem**. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.

TANNURE, M. C.; PINHEIRO, A. M. **SAE**: sistematização da assistência de enfermagem – guia prático. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.

BARROS, A. L. B. L. et al. **Anamnese e exame físico**: avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

KAZANOWSKI, M. K**. Procedimentos e protocolos de enfermagem**. Rio de Janeiro: Guanabara koogan, 2005.

SMELTZER, S. C. et al. **Brunner e Suddarth**: tratado de enfermagem médico-cirúrgica - 2 volumes. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

VIANA, D. L. **Boas práticas de enfermagem**. São Caetano do Sul-SP: Yedis Editora, 2010.

KAWAMOTO, Emilia M. **Fundamentos de enfermagem**. 2. ed. São Paulo: EPU, 1997.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

NETTINA, S. M. **Prática de enfermagem**. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

PASSOS, M. B. S. **Semiologia e semiotécnica de enfermagem**. São Paulo: Atheneu, 2005.

SOUZA, V. H. S.; MOZACHI, N. **O hospital**: manual do ambiente hospitalar. 2. ed. Curutiba: Os autores, 2005.

CHAVES, L. C.; PASSOS, M. B. S. **Avaliação física em enfermagem**. São Paulo: Atheneu, 2012.

PORTO, C. C.; PORTO, A. L. **Exame clínico**. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

2. PESQUISA EM SAÚDE E NA ENFERMAGEM (20h)

EMENTA: A ciência e a construção do saber em saúde e enfermagem. Os tipos de pesquisa. Projeto de pesquisa. Métodos de coleta de dados. Abordagens metodológicas. Aspectos éticos que envolvem a pesquisa em saúde. Relatório de pesquisa. Elaboração de trabalho de conclusão de curso e artigo científico.

OBJETIVOS: Fornecer elementos teóricos fundamentais sobre a produção em ciências, com foco no conhecimento e discernimento dos tipos de pesquisa científica, bem como no fornecimento de subsídios teóricos para a elaboração de um projeto de pesquisa.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

POLIT, D. F. BECK, C. T. **Fundamentos de pesquisa em enfermagem**: avaliação de evidências para a prática da enfermagem. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento:** pesquisa qualitativa em saúde. 12. ed. São Paulo: Hucitec, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

RUDIO, F. V. **Introdução ao projeto de pesquisa científica**. 34. ed. Petrópolis: Vozes, 2002.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MINAYO, M. C. S. Análise qualitativa: teoria, passos e fidedignidade. **Ciência e saúde coletiva**, v. 17, n. 3, p. 621-626, 2012.

DEMO, P. **Metodologia do Conhecimento Científico**. São Paulo: Atlas, 2000.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

3. BASES TEÓRICO-PRÁTCA DA GESTÃO DE SAÚDE E DA ENFERMAGEM NOS SERVIÇOS DE SAÚDE II (40h)

EMENTA: Esta disciplina propõe oferecer uma visão crítica e reflexiva do processo de trabalho do enfermeiro na unidade, possibilitando a utilização de meios para desenvolver ações para gerenciar os recursos para a prestação da assistência de enfermagem. Possibilita ainda que o aluno possa experimentar o papel gerencial do enfermeiro.

OBJETIVOS: Reconhecer a importância do processo de direção na administração da assistência de enfermagem numa unidade de trabalho; Conhecer as ferramentas para gerenciar os recursos físicos, materiais e humanos necessários para prestar assistência de enfermagem; Utilizar os instrumentos necessários para desenvolver as ações de enfermagem na unidade de trabalho, permitindo experenciar o papel gerencial do enfermeiro; Desenvolver a capacidade para o auto conhecimento, ao relacionamento interpessoal e intergrupal.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BRASIL. **Projeto de esclarecimentos assistenciais de saúde** – elaboração de projetos físicos. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ministério da Saúde/Departamento de Normas Técnicas: Brasília, 2002.

CHIAVENATO, I**. Recursos humanos**. 9. ed. São Paulo: Campus, 2009.

COLMAN, F. T. **Tudo o que o enfermeiro precisa saber sobre treinamento**: um manual prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MARQUIS, B. L.; HUSTON, C. J. **Administração e liderança em enfermagem**: teoria e aplicação. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

FERNANDES, L. O. **Princípios elementares de custos hospitalares**. São Paulo: CEDAS, 1993.

KURCGANT, P. et al. **Administração em enfermagem**. São Paulo: EPU, 1991.

BYHAN, W. C. Z. **O poder da energização**. Rio de Janeiro: Campus, 1992.

SILVA, M. J. P. **Comunicação tem remédio**: a documentação nas relações interpessoais em saúde. 5. ed. São Paulo: Gente, 1996.

4. **ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA II (20h)**

EMENTA: O enfermeiro na saúde coletiva. A Estratégia Saúde da Família e a abordagem familiar. O Programa Nacional de Imunização e as competências do enfermeiro na rede de frio e em sala de vacinas. HumanizaSUS: a humanização nas práticas e serviços de saúde.

OBJETIVOS: Desenvolver compreensão e habilidades fundamentais ao desenvolvimento de atividades de um profissional de saúde no contexto do Sistema Único de Saúde.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ANDRADE, S. M.; SOARES, D. A.; CORDONI JUNIOR, L. **Bases da saúde coletiva**. Londrina: Editora UEL, 2001.

CAMPOS, G. W. S. **Manual de práticas de atenção básica**: saúde ampliada e compartilhada. São Paulo: Hucitec, 2010.

PINHEIRO, R.; MATTOS, R. A. **Construção da integralidade**: cotidiano, saberes e práticas em saúde. Rio de Janeiro: UERJ/IMS/ABRASCO, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CIANCIARULLO, T. I. **Uma nova estratégia em foco**: o programa de saúde da família – identificando as suas características no cenário do SUS. São Paulo: Ícone, 2005.

MATUMOTO, S.; MISHIMA, S. M.; PINTO, I. C. Saúde Coletiva: um desafio para a enfermagem. **Cadernos de saúde pública**, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 233-241, 2001.

EGRY, E.Y.; FONSECA, R. M. G. S. A família, a visita domiciliária e a Enfermagem: revisitando o processo de trabalho da Enfermagem em Saúde Coletiva. **Revista da escola de enfermagem USP**, São Paulo, v. 34, n. 3, p. 233- 239, set. 2000.

DAVID, R. **Vacinas**: orientações práticas. São Paulo: Martinari, 2011.

DESLANDES, S. F. **Humanização dos cuidados em saúde**: conceitos, dilemas e práticas. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2006.

5. EPIDEMIOLOGIA (40h)

EMENTA: Aspectos gerais do processo de Saúde/Doença/Transmissão de Doenças. Fundamentos Teóricos/Prático de Epidemiologia e seus principais modelos de estudo. Noções básicas sobre vigilância epidemiológica/vigilância em saúde.

OBJETIVOS: Proporcionar conhecimentos relativos a epidemiologia, no que diz respeito ao estado de saúde em nível populacional e os fatores que sobre eles influem e sua historicidade; conhecer e aplicar os principais indicadores de saúde; Estudar aspectos gerais do processo Saúde/Doença, fundamentos teórico-práticos de epidemiologia e seus modelos. Fatores que determinam as condições de saúde da população e as doenças que mais acometem em todo o estágio evolutivo do ser; Proporcionar ao acadêmico o conhecimento e a compreensão do processo epidêmico e de vigilância epidemiológica das doenças infectocontagiosas, imunoprevíniveis, endêmicas, zoonoses e vigilância em saúde.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

FORATTINI, O. **Epidemiologia geral**. Porto Alegre: Artmed, 1996.

JEMES, J. F.; ELMORE, J. G.; KATZ, D. L. **Epidemiologia, bioestatística e medicina preventiva**. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.

PEREIRA, M. G. **Epidemiologia:** teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.

CURY, G. C. **Epidemiologia aplicada ao sistema único de saúde**. Belo Horizonte: Coopmed editora, 2005.

BENSENOR, I. M.; LOTUFO, P. A. **Epidemiologia:** abordagem prática. 2. ed. São Paulo: Sarvier, 2011.

MEDRONHO, R. A. et al**. Epidemiologia**. 2. ed. São Paulo: Editora Atheneu, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ROUQUARYOL, M. Z.; GURGEL, M. **Epidemiologia e saúde**. 7. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2013.

ALMEIDA FILHO, N; BARRETO, M. L. **Epidemiologia e saúde**: fundamentos, métodos, aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

AYRES, J. R. C. M. **Epidemiologia e emancipação**. São Paulo: Hucitec, 1995.

PASSOS, A. D. C.; FRANCISCO, L. J. **Fundamentos de epidemiologia**. 3. ed. São Paulo: Manole, 2010.

BRASIL. Ministério de Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde e Meio Ambiente. **Manual de controle de doenças sexualmente transmissíveis - DST**. Brasília: 2002.

6. PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÕES EM SAÚDE (20h)

EMENTA: Estudo dos aspectos relativos ao controle de infecção em estabelecimentos assistenciais de saúde e de interesse à saúde, com ênfase nas intervenções do enfermeiro como integrante da equipe de saúde. Possibilitar o conhecimento dos textos legais referentes ao controle de infecção. Desenvolver senso crítico frente a situações que são vivenciadas na prática, identificando a importância do tema para a segurança da assistência de enfermagem.

OBJETIVOS: Proporcionar subsídios teóricos aos alunos de forma a capacitá-los para atuar como profissionais controladores de infecção, reconhecendo problemas, planejando intervenções, avaliando e orientando as ações de controle de infecção relacionada à assistência a saúde.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Higienização das mãos em serviços de saúde**. Brasília: Anvisa, 2007.

_____. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Manual de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.

_____. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução - RDC nº 15.** Março, 2012.

APECIH. **Precauções e isolamento**. 2. ed. rev. amp. São Paulo, 2012.

_____. **Como instituir um programa de controle de infecção**. São Paulo, 2011.

GRAZIANO, K. U.; SILVA, A.; PSLTIKIDIS, E. M. **Enfermagem em centro de material e esterilização**. São Paulo, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

HINRICHSEN, S. L. **Biossegurança e controle de infecção**: risco sanitário hospitalar. Rio de Janeiro: Medsi, 2004.

HINRICHSEN, S. L. **Biossegurança e controle de infecções**. Guanabara Koorgan: Rio de Janeiro, 2004.

BRASIL. **Higiene, desinfecção ambiental e resíduos sólidos em serviços de saúde**. São Paulo, 2013.

_____. **Limpeza desinfecção e esterilização de artigos em serviços de saúde**. São Paulo, 2010.

_____. **Prevenção e controle de infecção associadas à assistência médica extra-hospitalar**: ambulatórios, serviços diagnósticos, assistência domiciliar e serviços de longa permanência. São Paulo, 2014.

7. ESTATÍSTICA APLICADA À SAÚDE (60h)

EMENTA: Noções básicas de Estatística. Séries e gráficos estatísticos. Distribuições de frequências. Medidas de tendência central. Medidas de dispersão. Medidas separatrizes. Análise de Assimetria. Noções de amostragem e inferência. Testes estatísticos.

OBJETIVO: Utilizar ferramentas da estatística descritiva para interpretar, analisar e sintetizar dados estatísticos com vistas à compreensão de contextos diversos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. **Estatística básica**. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

CRESPO, A. A. **Estatística fácil**. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

FONSECA, J. S.; MARTINS, G. A. **Curso de estatística**. 6. ed. 12. reimpr. São Paulo: Atlas, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BUSSAB, B. H.; BUSSAB, W. O. **Elementos de amostragem**. São Paulo: Blucher, 2005.

CARVALHO, S. **Estatística básica**: teoria e 150 questões. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

PINHEIRO, J. I. D. et al. **Estatística básica**: a arte de trabalhar com dados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

VIEIRA, S. **Introdução à bioestatística**. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

TRIOLA, M. F. **Introdução à estatística**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

8. PRÁTICA INTEGRATIVA EM ENFERMAGEM III (200h)

EMENTA: Promove a integração teórico-prática e prática entre conteúdos Fundamentos e práticas para o cuidado de Enfermagem III, Bases Teórico-prática da Gestão de Saúde e da Enfermagem nos Serviços de Saúde II, Enfermagem em Saúde Coletiva II, Epidemiologia, Pesquisa em Saúde e na Enfermagem e Prevenção e Controle de infecções relacionadas à assistência à saúde buscando identificar elementos relevantes à formação do enfermeiro.

OBJETIVOS: Seminários integrados. Apresentar conceitos básicos relacionados ao cuidar e gerenciar em enfermagem Possibilitar aos acadêmicos de enfermagem uma visão global e integrada dos conteúdos e conhecimentos adquiridos no semestre. Contribuir para o desenvolvimento da capacidade crítica e reflexiva do aluno articulando os saberes científicos. Oportunizar o estudo teórico-prático e prático de temas que envolvam as vivências da Enfermagem.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ANDRADE, S. M.; SOARES, T.; CORDONI JUNIOR, L. **Bases da saúde coletiva**. Londrina: UEL, 2001.

CAMPOS, G. W. S. **Manual de práticas de atenção básica**: saúde ampliada e compartilhada. São Paulo: Hucitec, 2010.

DAVID, R. Vacinas: **orientações práticas**. São Paulo: Martinari, 2011.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Higienização das mãos em serviços de saúde**. Brasília: Anvisa, 2007.

_____. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Manual de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.

_____. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária**. Resolução - RDC nº 15**. Março, 2012.

MEDRONHO, R. A. et al. **Epidemiologia**. 2. ed. São Paulo: Editora Atheneu, 2008.

CHIAVENATO, I. **Recursos humanos**. 9. ed. São Paulo: Campus, 2009.

POLIT, D. F. BECK, C. T. **Fundamentos de pesquisa em enfermagem**: avaliação de evidências para a prática da enfermagem. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

CHIAVENATO, I. **Recursos humanos**. 9. ed. São Paulo: Campus, 2009.

DESLANDES, S. F. **Humanização dos cuidados em saúde**: conceitos, dilemas e práticas. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2006.

PEREIRA, M. G. **Epidemiologia**: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.

POTTER, P. A.; PERRY, A. G. **Fundamentos de enfermagem**. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.

TANNURE, M. C.; PINHEIRO, A. M. **SAE**: sistematização da assistência de enfermagem – guia prático. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.

BARROS, A. L. B. L. et al. **Anamnese e exame físico**: avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

KAZANOWSKI, M. K. **Procedimentos e protocolos de enfermagem**. Rio de Janeiro:Guanabara koogan, 2005.

SMELTZER, S. C. et al. **Brunner e Suddarth**: tratado de enfermagem médico-cirúrgica - 2 volumes. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

VIANA, D. L. **Boas práticas de enfermagem**. São Caetano do Sul, SP: Yedis Editora, 2010.

KAWAMOTO, E. M. **Fundamentos de enfermagem**. 2. ed. São Paulo: EPU, 1997.

HINRICHSEN, S. L. **Biossegurança e controle de infecção**: risco sanitário hospitalar. Rio de Janeiro: Medsi, 2004.

V PERÍODO

1. ENFERMAGEM NA ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO I: ABORDAGEM CLÍNICA (60h)

EMENTA: Assistência de Enfermagem sistematizada em nível individual e coletivo prestado ao adulto considerando as ações distribuídas nos níveis primário, secundário e terciário de atenção à saúde em todo o processo saúde-doença nos diversos serviços de saúde. Cuidado de enfermagem ao indivíduo acometido por doenças não infecciosas agudas e crônico-degenerativas; infecciosas agudas e crônicas. Contextualização das questões éticas e de cidadania relativas aos cuidados do homem, da família e da comunidade.

OBJETIVOS: Proporcionar conhecimentos teóricos que possibilitem ao acadêmico assistir o indivíduo portador de afecções clínicas e sua família nos níveis primário, secundário e terciário, a partir de uma abordagem técnico-humanística; Desenvolver competências para o processo de cuidar do adulto implementando a metodologia do processo de enfermagem; Reconhecer referenciais que oportunizem o entendimento dos determinantes envolvidos no adoecimento do indivíduo adulto, reconhecendo a importância das fases do ciclo vital.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

POTTER, P. A.; PERRY, A. G. **Fundamentos de enfermagem**. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.

CARPENITO, L. J. **Manual de diagnóstico de enfermagem**. 13. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.

COTRAN, R. S.; KUMAR, V.; COLLINS, T. R. **Patologia funcional e estrutural**. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.

SMELTZER, S. C. et al. **Brunner e Suddarth**: tratado de enfermagem médico-cirúrgica - 2 volumes. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BARROS, A. L. B. L. et al. **Anamnese e exame físico**: avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

NORTH AMERICAN NURSING ASSOCIATION. **Diagnósticos de enfermagem da NANDA:** definições e classificação 2012-2014. Porto Alegre: Artmed, 2012.

TANNURE, M. C.; PINHEIRO, A. M. **SAE**: sistematização da assistência de enfermagem – guia prático. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.

PORTO, C. C.; PORTO, A. L. **Exame clínico**. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

PORTO, C. C. **Semiologia médica**. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.

POSSO, M. B. S. **Semiologia e semiotécnica de enfermagem**. São Paulo: Atheneu, 2005.

POTTER, P. A.; PERRY, A. G. **Grande tratado de enfermagem prática**: clínica e prática hospitalar. 3. ed. São Paulo: Santos, 1998.

2. ENFERMAGEM NA ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO II: ABORDAGEM CIRÚRGICA (80h)

EMENTA: Assistência de enfermagem ao paciente em tratamento cirúrgico, nos procedimentos pré, trans e pós, fundamentado no conhecimento teórico-prático voltado às questões éticas e legais, ao atendimento humanizado e sistematizado, às técnicas e procedimentos específicos executados e a integração da equipe multiprofissional; direciona o aluno para o reconhecimento, planejamento, organização e assistência na unidade de centro cirúrgico e recuperação pós-anestésica e Central de Materiais e Esterilização.

OBJETIVOS: Realizar assistência de enfermagem à pacientes internados em unidades cirúrgicas, centros cirúrgicos e unidades de terapia intensiva, a luz dos conteúdos teóricos desenvolvidos na disciplina de Enfermagem nos Cuidados Cirúrgicos; Prestar cuidados de

enfermagem com a utilização de técnicas especializadas no atendimento das necessidades humanas básicas afetadas ao indivíduo e sua família no período pré, trans e pós-cirúrgicos; Proporcionar ao acadêmico o manuseio de equipamentos de tecnologia com maior complexidade.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

SMELTZER, S. C. et al. **Brunner e Suddarth**: tratado de enfermagem médico-cirúrgica - 2 volumes. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

MEEKER, M.; ROTHROCK, J. C. **Cuidados de enfermagem ao paciente cirúrgico**. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogam, 2011.

AUN, F.; BEVILACQUA, R. G. **Manual de cirurgia**. São Paulo: EPU, 1995.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BOGOSSIAN, L. **Manual prático de pré e pós-operatório**. 2. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 1995.

PETROIANU, A.; MIRANDA, M. E.; OLIVEIRA, R. G. **Blackbook cirurgia**. Belo Horizonte: Blackbook Editora, 2008.

ARAÚJO, M. J. B. **Ações de enfermagem em clínica cirúrgica**. 2. ed. Rio de Janeiro, 1993.

CORRÊA NETO, A. **Clínica cirúrgica**. 4. ed. São Paulo: Sarvier, 1994.

SANDS, J. K.; DENNISON, P. E. **Manual clínico de enfermagem médico-cirúrgica** – Conceitos e Prática Clínica. 3. ed. Lisboa: Lusodidacta, 1996.

3. ENFERMAGEM NO PROCESSO DE CUIDAR EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (60h)

EMENTA: Intervenções de enfermagem e ações de alta complexidade na assistência a pacientes que apresentam agravos à saúde caracterizados por risco de morte iminente ou relativo, nas situações de urgência/emergência, pacientes críticos que exigem do profissional enfermeiro cuidados intensivos e a tomada de decisão para a determinação das prioridades de cuidados.

OBJETIVOS: Prestar assistência de enfermagem voltada às prioridades do paciente adulto em situação de urgência/emergência. Proporcionar subsídios teóricos para atuação no campo do gerenciamento da assistência ao paciente crítico em risco de morte, enfocando aspectos referentes às áreas organizacional, gerencial e clínica. Possibilitar aos acadêmicos de

enfermagem uma visão global e integrada dos conteúdos e conhecimentos adquiridos, contribuindo para o desenvolvimento da capacidade crítica e reflexiva frente aos desafios de cuidar o paciente em situação de urgência/emergência. Identificar os sinais e sintomas que caracterizam a condição de urgência/emergência do paciente no processo saúde-doença. Estabelecer prioridades de ações de enfermagem frente ao paciente em situação de urgência/ emergência e desenvolver habilidades necessárias para o atendimento para o seu atendimento. Operacionalizar a assistência ao paciente em situação de urgência/emergência aplicando princípios sistematizados de atendimento (ATLS/ACLS). Desenvolver habilidades necessárias do Acolhimento com classificação de risco.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

TASHIRO, M. T. O.; MURAYAMA, S. P. G. **Assistência de enfermagem em ortopedia e traumatologia**. Rio de Janeiro: Atheneu, 2001.

SANTOS, N. C. M. **Urgência e emergência para enfermagem**: do atendimento pré-hospitalar (APH) à sala de emergência. 4. rev. e ampl. São Paulo: Érica, 2007.

BAIRD, M. S.; BETHEL, S. **Manual de enfermagem no cuidado crítico**: intervenções de enfermagem e condutas colaborativas. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

AMERICAN HEART ASSOCIATION. **Destaques das diretrizes da American Heart Association 2010 para RCP e ACE**, 2010.

BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Política nacional de humanização – PNH**: acolhimento com classificação de risco nos sistemas de urgência do SUS. Brasília, 2004.

SWEARINGEN, P. L.; KEEN, J. H. **Manual de enfermagem no cuidado crítico**: intervenções em enfermagem e problemas colaborativos. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.

VIANA, A. P. P. et al. **Enfermagem em terapia intensiva**: práticas e vivências. Porto Alegre: Artmed, 2011.

KNOBEL, E. **Terapia intensiva**: enfermagem. São Paulo: Atheneu, 2005.

SANTOS, N. C. M. **Urgência e emergência para a enfermagem**. 4. ed. Edição. São Paulo: Erika, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

DICCINI, S.; WHITAKER, I. Y. Exame neurológico. In: BARROS, A. L. B. L. et al. **Anamnese e exame físico**: avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. Cap. 7, p. 163-169.

JERONIMO, R.; CHEREGATTI, A. **Técnicas de UTI**. 2. ed. São Paulo: Rideel, 2011.

CINTRA, E. A.; NISCHID, V. M.; NUNES, W. A. **Assistência de enfermagem ao paciente gravemente enfermo**. 2. ed. Atheneu, 2006.

KNOBEL, E. **Condutas no paciente grave**. 2. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 1998.

BURIHAN, E. **Emergências em cirurgia**. São Paulo: Sarvier, 1995.

AUN, F. **Terapia intensiva em enfermagem**. São Paulo: Atheneu, 2005.

SMELTZER, S. C. et al. **Brunner e Suddarth**: tratado de enfermagem médico-cirúrgica - 2 volumes. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

4. ENFERMAGEM E A SAÚDE DO TRABALHADOR (OPTATIVA) - 40h

EMENTA: Conhecimento sobre as relações entre o homem e o trabalho enfocando, particularmente, o impacto deste último sobre a saúde do indivíduo. Pretende-se instrumentalizar o graduando de enfermagem para prestar assistência à população trabalhadora usuária dos serviços de saúde a partir do fornecimento de noções básicas sobre os riscos presentes nos ambientes de trabalho, as medidas de controle que podem ser adotadas e os principais danos à saúde decorrentes de exposições ocupacionais.

OBJETIVOS: Ao final da disciplina o aluno deverá estar apto a entender a articulação entre o contexto econômico, as ações da sociedade civil, particularmente dos movimentos dos trabalhadores, as ações do Estado e as condições de saúde da população trabalhadora no Brasil. Conhecer o perfil de morbimortalidade da população trabalhadora. Discutir os principais riscos existentes nos ambientes de trabalho. Relacionar as medidas de caráter coletivo, individual e administrativo que podem ser adotadas para o controle dos riscos presentes nos ambientes de trabalho. Reconhecer sinais e sintomas das doenças profissionais mais prevalentes na população trabalhadora. Conhecer as principais legislações de proteção à saúde dos trabalhadores em vigor no Brasil.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

HAAG, G. S.; LOPES M. J.; SCHUCK, J. S. **A enfermagem e a saúde dos trabalhadores**. 2. ed. Goiânia: A B Editora, 2001.

ROGERS B. **Enfermagem do trabalho**: conceitos e prática. Portugal: LUSOCIENCIA – Edições Técnicas e Científicas Ltda., 1997.

FERREIRA JUNIOR, M. **Saúde no trabalho**: temas básicos para o profissional que cuida da saúde dos trabalhadores. São Paulo: Roca, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MENDES, R. **Patologia do trabalho – 2 volumes**. 3. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2013.

MACEDO, R. **Manual de higiene na indústria**. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2006.

BRASIl. **Normas regulamentadoras**. Disponível em: <http://www.tem.gov.br>.

OPPERMANN, C. M.; PIRES, L. C. **Manual de biossegurança para serviços de saúde**. Porto Alegre: PMPA/SMS/CGVS, 2003.

PONJETTO, G. **Mapa de riscos ambientais:** manual prático. São Paulo: LTR, 2002.

5. PRÁTICA INTEGRATIVA EM ENFERMAGEM IV (240h)

EMENTA: Promove a integração teórico-prática e prática entre conteúdos Enfermagem na Atenção à Saúde do Adulto I: abordagem clínica, enfermagem na Atenção à Saúde do Adulto II: abordagem cirúrgica e enfermagem no processo de cuidar em urgência e emergência buscando identificar elementos relevantes à formação do enfermeiro.

OBJETIVOS: Seminários integrados. Apresentar conceitos básicos relacionados ao cuidar e gerenciar em enfermagem. Possibilitar aos acadêmicos de enfermagem uma visão global e integrada dos conteúdos e conhecimentos adquiridos no semestre. Contribuir para o desenvolvimento da capacidade crítica e reflexiva do aluno articulando os saberes científicos. Oportunizar o estudo teórico-prático e prático de temas que envolvam as vivências da Enfermagem.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

SMELTZER, S. C. et al. **Brunner e Suddarth**: tratado de enfermagem médico-cirúrgica - 2 volumes. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

POTTER, P. A.; PERRY, A. G. **Fundamentos de enfermagem**. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.

AUN, F.; BEVILACQUA, R. G. **Manual de cirurgia**. São Paulo: EPU, 1995.

BOGOSSIAN, L. **Manual prático de pré e pós-operatório**. 2. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 1995.

ARAÚJO, M. J. B. **Ações de enfermagem em clínica cirúrgica**. 2. ed. Rio de Janeiro, 1993.

CORRÊA NETO, A. **Clínica cirúrgica**. 4. ed. São Paulo: Sarvier, 1994.

TASHIRO, M. T. O; MURAYAMA, S. P. G. **Assistência de enfermagem em ortopedia e traumatologia**. Rio de Janeiro: Atheneu, 2001.

AUN, F. **Terapia intensiva em enfermagem**. São Paulo: Atheneu, 2005.

SWEARINGEN, P. L.; KEEN, J. H. **Manual de enfermagem no cuidado crítico: intervenções em enfermagem e problemas colaborativos.** 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.

CINTRA, E. A.; NISCHID, V. M.; NUNES, W. A. **Assistência de enfermagem ao paciente gravemente enfermo**. 2. ed. Atheneu, 2006.

KNOBEL, Elias. **Terapia intensiva**: enfermagem. São Paulo: Atheneu, 2005.

SANTOS, N. C. M. **Urgência e emergência para a enfermagem**. 4. ed. Edição. São Paulo: Erika, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

MEEKER, M.; ROTHROCK, J. C. **Cuidados de enfermagem ao paciente cirúrgico**. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

BARROS, A. L. B. L. et al. **Anamnese e exame físico**: avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

TANNURE, M. C.; PINHEIRO, A. M. **SAE**: sistematização da assistência de enfermagem – guia prático. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.

NORTH AMERICAN NURSING ASSOCIATION. **Diagnósticos de enfermagem da NANDA:** definições e classificação 2012-2014. Porto Alegre: Artmed, 2012.

PETROIANU, A.; MIRANDA, M; E; OLIVEIRA, R. G. **Blackbook cirurgia**. Belo Horizonte: Blackbook Editora, 2008.736p.

DICCINI, S.; WHITAKER, I. Y. Exame neurológico. In: BARROS, A. L. B. L. et al. **Anamnese e exame físico**: avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. 2. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2010. Cap. 7, p. 163-169.

VIANA, A. P. P. et al. **Enfermagem em terapia intensiva**: práticas e vivências. Porto Alegre: Artmed, 2011.

JERONIMO, R.; CHEREGATTI, A. **Técnicas de UTI**. 2. ed. São Paulo: Rideel, 2011.

VI PERÍODO

1. ENFERMAGEM À SAÚDE DA MULHER I (40h)

EMENTA: Introdução às relações sociais de gênero, raça, etnia, e divisão sexual do trabalho. Suas determinações históricas, condicionamentos socioeconômicos e culturais. Reprodução, família e saúde. As políticas de saúde da mulher. A violência contra as mulheres, e modelos de atendimentos pelos profissionais de saúde.

OBJETIVOS: Desenvolver formação política ética e científica do graduando de enfermagem capacitando-o para compreender a saúde da mulher sob as diferentes perspectivas que envolvem os direitos humanos da mulher, assim como seu papel na sociedade. Espera que a unidade propicie aos estudantes compreender as relações da mulher, gênero e sociedade; Compreender as políticas públicas voltadas à saúde da mulher. Prestar assistência de enfermagem à mulher, tendo como foco promoção, prevenção, relacionados à vivência da sexualidade e direitos reprodutivos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BERQUÓ, E. **Sexo e vida**: panorama da saúde reprodutiva no Brasil. Campinas: Unicamp, 2003.

CORNWALL, A.; WELBOURN, A. **Direitos sexuais e reprodutivos**: experiências com abordagens participativas. Porto Alegre: Tomo, 2006.

MURARO, R. M. **Mulher, gênero e sociedade**. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Departamento de Saúde Reprodutiva e Pesquisa (SRP) da Organização Mundial da Saúde (OMS) e Escola Bloomberg de Saúde Pública/Centro de Programas de Comunicação (CPC) da Universidade Johns Hopkins, Projeto INFO. **Planejamento familiar**: um manual global para prestadores de serviços de saúde. Baltimore e Genebra: CPC e OMS, 2007. Disponível em: <http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9780978856304_por.pdf>.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Política nacional de atenção integral à saúde da mulher:** princípios e diretrizes. 1. ed. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

FERNANDES, R. A. Q.; NARCHI, N. Z. **Enfermagem e saúde da mulher**. 2. ed. Barueri-SP: Manole, 2013.

ALDRIGHI, J, M.; PETTA, C. A. **Anticoncepção**: aspectos contemporâneos. São Paulo: Atheneu, 2005.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Política de Saúde. **Violência intrafamiliar**: orientações para a prática em serviços. Manual técnico. Brasília-DF, 2001.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Manual dos comitês de mortalidade matern**a. 3. ed. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2007. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/comites_mortalidade_materna_3ed.pdf>.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Saúde sexual e saúde reprodutiva.** Brasília: Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: <http://dab.saude.gov.br/caderno_ab.php>.

2. ENFERMAGEM À SAÚDE DA MULHER II (100h)

EMENTA: A disciplina tem como proposta promover no aluno a competência para o desenvolvimento intelectual e profissional autônomo e permanente na área da saúde da mulher. Contempla os elementos de fundamentação essencial para a redução do risco de doenças e agravos, garantia de acesso universal e igualitário às ações e serviços públicos de saúde que integram uma rede regionalizada e hierarquizados. Visa instrumentalizar o aluno para a prestação da assistência sistematizada de enfermagem na prevenção de câncer de mama e de colo de útero, ao pré-natal, à parturiente, puérpera e recém-nascido, e no aleitamento, assim como a mulher com intercorrências ginecológicas e obstétricas.

OBJETIVOS: Desenvolver a formação técnico-científica do graduando para capacitá-lo a prestar assistência de enfermagem à saúde da mulher sexual e reprodutiva, durante o ciclo gravídico-puerperal e às com intercorrências obstétricas e ginecológicas mais prevalentes, utilizando as habilidades cognitivas, interpessoais e psicomotoras. Espera que a unidade propicie aos estudantes prestar assistência à mulher nas diferentes fases da vida, tendo como foco promoção, prevenção relacionados à vivência da sexualidade e direitos reprodutivos. Prestar assistência de Enfermagem sistematizada à mulher na saúde sexual e reprodutiva, incluindo a concepção e a anticoncepção. Conhecer a filosofia do parto e nascimento.

Conhecer a filosofia do pré-natal, puerpério e aleitamento. Conhecer a fisiopatologia das intercorrências obstétricas e ginecológicas mais prevalentes. Realizar o levantamento de dados das pacientes por meio de entrevista, exame físico/obstétrico/ginecológico, resultados de exames e diagnóstico médico. Correlacionar os dados identificados e as necessidades da paciente para tomar decisões com planejamento, intervenção e avaliação de enfermagem. Documentar o cuidado de enfermagem prestado, gerando informações que produzam evidências para sustentar a prática profissional, garantir a continuidade da assistência e desenvolver pesquisa científica. Promover ações educativas na saúde materna e da mulher, visando atender as necessidades de saúde da população consciente da sua importância, e permanente atualização do conhecimento técnico-científica da equipe de enfermagem, contribuindo para a consciência sanitária, social, política e ética da população.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MONTENEGRO, C. A. B.; REZENDE FILHO, J. **Rezende**: obstetrícia. 12. ed. Rio de Janeiro*:* Guanabara Koogan, 2013.

LOWDERMILK, D. L. et al. **Saúde da mulher e enfermagem obstétrica**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

BARROS, S. M. O.; MARIN, H. F.; ABRÃO, C. F. V. **Enfermagem obstétrica e ginecológica**: guia para a prática assistencial. 2. ed. São Paulo: Roca, 2009.

CUNNINGHAM, F. G. et al. **Obstetrícia de Williams**. 23. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012.

ENKIN, M. et al. **Guia para atenção efetiva na gravidez e no parto**. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.

REZENDE FILHO, J.; MONTENEGRO, C. A. B. **Rezende, obstetrícia fundamental.** 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Atenção ao pré-natal de baixo risco**. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2012.

NEME, B. **Obstetrícia básica**. 3. ed. São Paulo: Sarvier, 2006. 1406p.

BRÜGGEMANN, O. M; OLIVEIRA, M. E.; SANTOS, E. K. A. **Enfermagem na atenção obstétrica e neonatal**. Curitiba: Progressiva, 2011.

FREITAS, F; MARTINS-COSTA, S. H.; RAMOS, J. G. L.; MAGALHÃES, J. A. **Rotinas em obstetrícia**. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

RICCI, S. S. **Enfermagem materno-neonatal e saúde da mulher**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.

ENKIN, M. et al. **Guia para atenção afetiva na gravidez e no parto**. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.

GOMES, M. L. **Enfermagem obstétrica**: diretrizes assistenciais. Rio de Janeiro: Centro de Estudos da Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2010.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Humanização do parto e do nascimento**. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. **Ações de enfermagem para o controle do câncer: uma proposta de integração ensino-serviço**. 3. ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: INCA, 2008. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acoes_enfermagem_controle_cancer.pdf>.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (Brasil). Coordenação Geral de Ações Estratégicas. Divisão de Apoio à Rede de atenção Oncológica. **Diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero**. Rio de Janeiro: INCA, 2011. Disponível em: <http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/diretrizes_rastreamento_cancer.pdf>.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Urgências e emergências maternas**: Guia para diagnóstico e conduta em situações de risco de morte materna. Brasília, 2000. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/0105urgencias.pdf>.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Atenção humanizada ao abortamento: norma técnica**. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_humanizada_abortamento_norma_tecnica_2ed.pdf>.

_____. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011. Institui no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS – a Rede Cegonha. **Diário Oficial da União[da] República Federativa do Brasil**, Poder Executivo, Brasília, DF, 27 jun. 2011. Seção 1, p. 109.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Amamentação e uso de medicamentos e outras substâncias.** Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2010.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Área de Saúde da Criança. **Atenção humanizada ao recém-nascido de baixo-peso:** método-canguru. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2002.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Controle dos cânceres do colo do útero e da mama**. Brasília: MS, 2013. Disponível em: <http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/cab13.pdf>.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST e Aids. **Manual de controle das doenças sexualmente transmissíveis**. Brasília: Ministério da Saúde. 2006. Disponível em: <http://www.aids.gov.br/sites/default/files/manual_dst_tratamento.pdf>.

_____. Ministério da Saúde. **Parto, aborto e puerpério**: assistência humanizada à mulher. Brasília: Ministério da Saúde, 2001.

3. ENFERMAGEM EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (40h)

EMENTA: Contextualizados pelos aspectos do crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor da criança e do adolescente sadios, visando à prevenção e a promoção da saúde, buscamos propiciar ao aluno de graduação em enfermagem o conhecimento dos princípios, estratégias e práticas propostas pelos programas que norteiam a assistência de enfermagem à saúde da criança e do adolescente junto à família, em serviços de saúde. Intercorrências no processo saúde-doença da criança. Assistência de enfermagem ao recém-nascido e à criança hospitalizada nas diversas especialidades bem como nas doenças prevalentes na infância, em suas diferentes fases de crescimento e desenvolvimento, segundo necessidades biopsicossociais.

OBJETIVOS: Proporcionar ao aluno de graduação em enfermagem o conhecimento dos princípios, estratégias e práticas propostas pelos programas que norteiam a assistência de enfermagem à saúde da criança e à família em serviços de saúde e educação da comunidade. Conhecer os aspectos epidemiológicos, os programas de saúde e a legislação de proteção à criança e ao adolescente no Brasil. Compreender o processo de crescimento e desenvolvimento da criança, os determinantes sociais, emocionais e biológicos que o influenciam. Saber identificar a criança sadia e reconhecer a criança que apresenta riscos e/ou agravos à saúde. Utilizar método de avaliação, formas de Intervenção e de Estimulação

Psicomotora. Conhecer as formas adequadas de comunicação com a criança e sua família, tais como entrevista e brinquedo/brinquedo terapêutico e utilizá-las em situações de assistência, como levantamento de dados e preparo para procedimentos. Conhecer os principais agravos de saúde da infância em nossa população e discutir planejar e prestar assistência de enfermagem preconizada no contexto da assistência ambulatorial e domiciliar. Conhecer a criança sadia, particularmente o lactente e o pré-escolar, individualmente e no contexto coletivo/institucional, atendendo-a em suas necessidades básicas, avaliando seu desenvolvimento e propondo atividades de estimulação psicomotoras. Realizar a consulta de enfermagem em serviço ambulatorial de puericultura, por meio de aplicação de instrumento sistematizado, assim como vivenciar a visita domiciliar para casos selecionados. Realizar atividade de educação em saúde com crianças e adolescentes, conforme programação estabelecida e respeitando as características e os interesses da faixa etária. Assistência de enfermagem hospitalar.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BRETAS, J. R. S. **Manual de exame físico para a prática da enfermagem em pediatria**. 3. ed. São Paulo: Iatra, 2012.

BOUDEN, V. R.; GREENBERG, C. S. **Procedimentos de enfermagem pediátrica.** Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.

GAÍVA, M. A. M.; GOMES, M. M. F. **Cuidando do neonato**: uma abordagem de Enfermagem. Goiânia: EB editora, 2003.

SABATÉS, A. L.; ALMEIDA, F. A. **Enfermagem pediátrica a criança, o adolescente e sua família no hospital**. São Paulo: Manole, 2014.

SOUSA, A. L. T. M.; FLORIO, A.; KAWAMOTO, E. E. **O neonato, a criança e o adolescente.** São Paulo: EPU, 2000.

SOUZA, A. B. G. **Enfermagem neonatal**: cuidado integral ao recém-nascido. 1. ed. São Paulo: Editora Martinari, 2011.

SPRINGHOUSE CORPORATION. **Enfermagem pediátrica**. Série Incrivelmente Fácil. Rio de Janeiro: Nova Guanabara, 2006.

WILSON, D.; HOCKENBERRY, M. J. **Wong manual clinico de enfermagem pediátrica**. Especialidade: Pediatria, 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

ARAÚJO, L. A.; REIS, A. T. **Enfermagem na prática neonatal**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

ALVES, R. L. A; VIANA, M. R. A. **Saúde da família**: cuidando de crianças e adolescentes. Juiz de Fora: Coopmed, 2004.

BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de Saúde. **Saúde da criança**: acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. Série Cadernos de Atenção Básica, n.11. Brasília, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

OLIVEIRA, R. G. **Black book:** manual de referência de pediatria - medicamentos e rotinas médicas. 4. ed. Belo Horizonte: Blackbook Editora, 2011.

PENNA, H. A. O. **Neonatologia.** São Paulo: Sarvier, 2006.

PERRY, L; CASHION, A. **Saúde da mulher e enfermagem obstétrica**. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

TAMEZ, R. N.; SILVA, M. J. P. **Enfermagem na UTI neonatal**: assistência ao recém-nascido de alto risco. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Indicadores e dados básicos (IBD)**. Rede Internacional de Informações para a Saúde, 1997.

DIAMENT, A. J. Exame neurológico do lactente. In: LEFÈVRE. A. F. B; DIAMENT, A. J. E; CYPEL, S. **Neurologia Infantil**. São Paulo: Ateneu, 1989. p. 33-62.

MARTINS, M. R; RIBEIRO, C. A; BORBA, R. I. H; SILVA, C. V. Protocolo de preparo da criança para punção venosa, com utilização do brinquedo terapêutico. **Rev. latino-americana de enfer.**, v. 9, n. 2, p.76-85, 2001.

SCHMITZ, E. M. **A enfermagem em pediatria e puericultura**. Rio de Janeiro: Atheneu, 2011.

4. PRÁTICA INTEGRATIVA EM ENFERMAGEM V (280h)

EMENTA: Promove a integração teórico-prática e prática entre conteúdos Enfermagem à saúde da mulher I, Enfermagem à saúde da mulher II e Enfermagem na Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente buscando identificar elementos relevantes à formação do enfermeiro.

OBJETIVOS: Seminários integrados. Apresentar conceitos básicos relacionados ao cuidar e gerenciar em enfermagem. Possibilitar aos acadêmicos de enfermagem uma visão global e integrada dos conteúdos e conhecimentos adquiridos no semestre. Contribuir para o desenvolvimento da capacidade crítica e reflexiva do aluno articulando os saberes científicos. Oportunizar o estudo teórico-prático e prático de temas que envolvam as vivências da Enfermagem.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Saúde sexual e saúde reprodutiva.** Brasília: Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: <http://dab.saude.gov.br/caderno_ab.php>.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Política nacional de atenção integral à saúde da mulher:** Princípios e Diretrizes. 1. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2004.

CUNNINGHAM, F. G. et al. **Obstetrícia de Williams**. 23. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012.

BRASIL, Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de Saúde. **Saúde da criança**: acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. Série Cadernos de Atenção Básica, n.11. Brasília, 2002.

SCHMITZ, E. M. **A enfermagem em pediatria e puericultura**. Rio de Janeiro: Atheneu, 2011.

BRETAS, J. R. S. **Manual de exame físico para a prática da enfermagem em pediatria**. 3. ed. São Paulo: Iatra, 2012.

SOUSA, A. L. T. M.; FLORIO, A.; KAWAMOTO, E. E. **O neonato, a criança e o adolescente.** São Paulo: EPU, 2000.

ENKIN, M. et al. **Guia para atenção efetiva na gravidez e no parto**. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.

MONTENEGRO, C. A. B.; REZENDE FILHO, J. **Rezende**: obstetrícia. 12. ed. Rio de Janeiro*:* Guanabara Koogan, 2013.

REZENDE FILHO, J.; MONTENEGRO, C. A. B. **Rezende, obstetrícia fundamental.** 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ALDRIGHI, J. M.; PETTA, C, A. **Anticoncepção**: aspectos contemporâneos. São Paulo: Atheneu, 2005.

FERNANDES R. A. Q.; NARCHI, N. Z. **Enfermagem e saúde da mulher**. Barueri, SP, Manole, 2007.

FREITAS, F; MARTINS-COSTA, S. H.; RAMOS, J. G. L.; MAGALHÃES, J. A. **Rotinas em obstetrícia**. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.

LOWDERMILK, D. L; PERRY, S. E.; BOBAK, I.M. **O cuidado em enfermagem materna**. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.

PERRY, L; CASHION, A. **Saúde da mulher e enfermagem obstétrica**. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 1024p.

GARCIA, T. R.; EGRY, E. Y. **Integralidade da atenção no SUS e sistematização da assistência de enfermagem**. São Paulo: Artmed, 2010.

WILSON, D.; HOCKENBERRY, M. J. **Wong manual clínico de enfermagem pediátrica**. Especialidade: Pediatria, 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

LOWDERMILK, D. L. et al. **Saúde da mulher e enfermagem obstétrica**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

BRÜGGEMANN, O. M; OLIVEIRA, M. E.; SANTOS, E. K. A. **Enfermagem na atenção obstétrica e neonatal.** Curitiba: Progressiva, 2011.

GOMES, M. L. **Enfermagem obstétrica**: diretrizes assistenciais. Rio de Janeiro: Centro de Estudos da Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2010.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Humanização do parto e do nascimento**. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. **Ações de enfermagem para o controle do câncer: uma proposta de integração ensino-serviço.** 3. ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: INCA, 2008. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acoes_enfermagem_controle_cancer.pdf>.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (Brasil). Coordenação Geral de Ações Estratégicas. Divisão de Apoio à Rede de atenção Oncológica. **Diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero**. Rio de Janeiro: INCA, 2011. Disponível em: <http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/diretrizes_rastreamento_cancer.pdf>.

VII PERÍODO

1. ENFERMAGEM NA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO IDOSO (40h)

EMENTA: Evolução do envelhecimento com bases para as intervenções de enfermagem na assistência ao idoso. Aspectos do envelhecer e a importância da educação na promoção e proteção da saúde. Questões relativas à satisfação das necessidades humanas básicas. Patologias mais frequentes. Importância da autonomia, do autocuidado e a influência da família para uma melhor qualidade de vida do idoso em domicílio, na comunidade ou institucionalizado. Estatuto do Idoso e Política Nacional de Atenção à Saúde do Idoso.

OBJETIVOS: Oportunizar conhecimentos para assistência de enfermagem aos idosos, bem como o atendimento das necessidades básicas no período do envelhecimento, em nível primário, secundário e terciário baseados nos fundamentos teóricos de Wanda Horta; Identificar e intervir nos problemas de enfermagem e nas necessidades do cuidado da população idosa no processo saúde-doença; Analisar o processo de envelhecimento humano no seu ciclo de vida nos vários sistemas orgânicos sob a perspectiva política, social, demográfica e epidemiológica. Oportunizar conhecimentos na fisiologia, patologia, farmacologia aplicada à terceira idade; Avaliar o grau de cuidado a ser prestada ao idoso; Avaliar os resultados das intervenções de Enfermagem a serem prestados no envelhecimento humano; Estimular no aluno a interdisciplinaridade; Estimular o pensamento reflexivo, construtivo e crítico sobre a saúde.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

FREITAS, E. V.; PY, L. **Tratado de geriatria e gerontologia**. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

DUARTE, Y. A. O.; DIOGO, M. J. D. **Atendimento domiciliar**: um enfoque gerontológico. São Paulo: Atheneu, 2005.

PAPALÉO, N. M. **Gerontologia**. São Paulo: Atheneu, 1999.

BRASIL. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. **Dispõe sobre o estatuto do idoso e dá outras providências**. Brasília, DF, 2003.

BRASIL. A Lei nº. 8.842, de 4 de janeiro de 1994. **Dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências**. Brasília, DF, 1994.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ABRAMS, W.; BERKOW, R. **Manual merk de geriatria**. 2. ed. São Paulo: Rocca, 2001.

CANÇADO, F. A. X. **Noções práticas de geriatria**. Belo Horizonte: Coopmed, 1994.

FORCIEA. **Segredos em geriatria**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

VERAS, R. P. **Terceira idade**: gestão contemporânea em saúde. Rio de Janeiro: UNATI\UERJ, 2002.

GUIMARÃES, R. M.; CUNHA, U. G. **Sinais e sintomas em geriatria**. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2004;

ROACH, S. **Introdução à enfermagem gerontológica**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA. **Caminhos do envelhecer**. Rio de Janeiro: Vozes, 1994.

2. ENFERMAGEM NO CUIDADO A SAÚDE MENTAL (40h)

EMENTA: Trata-se de elementos teóricos sobre psiquiatria e saúde mental que facilitam a compreensão da assistência de enfermagem frente a portadores de transtornos mentais e suas famílias dentro de uma dinâmica reabilitadora nos diferentes contextos de atuação profissional, tendo como base a respeitabilidade e a valorização do sujeito em sofrimento psíquico.

OBJETIVOS: Compreender a trajetória da assistência psiquiátrica até o atual contexto das políticas de saúde mental. Refletir sobre o papel do enfermeiro na saúde mental. Estimular o aluno a reconhecer o portador de transtorno mental como um ser humano, diminuindo o estigma a fim de facilitar o estabelecimento de uma relação terapêutica com o sujeito e sua família. Conhecer os diferentes transtornos mentais, sua epidemiologia, tratamentos e cuidados de enfermagem.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ROCHA, R. M. **Enfermagem em saúde mental**. 2. ed. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2013.

STUART, G. W.; LARAIA, M. T. **Enfermagem psiquiátrica**. 6. ed. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso, 2012.

TAYLOR, C. M. **Fundamentos de enfermagem psiquiátrica**. 15. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.

BUCKLEY, P. J.; MACKINNON, R. A.; MICHELS, R. **A entrevista psiquiátrica na prática clínica**. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.

VIDEBECK, S. L. **Enfermagem em saúde mental e psiquiátrica**. Trad. Denise Regina de Sales. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRASIL. Ministério da Saúde**. Legislação em saúde mental 1990-2004.** Brasília, 2004.

_____. Ministério da Saúde. **Memória da loucura**. Brasília, 2004.

_____. Ministério da Saúde. **Reforma psiquiátrica e política de saúde mental no brasil**. Brasília, 2005.

JORGE, M. S. B.; SILVA, V. V. da; OLIVEIRA, F. B. de. **Saúde mental**: da prática psiquiátrica asilar ao terceiro milênio. São Paulo: Lemos, 2000.

KAPCZINSKI, F. et al. **Emergências psiquiátricas**. Porto Alegre: Artmed, 2001.

3. RELAÇÕES HUMANAS NO PROCESSO DE TRABALHO DA ENFERMAGEM (60h)

EMENTA: Teoria da comunicação humana, que embasa o entendimento do comportamento humano e as relações interpessoais nas organizações, abrangendo tópicos de organizações, comunicações e dinâmicas interpessoais.

OBJETIVOS: Compreender a dinâmica das organizações, ensinando noções básicas de Administração em Serviços de Saúde e na Enfermagem, tipos de estruturas organizacionais, principalmente no que se refere à questão da hierarquia. Capacitar o aluno a compreender a dinâmica do poder nas organizações e detectar sua influência. Introduzir noções referentes às aplicações práticas de técnicas para implementar o sistema de comunicação nos serviços de saúde e na enfermagem. Introduzir conceitos básicos sobre grupos, levando o aluno a conhecer os tipos de grupos, detectar características e diagnosticar sua dinâmica. Capacitar alunos a identificar e detectar dados sobre estilos gerenciais e compreender o que caracteriza o estilo gerencial, liderar e chefiar. Capacitar o aluno a compreender o processo motivacional humano nos serviços de saúde e na Enfermagem. Capacitar o aluno para avaliar a dinâmica relacional-grupal: conflitos, negociações, tomada de decisões.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ROBBINS, S. P. **Fundamentos do comportamento organizacional**. 8. ed. São Paulo: Prentice. Hall Pearson, 2008.

BERGAMINI, C. W. **Psicologia aplicada à administração de empresas**: psicologia do comportamento organizacional. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2005.

FIORELLI, J. O. **Psicologia para administradores:** integrando teoria e prática**.** São Paulo: Atlas, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

IORIO, C. S. **Manual de administração de pessoal**. 5. ed. São Paulo: Senac Sp, 1996

LIMONGI-FRANÇA, A. C. **Comportamento organizacional**: Conceitos e Práticas. São Paulo: Saraiva, 2005.

CARVALHO, J. M. **Cidadania no Brasil**: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.

PICHON-RIVIÈRE, E. **O processo grupal**. São Paulo: Martins Fontes, 1986.

QUIN, R. E et al. **Competências gerenciais**: princípios e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

4. PRÁTICAS EDUCATIVAS EM SAÚDE/ENFERMAGEM – 60h

EMENTA: Estudo das diferentes concepções, modelos e tecnologias educacionais com vistas à capacitação do enfermeiro para o exercício da prática pedagógica em atividades de Educação para a Saúde junto à população e em atividade de supervisão e instrução no processo de Educação permanente dos demais membros da equipe de enfermagem inseridos nos serviços de saúde.

OBJETIVO: Compreender as complexas relações das áreas Educação e Saúde, na perspectiva de formação de educadores para a área da saúde e da enfermagem.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BATISTA, N. A.; BATITSTA, S. H (Org.). **Docência em saúde**. 2. ed. São Paulo: Senac, 2014.

GERMANO, R. M. **Educação e ideologia da enfermagem no Brasil**: (1955-1980). São Caetano do Sul, SP: Yendis, 2007.

LIMA, E. M. M. **Políticas públicas de educação-saúde**: reflexões, diálogos e práticas. Campinas-SP: Alinea, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

GAZZINELLI, M. F.; REIS, D. C. **Educação em saúde**: teoria, método e imaginação. Belo Horizonte: UFMG, 2006.

CAVALHO, V. L. **Ensino de Enfermagem e Metodologia**. Rio de Janeiro: Cultura Médica, 1999.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia**: Saberes necessários à prática educativa. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996

5. PRÁTICA INTEGRATIVA EM ENFERMAGEM VI (240h)

EMENTA: Promove a integração teórico-prática e prática entre conteúdos Enfermagem na atenção Integral à Saúde do Idoso e Enfermagem no cuidado a Saúde Mental, buscando identificar elementos relevantes à formação do enfermeiro.

OBJETIVOS: Seminários integrados. Apresentar conceitos básicos relacionados ao cuidar e gerenciar em enfermagem Possibilitar aos acadêmicos de enfermagem uma visão global e integrada dos conteúdos e conhecimentos adquiridos no semestre. Contribuir para o desenvolvimento da capacidade crítica e reflexiva do aluno articulando os saberes científicos. Oportunizar o estudo teórico-prático e prático de temas que envolvam as vivências da enfermagem.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

FREITAS, E. V.; PY, L. **Tratado de geriatria e gerontologia**. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

ROACH, S. **Introdução à enfermagem gerontológica**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.

ROCHA, R. M. **Enfermagem em saúde mental**. 2. ed. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

STUART, G. W.; LARAIA, M. T. **Enfermagem psiquiátrica**. 6. ed. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso, 2012.

VIDEBECK, S. L. **Enfermagem em saúde mental e psiquiátrica**. Trad. Denise Regina de Sales. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.

TAYLOR, C. M. **Fundamentos de enfermagem psiquiátrica**. 15. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.

BRASIL. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. **Dispõe sobre o estatuto do idoso e dá outras providências**. Brasília, DF, 2003.

BRASIL. A Lei nº. 8.842, de 4 de janeiro de 1994. **Dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências**. Brasília, DF, 1994.

VIII PERÍODO

1. ENFERMAGEM EM DOENÇAS TROPICAIS E TRANSMISSÍVEIS (40h)

EMENTA: Aspectos socioculturais e clínicos das doenças transmissíveis, metodologia do cuidado de enfermagem e organização de serviços e ações de saúde da atenção básica e hospitalar para o controle das doenças transmissíveis.

OBJETIVOS: Conhecer os aspectos socioculturais e clínicos em doenças transmissíveis, com ênfase naqueles de maior importância epidemiológica loco-regional e para a Saúde Pública. Desenvolver ações de enfermagem em doenças transmissíveis nos serviços de saúde ambulatorial e hospitalar e junto às organizações da sociedade civil, utilizando ferramentas da metodologia da assistência de enfermagem, da epidemiologia e do planejamento em saúde. Ampliar conhecimentos em doenças transmissíveis nos aspectos de controle e assistência, com ênfase na educação para saúde.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BRASIL. **Manual técnico para o controle da tuberculose**. Brasília: Ministério da Saúde, 2011.

_____. Ministério da Saúde. **Doenças infecciosas e parasitárias**: guia de bolso. 8. ed. Brasília: Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde, 2010.

_____. Ministério da Saúde. **Manual de bolso controle das doenças sexualmente transmissíveis – DST**. 2. ed. Brasília, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MACIEL, E. L. N. et al. Tuberculosis in health professionals: a new perspective on an old problem. **Jornal brasileiro de pneumologia,** v. 35, n. 1, p. 83-90, 2009.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Guia de vigilância epidemiológica**. 6. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2005.

PHILIPPI, M. L. S; ARONE, E. M. **Enfermagem em doenças transmissíveis**. São Paulo: SENAC, 2008.

AGUIAR NETO, Z.; RIBEIRO, M. C. S. **Vigilância e controle de doenças transmissíveis**. São Paulo: Martinari, 2006.

CHIN, J. **Manual de controle de doenças transmissíveis**. Porto Alegre: Artmed, 2002.

2. **ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA III (40h)**

EMENTA: Assistência de enfermagem ao indivíduo, família e comunidade em saúde coletiva integrada ao conjunto de disciplinas da matriz curricular. Aspectos éticos e fundamentação teórica na assistência de enfermagem na comunidade. Instrumentalização para atuação na assistência e na gestão nos serviços de saúde e coletividades. Planejamento, execução e avaliação de medidas de promoção e proteção da saúde individual, familiar e coletiva, prevenção e controle dos principais problemas de saúde da população, doenças e agravos não-transmissíveis e transmissíveis, enfocando grupos específicos e mais vulneráveis da população. Os Programas de saúde e a atuação do enfermeiro. Acidentes e violências como um desafio para a Saúde Coletiva. A saúde mental na atenção básica. A vigilância em saúde.

OBJETIVOS: Proporcionar ao acadêmico experenciar e prestar a assistência de enfermagem na coletividade em diferentes situações no processo saúde-doença, desenvolvendo ações direcionadas aos Programas de Saúde do Ministério de Saúde; Conhecer a estruturação e funcionamento da Estratégia Saúde da Família e do Monitoramento e Avaliação da atenção básica; Proporcionar ao acadêmico o planejamento e gerenciamento de Unidade e Programas de Saúde; Participar de atividades de educação em Saúde; A enfermagem e a vigilância em saúde.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ANDRADE, S. M.; SOARES, T.; CORDONI JUNIOR, L. **Bases da saúde coletiva**. Londrina: UEL, 2001.

MILÃO L. F.; FIGUEIREDO, M. R. B. **Enfermagem em saúde coletiva**. Rio de Janeiro: Editora Senac, 2012.

SANTOS, A. da S.; CUBAS, M. R. **Saúde coletiva**: linhas de cuidado e consulta de enfermagem. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil:** texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com alterações adotadas pelas ementas constitucionais nº 1/1992 a 68/2011 pelo Decreto Legislativo nº 186/2008 e pelas Emendas Constitucionais de Revisão nos 1 a 6/1994. 35. ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2012.

CAMPOS, G. W. S. et al. **Tratado de saúde coletiva**. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 2012.

MATTOS, M. de; VERONESI, C. L.; SILVA JUNIOR, A. J. **Enfermagem na educação em saúde**. Curitiba: Prismas, 2013.

OLIVEIRA, G. N. **Gestão gerencial em saúde da família**. Araras, SP: Lawbook, 2011.

STARFIELD, B. **Atenção primária:** equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia. Brasília: UNESCO, Ministério da Saúde, 2002.

3. A GERÊNCIA DO PROCESSO DE TRABALHO DA ENFERMAGEM EM GESTÃO, REDE BÁSICA DE SAÚDE E REDE HOSPITALAR/AMBULATORIAL (60h)

EMENTA: Ensino prático da aplicação das teorias, princípios e métodos da administração, relacionando-os na pratica da enfermagem. Capacitação técnica e política do enfermeiro para a coordenação do processo de trabalho da enfermagem, inserido no trabalho coletivo em saúde e para a administração da assistência de enfermagem no nível da Rede Básica de serviços de saúde, Gestão na Rede hospitalar/ambulatorial.

OBJETIVOS: Coordenar a assistência de enfermagem em uma unidade de internação hospitalar/ambulatorial e na rede básica, relacionando-a como parte integrante da instituição de saúde; Conhecer e acompanhar os componentes das políticas assistenciais, de recursos humanos, recursos materiais, e planejamento em saúde nos três níveis de atenção; Conhecer a política de financiamento do setor saúde; Instrumentalizar o acadêmico para a tomada de decisões; Capacitar o acadêmico para planejar e implementar o programa de educação Permanente e Continuada da equipe de enfermagem. Observar crítica e reflexivamente o Processo Administrativo das Unidades de saúde.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

CHIAVENATO, I. **Administração**: teoria, processo e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

KURCGANT, P. **Administração em enfermagem**. São Paulo: EPU, 1998.

MARQUIS, B. L.; HUSTON, C. J. **Administração liderança em enfermagem**: teoria e prática. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

COHN, A.; ELIAS, P. E. M. **Saúde no Brasil**: políticas e organização de serviços. São Paulo: Cortez, 2003.

MAXIMIANO, A. C. A. **Introdução à administração**. São Paulo: Atlas, 2004.

SANTOS. Y. **Supervisão em enfermagem**. Rio de Janeiro: Cultura Médica, 1993.

ALMEIDA, M. H. **Tomada de decisões do enfermeiro**. Rio de Janeiro: Cultura Médica, 1994.

ALMEIDA, M. C. P. de; ROCHA, S. M. M. **O trabalho de enfermagem**. São Paulo: Cortez, 1997.

4. PRÁTICA INTEGRATIVA EM ENFERMAGEM VII (280h)

EMENTA: Promove a integração teórico-prática e prática entre conteúdos das disciplinas enfermagem em doenças tropicais e transmissíveis, enfermagem em saúde coletiva III e A gerência do processo de trabalho da enfermagem em gestão, rede básica de saúde e rede hospitalar/ambulatorial, buscando identificar elementos relevantes a formação do enfermeiro.

OBJETIVOS: Seminários integrados. Apresentar conceitos básicos relacionados ao cuidar e gerenciar em enfermagem. Possibilitar aos acadêmicos de enfermagem uma visão global e integrada dos conteúdos e conhecimentos adquiridos no semestre. Contribuir para o desenvolvimento da capacidade crítica e reflexiva do aluno articulando os saberes científicos. Oportunizar o estudo teórico-prático e prático de temas que envolvam as vivências da Enfermagem.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

MARQUIS, B. L.; HUSTON, C. J. **Administração liderança em enfermagem**: teoria e prática. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

MILÃO L. F.; FIGUEIREDO, M. R. B. **Enfermagem em saúde coletiva**. 1. Rio de Janeiro: Editora Senac, 2012.

OLIVEIRA, G. N. **Gestão gerencial em saúde da família**. Araras, SP: Lawbook, 2011.

SANTOS, A. da S.; CUBAS, M. R. **Saúde coletiva**: linhas de cuidado e consulta de enfermagem. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

SOUNIS, E. **Epidemiologia aplicada**. São Paulo: Livraria Atenas, 1985.

BRASIL. **Manual técnico para o controle da tuberculose**. Brasília: Ministério da Saúde, 2011.

_____. Ministério da Saúde. **Doenças infecciosas e parasitárias:** guia de bolso. 8. ed. Brasília: Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde, 2010.

_____. Ministério da Saúde. **Manual de bolso controle das doenças sexualmente transmissíveis – DST**. 2. ed. Brasília, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil:** texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com alterações adotadas pelas ementas constitucionais nº 1/1992 a 68/2011 pelo Decreto Legislativo nº 186/2008 e pelas Emendas Constitucionais de Revisão nos 1 a 6/1994. 35. ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2012. 454p.

_____. Fundação Nacional de Saúde. **Guia de vigilância epidemiológica**. 5. ed. Brasília: FUNASA, 2002. V. I. Aids / Hepatites virais.

PHILIPPI, M. L. S; ARONE, E. M. **Enfermagem em doenças transmissíveis**. São Paulo: SENAC, 2008.

AGUIAR NETO, Z.; RIBEIRO, M. C. S. **Vigilância e controle de doenças transmissíveis**. São Paulo: Martinari, 2006.

CHIN, J. **Manual de controle de doenças transmissíveis**. Porto Alegre: Artmed, 2002.

CAMPOS, G. W. S. et al. **Tratado de saúde coletiva**. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 2012. 976p.

MATTOS, M.; VERONESI, C. L.; SILVA JUNIOR, A. J. **Enfermagem na educação em saúde**. Curitiba: Prismas, 2013.

SANTOS. Y. **Supervisão em enfermagem**. Rio de Janeiro: Cultura Médica, 1993.

IX PERÍODO

1. ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I (420h)

EMENTA: Desenvolvimento das competências e habilidades inerentes ao futuro profissional Enfermeiro em hospitais gerais ou especializados, ambulatórios, rede básica de serviços de saúde, comunidades e na gestão, entre outras. Compreensão da realidade das atividades

desempenhadas pela Enfermagem nos diferentes contextos. Desenvolvimento de ações e estratégias que visam ao cuidado integral ao ser humano. Execução do planejamento das ações em saúde e enfermagem por meio do estágio supervisionado.

OBJETIVOS: Desenvolver nos discentes conhecimentos, habilidades e atitudes a partir dos eixos norteadores da universidade, o ensino, a pesquisa e a extensão, os quais permitem a formação técnico-científica e ético-política voltada ao exercício profissional. Proporcionar uma experiência acadêmica-profissional através de vivências nos campos de estágio; Oportunizar aos discentes vivenciar as problemáticas do trabalho em Enfermagem através de uma prática crítico-reflexiva da realidade com articulação entre teoria e prática; Fortalecer o processo de integração dos discentes com a realidade social e profissional; Aprimorar habilidades técnico-científicas requeridas para o exercício do futuro profissional; Estimular os discentes para o desenvolvimento da assistência norteada pelos preceitos do Sistema Único de Saúde - SUS, assegurando a integralidade da atenção, a qualidade e humanização do atendimento; Propiciar a reflexão sobre os aspectos éticos e legais inerentes ao exercício profissional; Sensibilizar os discentes para promover transformações necessárias como resultado da reflexão e da ação sobre a realidade; Oportunizar ao discentes a prática de atividades de ensino, pesquisa e extensão; Propiciar ao discentes o aprofundamento teórico-prático, oportunizando uma vivência assistencial para o aprimoramento da capacidade de interpretação e de crítica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ARRUDA, M. **Humanizando o infra-humano**: a formação do ser humano integral: homo evolutivo, práxis e economia solidária. Rio de Janeiro: Vozes, 2003.

CANGUILHEM, G. **O normal e o patológico**. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006.

CECÍLIO, L. C. O. **Inventando a mudança na saúde**. São Paulo: Hucitec, 1997.

GÓIS, C. W. de L. **Saúde comunitária:** pensar e fazer. São Paulo: Hucitec, 2008.

HARTZ, Z. M. de A.; SILVA, L. M. V. **Avaliação em saúde**: dos modelos teóricos à prática na avaliação de programas e sistemas de saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2008.

MENDES, E. V. **Uma agenda para a saúde**. São Paulo: Hucitec, 1996.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GAUTHIER, J. H. M.; CABRAL, I. E.; SANTOS, I.; TAVARES, C. M. M. **Pesquisa em enfermagem**: novas metodologias aplicadas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997.

MERHY, E. E. **Saúde**: a cartografia do trabalho vivo. São Paulo: Hucitec, 2002.

MERHY, E. E.; ONOCKO, R. **Agir em saúde**: um desafio para o público. São Paulo: Hucitec, 2002.

MINAYO, M. C. S; ASSIS, S. G.; SOUZA, E. R. **Avaliação por triangulação de métodos**: abordagem de programas sociais. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005.

MORAES, I. H. S. **Informações em saúde**: da prática fragmentada ao exercício da cidadania. São Paulo: Hucitec-Abrasco, 1994.

PESSINI, L.; BERTACHINI, L. **Humanização e cuidados paliativos**. São Paulo: Loyola, 2004.

SCHIER, J. **Tecnologia de educação em saúde**: o grupo aqui e agora. Porto Alegre: Sulina, 2004.

VASCONCELOS, E. M. **Educação popular e a atenção à saúde da família**. 4. ed. São Paulo: Hucitec, 2008.

2. Trabalho de Conclusão de Curso I (20h)

EMENTA: O trabalho de conclusão de curso (TCC) é uma atividade acadêmica avaliativa e obrigatória para todos discentes do Curso de Graduação em Enfermagem. Consiste na elaboração do projeto de pesquisa ou plano de trabalho, metodologicamente sistematizado, construído nesta Disciplina e desenvolvido na Disciplina de trabalho de conclusão de curso II.

OBJETIVOS: Propiciar ao discentes o aprofundamento temático, o estímulo a produção científica e o aprimoramento da capacidade de interpretação e crítica; Possibilitar ao discentes a reflexão acerca de suas concepções sobre o conhecimento científico e as inter-relações com a prática profissional; Propiciar ao discentes a apropriação, elaboração e produção do conhecimento.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR:

As referências devem ser sugeridas pelo professor orientador de acordo com a temática de estudo e abordagem de pesquisa.

X PERÍODO

1. ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II – (420h)

EMENTA: Desenvolver ações de enfermagem nos serviços de saúde. Exercitar habilidade de diagnóstico e planejamento de ações em saúde. Observar diferentes níveis de complexidade nos cuidados realizados. Colocar em prática todas as habilidades e as competências adquiridas no decorrer do curso de graduação em enfermagem. Execução do planejamento das ações em saúde e enfermagem por meio do estágio supervisionado realizado no âmbito da atenção básica, ambulatorial, hospitalar e na gestão dos serviços de saúde.

OBJETIVOS: Aprofundar e ampliar as competências e habilidades inerentes ao profissional enfermeiro nos ambientes hospitalares, ambulatórios, rede básica de saúde, comunidades, gestão, entre outras, planejando, desenvolvendo e aplicando o cuidado integral ao ser humano.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

GAUTHIER, J. H. M.; CABRAL, I. E.; SANTOS, I.; TAVARES, C. M. M. **Pesquisa em enfermagem**: novas metodologias aplicadas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997.

MERHY, E. E. **Saúde**: a cartografia do trabalho vivo. São Paulo: Hucitec, 2002.

MERHY, E. E.; ONOCKO, R. **Agir em saúde**: um desafio para o público. São Paulo: Hucitec, 2002.

MORAES, I. H. S. **Informações em saúde**: da prática fragmentada ao exercício da cidadania. São Paulo: Hucitec/Abrasco, 1994.

PESSINI, L.; BERTACHINI, L. **Humanização e cuidados paliativos**. São Paulo: Loyola, 2004.

VASCONCELOS, E. M. **Educação popular e a atenção à saúde da família**. 4. ed. São Paulo: Hucitec, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ARRUDA, M. **Humanizando o infra-humano**: a formação do ser humano integral: homo evolutivo, práxis e economia solidária. Rio de Janeiro: Vozes, 2003.

CANGUILHEM, G. **O normal e o patológico**. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006.

CECÍLIO, L. C. O. **Inventando a mudança na saúde**. São Paulo: Hucitec, 1997.

GÓIS, C. W. de L. **Saúde comunitária**: pensar e fazer. São Paulo: Hucitec, 2008.

HARTZ, Z. M. de A.; SILVA, L. M. V. **Avaliação em saúde**: dos modelos teóricos à prática na avaliação de programas e sistemas de saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2008.
MENDES, E. V. **Uma agenda para a saúde**. São Paulo: Hucitec, 1996.
SCHIER, J. **Tecnologia de educação em saúde**: o grupo aqui e agora. Porto Alegre: Sulina, 2004.

2. Trabalho de Conclusão de Curso II (20h)

EMENTA: Dar continuidade ao exercício da prática investigativa em enfermagem, a partir da elaboração de um projeto de pesquisa.

OBJETIVO: Construir um trabalho de conclusão de curso na forma escrita e apresentá-lo na forma oral. Propiciar ao discente o aprofundamento temático, o estímulo a produção científica e o aprimoramento da capacidade de interpretação e crítica; possibilitar ao discente a reflexão acerca de suas concepções sobre o conhecimento científico e as inter-relações com a prática profissional; propiciar ao discente a apropriação, elaboração e produção do conhecimento.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR:

As referências devem ser sugeridas pelo professor orientador de acordo com a temática de estudo e abordagem de pesquisa.

Em todos os componentes curriculares do tronco profissional do Curso serão abordados aspectos relativos à alimentação saudável, direitos humanos e educação ambiental. Periódicos devem ser acessados para complementar a bibliografia com estudos recentes acerca da temática. Inicialmente, está previsto somente o uso de periódicos científicos, cujos principais títulos pertinentes, com acesso on-line, estão listados a seguir no quadro 3:

Quadro 3 - Periódicos científicos de interesse para o curso de graduação em enfermagem da UNIR.

Área do conhecimento	**Periódico**
Administração Pública	Comportamento Organizacional e Gestão
Antropologia	Revista Anthropológicas Teoria & Sociedade (UFMG) Social Science and Medicine Revista de Antropologia (São Paulo)
Economia	Economia e Sociedade (UNICAMP) Revista Brasileira de Economia

	Journal of Human Resources
Educação	Educação & Realidade Interface - Comunicação, Saúde, Educação Psicologia da Educação Revista Brasileira de Educação Médica
Enfermagem	Revista Brasileira de Enfermagem Revista da Escola de Enfermagem da USP Revista Gaúcha de Enfermagem Revista Latino-Americana de Enfermagem Texto & Contexto Enfermagem Public Health Nursing Journal of public health management and practice Journal of Community Health Nursing
Epidemiologia	Epidemiologia e Serviços de Saúde Revista Brasileira de Epidemiologia Journal of epidemiology and community health International journal of epidemiology
Estatística	Statistics & Probability Letters Demography
Ética e Bioética	Medical Humanities Revista Bioética
Geografia	Revista USP Revista Brasileira de Geociências Revista Brasileira de Ciências Sociais Progress in Human Geography
História da Medicina	Arquivos Riograndenses de Medicina Medicina e História Revista de História e Humanidades Médicas Journal of the history of medicine and allied sciences
Hospitais	Revista de Administração em Saúde Hospitals & Health Networks
Informática Médica	Journal of the American Medical Informatics Association Health informatics journal International journal of medical informatics
Medicina Ocupacional	Revista Brasileira de Saúde Ocupacional Journal of Occupational Health
Medicina Preventiva e Social	História, Ciências, Saúde / Manguinhos Physis - Revista de Saúde Coletiva American Journal of Preventive Medicine
Medicina Social	Revista Latino-Americana de Ciências Sociales, Niñez y Juventud
Medicina Tropical	Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo
Medicina Veterinária	Archivos de Medicina Veterinária Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia
Prestação de cuidados de	Health and Quality of Life Outcomes

saúde	
Psicologia	Estudos e Pesquisas em Psicologia Psicologia & Sociedade Psicologia Hospitalar
Reabilitação	Revista Brasileira de Fisioterapia Fisioterapia em movimento Journal of Reabilitation Research and Development
Saúde Ambiental	Environmental Health Environmental Health Perspectives
Saúde Coletiva	Ciência & Saúde Coletiva Cadernos de Saúde Pública (FIOCRUZ) American Journal of Preventive Medicine American Journal of Public Health
Saúde Pública	Boletim da Saúde Cadernos de Saúde Coletiva Cadernos de Saúde Pública Ciência & Saúde Coletiva Estudos Avançados História, Ciências, Saúde – Manguinhos Revista Baiana de Saúde Pública Revista Brasileira de Estudos de População Revista Cubana de Salud Pública Revista de Saúde Pública Revista Panamericana de Salud Pública Saúde & Sociedade

3.7.6 O trabalho de conclusão de curso

O Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) de Graduação em Enfermagem será uma prática investigativa e/ou assistencial elaborada individualmente pelo acadêmico, em consonância com a Linha de Trabalho de um professor do corpo docente do DENF/UNIR. O TCC deverá abordar temas da área da saúde relacionados à enfermagem/saúde, sendo este uma proposta que tenha relação com a realidade dos serviços, ressaltando o compromisso da Universidade em contribuir para a concretização dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. É uma contribuição ao conhecimento e deve ser de nível publicável e científico, segundo os parâmetros da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Os objetivos gerais do TCC é o de proporcionar aos alunos à oportunidade de demonstrar o grau de conhecimento adquirido, o aprofundamento do recorte temático, a sistematização das atividades, o ensaio teórico e/ou exposição dos resultados de uma

pesquisa. A regulamentação específica para a realização do TCC no âmbito do DENF/UNIR consta no Apêndice 2.

3.7.7 Os estágios curriculares obrigatórios

O estágio curricular supervisionado pressupõe um estudante "pré-profissional", capaz de exercer atividades sob o gerenciamento de preceptor (articulando docente com o enfermeiro assistencial/gerencial), que será responsável pelo acompanhamento avaliativo. Desta forma o preceptor e o professor avaliarão o posicionamento correto do estudante no que se refere à aquisição de competências e habilidades, treinadas e introjetadas anteriormente no ensino prático. Os Estágios Supervisionados obrigatórios são organizados de forma a possuírem complexidade crescente à medida que o aluno vença os objetivos de cada disciplina, os quais têm por objetivos:

- Proporcionar ao aluno experiência profissional específica e contribuir, de forma eficaz, em sua absorção pelo mercado de trabalho.

- Possibilitar ao aluno aplicar seus conhecimentos acadêmicos em situações da prática profissional, oferecendo o exercício de suas habilidades e fazendo com que adquira visão crítica de sua área de atuação.

- Oportunizar a integração dos conhecimentos teóricos com a prática cotidiana;

- Identificar problemas organizacionais.

- Transposição dos conhecimentos para situações concretas.

- Observação e análise de situações práticas como base para a teorização.

- Elaborar e executar propostas de ações articuladas com a sociedade.

O estágio curricular do Curso de Graduação em Enfermagem está de acordo com a Resolução do CNE/CES n.3, situando-os nos dois últimos semestres, é uma atividade curricular de caráter obrigatório e se configura pela inserção do acadêmico no contexto social, intervindo no processo saúde/doença da população bem como na gestão do sistema de saúde.

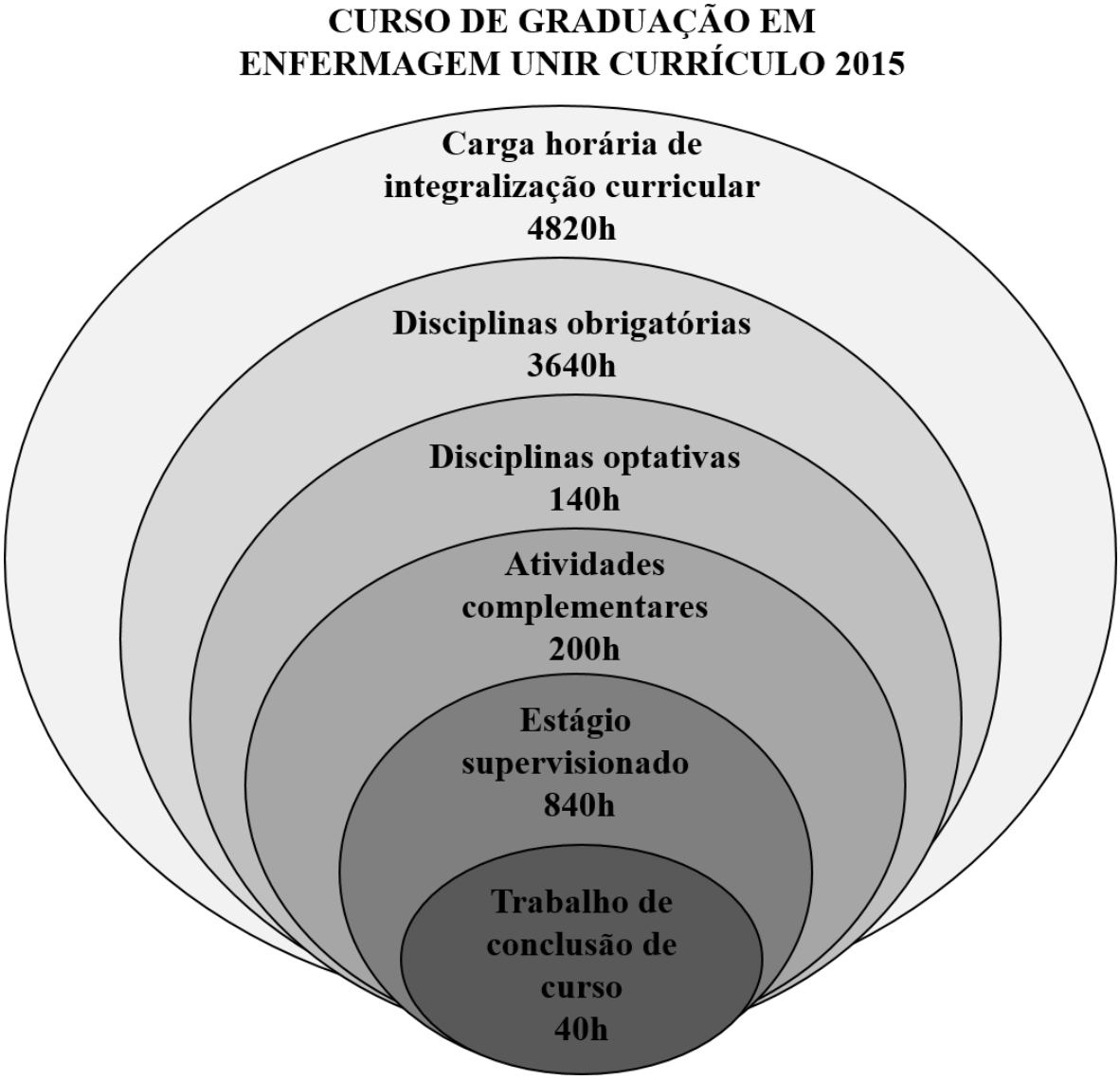
Os Estágios Curriculares Supervisionados I e II, respectivamente, proporcionam ao acadêmico o conhecimento "*in loco"* das características profissionais que circundam as ações de enfermagem e da saúde, conhecendo e interagindo com as singularidades e pluralidades das comunidades e dos indivíduos e, assim, ampliando e aprimorando a visão acerca da sua futura atuação. Engloba as áreas de Enfermagem em Saúde Coletiva, no Cuidado à Mulher,

no Cuidado à Criança e Adolescente, no Cuidado ao Adulto, no Cuidado ao Idoso, no Cuidado em Saúde Mental, nos Cuidados Cirúrgicos e Administração/Gestão de serviços de saúde e de Enfermagem. Para habilitar-se ao estágio o aluno deverá ter cumprido todos os componentes curriculares obrigatórios, optativos e as atividades complementares previstas neste PPC e constantes da organização curricular desde o 1º até o 8º período do Curso.

O desenvolvimento dos Estágios se dará em diferentes espaços, permeando os ambientes hospitalares, as unidades de saúde, ambulatórios, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), UPA, empresas, Secretarias de Saúde, Agência Estadual de Vigilância Sanitária (AGEVISA), entre outros, de modo a valorizar principalmente os ambientes do SUS e as instituições filantrópicas ou comunitárias credenciadas e/ou contratualizadas pelo SUS. Cabe salientar que, durante o período de estágio, o acadêmico receberá acompanhamento de um professor à distância e de um preceptor do serviço. O regulamento do Estágio Curricular Obrigatório encontra-se no Apêndice 3. A avaliação dos Estágios Curriculares Supervisionados I e II será realizada da seguinte forma: a avaliação dos preceptores dos serviços em 30% e dos professores tutores em 70%.

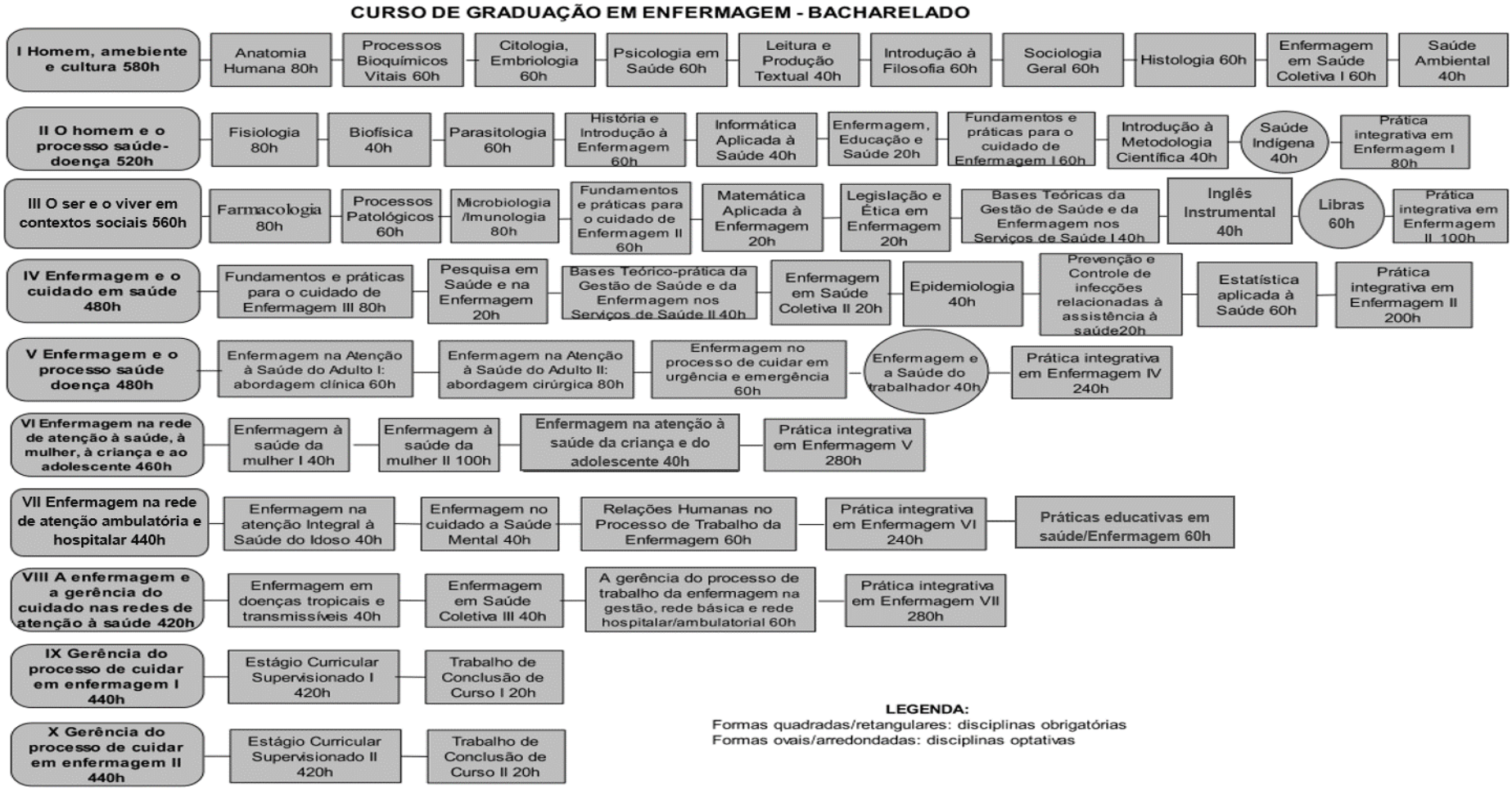
3.8 Representação gráfica de um perfil de formação

Figura 1 - Representação gráfica geral do perfil de formação do curso de graduação em enfermagem da UNIR.



Fonte: Elaborado com base na matriz curricular de 2015.

Figura 2 - Representação gráfica do perfil de formação do curso de graduação em enfermagem da UNIR por eixo temático de aprendizagem que corresponde aos períodos do curso.



Fonte: Elaborado com base na matriz curricular de 2015.

3.9 Avaliação e metodologias de ensino

3.9.1 Metodologias de ensino

As diretrizes pedagógicas que deverão nortear a formação profissional, científica, tecnológica, política e culturalmente são aquelas que venham atender ao perfil almejado e que desenvolvam neste o compromisso com a transformação dos modelos assistenciais. Estão centradas em metodologias que enfatizem a construção do conhecimento ao invés da reprodução acrítica, no intuito de conduzir o discente a questionar o processo ensino-aprendizagem e o contexto em que está inserido.

A metodologia proposta - por ser participativa, problematizadora e interdisciplinar - oportuniza reflexões e discussões sobre os problemas reais vivenciados pelos educandos, trabalhando a articulação teoria e prática, contemplando não só a diversidade dos cenários de aprendizagem, mas estabelecendo vínculos efetivos com as mudanças nesses cenários.

Possibilita identificar e privilegiar projetos integrados de atuação multiprofissional e direcionar as propostas de ensino-intervenção com vista às necessárias transformações do perfil de saúde, nas áreas de atuação das equipes de Enfermagem.

Todavia, confia-se também no potencial que o educando traz inerente a sua própria maneira de ser e aprender, bem como da acumulação de saberes e conhecimentos anteriormente apreendidos nos diversos espaços de sua convivência e de formação. Espera-se que o estudante do Curso de Graduação em Enfermagem da UNIR seja marcado pela curiosidade investigativa e científica, pela capacidade de desenvolver análise crítico-política, pelo compromisso ético primordialmente voltado à sua comunidade ou região, pela sensibilidade humanística e pelos princípios de solidariedade, e essencialmente, aberto às situações inovadoras e fomentadoras de transformação social.

Essa preposição metodológica não se configura, entretanto, como um modelo estático e uniforme a ser adotado, mas, serve como um parâmetro norteador da escolha dos recursos pedagógicos, das estratégias e técnicas de ensino que são utilizadas, para a elaboração do material didático, para as estratégias de acompanhamento e avaliação, e, até mesmo, para facilitar a relação educador-educando. Orientador, portanto, de uma aprendizagem que se destina a contribuir para a motivação e para o interesse do aluno, além de facilitar os processos de aprendizagem, garantindo a sua autonomia e liberdade.

Cria-se, dessa forma, a possibilidade não só de construir uma visão crítica e transformadora da realidade em que o educando está inserido, mas, da construção de sujeitos da ação, comprometidos com avanços e mudanças, através da pactuação, em comum, sobre protocolos de qualidade, acolhimento e humanização, em vivências cotidianas.

Pressupõe-se, principalmente, estabelecer uma relação democrática, não apenas entre educador e educando, mas também com os trabalhadores da saúde e com os usuários dos serviços, buscando, numa relação de mútua confiabilidade, desenvolver uma cultura e pacto de cientificidade e de humanização. E esta talvez se constitua na sua maior singularidade, uma diferença marcante deste projeto pedagógico em relação à ruptura com a cultura de formação em saúde predominante.

Esse modo de compreender o aprendizado implica em ver a avaliação como processo de crescimento intelectual do ser humano, que faz parte da permanente reflexão sobre a sua vida, a sua atividade cotidiana – progressos, retrocessos, erros e acertos -, constituindo, assim, um processo intencional, que se aplica a qualquer prática. É perceber a subjetividade humana em seu desenvolvimento integral e singular, na superação da concepção de avaliação enquanto cumprimento de padrões de conhecimento rigidamente preestabelecidos (LUCKESI, 1993; HOFFMANN, 2003; MORIN, 2003).

Dessa forma, exige do educador a tomada de decisão sobre que métodos e instrumentos que irá adotar no acompanhamento do desempenho dos alunos, buscando contemplar não só as diferenças e respeitar as suas potencialidades, mas também a sensibilidade, a cooperação e a humanidade inerente ao processo de aprendizado (HOFFMANN, 2003).

Para que isso ocorra, é preciso desenvolver um olhar atento sobre o educando, não só para as suas "respostas" comportamentais ou intelectuais, mas principalmente, o conhecimento da sua história, e, assim, poder compreender as condições concretas de sua existência. O princípio que deve nortear o processo de avaliação do estudante é: o que compreendeu? O que demonstra compreender? E, o que ainda não compreende? Assim, a avaliação se realiza em termos de acompanhamento permanente do processo de construção do pensamento do educando, enquanto desenvolvimento da aprendizagem e não enquanto aquisição de informações, mas principalmente a ação reflexiva, desafiando o aluno a refletir

sobre o não apreendido e os fatores que condicionam essa situação, e reformular seus conceitos e ações sobre aprendizagem.

3.9.2 A avaliação do desempenho

A avaliação é uma das atividades mais significativas e norteadoras do processo ensino-aprendizagem. Avaliamos e somos avaliados, continuamente, dentro e fora da escola, tanto formal como informalmente (DEPRESBITERIS, 2001).

Avaliar é observar e promover experiências educativas que sejam provocações intelectuais significativas no sentido do desenvolvimento do estudante. É, então, questionar, formular perguntas, propor tarefas desafiadoras, disponibilizando tempo, recursos e condições aos estudantes para a construção das respostas. Busca-se oferecer aos estudantes diversificadas oportunidades de pensar, buscar conhecimentos, engajar-se nas resoluções de problemas, reformular suas hipóteses, comprometendo-se com seus avanços e dificuldades (HOFFMANN, 2005).

O avaliar efetiva-se em um conjunto de procedimentos didáticos e se estende sempre por um longo tempo tal como se delineia um processo. Segundo Hoffmann (2005, p.13), "métodos e instrumentos de avaliação estão fundamentados em valores morais, concepções de educação, de sociedade, de sujeito. São essas as concepções que regem o fazer avaliativo e que lhe dão sentido".

A avaliação da aprendizagem envolve o educador/avaliador e o educando/avaliando. Considera-se a avaliação um ato dinâmico, de natureza processual, que precisa ser programado pelos envolvidos, favorecendo o processo de ensino-aprendizagem. Ocorre de modo co-participativo, no qual o professor e o estudante, cada qual assumindo o seu papel, comprometem-se com a construção do conhecimento e com a formação de um profissional competente (SÃO PAULO, 2004).

Avaliar a aprendizagem significa determinar as competências adquiridas por meio de aspectos quantitativos e qualitativos do comportamento humano. A área cognitiva inclui comportamentos de caráter intelectual, a área motora aborda os comportamentos que mais facilmente se evidenciam na prática, e a área afetiva aqueles comportamentos que denominamos atitudes, ideias, interesse e valores (BLOOM et al., 1993).

O processo de avaliar consiste essencialmente em determinar em que medida os objetivos educacionais estão sendo alcançados, objetivos estes propostos para promover mudanças no comportamento do estudante. Assim, enfatizamos que a avaliação deve se processar em função dos objetivos do curso (ZEFERINO; PASSERI, 2007).

Há três formas de avaliação, fundamentais em qualquer curso: diagnóstica, somativa e formativa. A avaliação diagnóstica tem como propósito constatar se os alunos possuem os conhecimentos básicos e imprescindíveis às novas aprendizagens; já a avaliação formativa compreendida como fonte de regulação dos processos de aprendizagem, ou seja, sua vocação é contribuir para as aprendizagens, pois permite a intervenção deliberada do professor, induzindo à regulação antecipada da aprendizagem em curso; e a avaliação somativa ou certificativa, cuja função é fazer um balanço das aquisições do estudante e decidir por sua aprovação ou não para etapas subsequentes do programa de ensino.

O Departamento de Enfermagem encontra-se em sua caminhada na busca pela construção do currículo integrado, orientado pela abordagem dialógica por competência, e, neste processo, é óbvio que o olhar para a avaliação exige um discernimento coerente onde estudantes, professores e unidades educacionais devem ser avaliados.

Uma avaliação apropriada deve servir para auxiliar a aprendizagem, medir o alcance individual e proporcionar informação para a implementação de um programa, expandindo a prática do professor, a organização da escola, o currículo, a participação da comunidade, as condições de trabalho, ou seja, tudo aquilo que interfere no processo de ensino-aprendizagem (VASCONCELOS, 2003).

Num currículo integrado e orientado por competência, segundo Hager, Gonczi, Athanasou (1994), a avaliação do processo ensino-aprendizagem pressupõe padrões integrados de maneira que haja aplicação e síntese do conhecimento, levando à integração da teoria e da prática.

Neste contexto, propomos que a avaliação aconteça no Curso de Graduação em Enfermagem ao longo do processo ensino-aprendizagem, que o professor estabeleça uma relação dialógica com os estudantes, promovendo o diagnóstico da situação particularmente vivenciada por cada indivíduo. E com isso, consiga avaliar a evolução dos estudantes no processo ensino-aprendizagem, bem como, a metodologia do ensino, com vistas à recuperação tanto do educando, quanto do ensino em tempo hábil.

Dessa forma, tomar-se-á por base um padrão mínimo de conhecimentos e habilidades a serem adquiridos pelos estudantes, de acordo com as competências da profissão. Para tanto, será assumido certo rigor científico e metodológico, no qual ensino e avaliação caminharão juntos e serão definidos conforme programas de conteúdos ou unidades a serem trabalhadas (LUCKESI, 2010).

Além disso, serão utilizadas como parâmetros para avaliação: a participação do educando em todo o processo (individualmente e em grupo); a realização de práticas crítico-reflexivas (seminários, estudos de casos e portfólios, dentre outros) a respeito de conteúdos teórico-práticos, com base nas realidades acolhidas por professores e estudantes; e a capacidade auto-avaliativa que propicie o crescimento profissional, sem considerar o resultado da auto-avaliação na avaliação docente, mas como um componente qualitativo que irá subsidiar a avaliação docente nos campos de prática e estágios curriculares.

Paralelamente, também será realizada aferição do conhecimento através de testes, exames ou provas, que terão por base conteúdos trabalhados em salas de aulas e cenários de práticas.

Aspectos padronizados pela instituição, tais como, frequência mínima de 75% e média final mínima de 60 pontos serão obedecidos. Estudantes que não conseguirem obter a pontuação mínima no componente teórico poderão realizar prova repositiva, com base na Resolução 251/CONSEPE/1997. O ensino prático, bem como sua avaliação será detalhado no item 3.9.3. No Estágio Curricular em Enfermagem, a avaliação do estudante será realizada pelos docentes envolvidos e preceptores (profissionais enfermeiros assistenciais/gerenciais) dos serviços de saúde.

Estudantes que não desenvolverem as competências e habilidades esperadas conforme instrumento de avaliação instituída durante o ensino prático/estágio, terão um acompanhamento especial para revisão de suas ações a fim de obter a pontuação mínima no componente prático, não sendo atingidos os critérios mínimos para aprovação o mesmo será considerado reprovado.

3.9.3 A prática como componente curricular

A prática profissional é estabelecida para permitir ao estudante qualificar seu processo de formação ao longo do curso. Nesse sentido, a prática profissional na UNIR pode

ser realizada tanto no ambiente interno da Instituição, quanto na comunidade, mas de forma que estabeleça interação com essa comunidade. O Estágio Supervisionado, obrigatório ou não obrigatório, é orientado pelos princípios metodológicos da Universidade e pela Lei nº 11788, de 25 de setembro de 2008.

Considerado ato educativo vivenciado no ambiente de trabalho, portanto em contato com a realidade social, econômica, ambiental e cultural. O ensino prático visa o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. (Art. 1º, parágrafo. 2º da Lei 11.788).

Com os eixos de integração colocamos o estudante em contato com o usuário numa progressão coerente do conhecimento, em suas expressões e fases evolutivas, enfocando o viver saudável, o respeito ao indivíduo no seu contexto cultural, sob a forma de Ensino Clínico.

Estes eixos integrativos associam conhecimentos da área básica com a específica, a teoria ao exercício prático, assegurando a presença de atividades práticas do primeiro ao oitavo períodos do curso, permeando toda a formação do enfermeiro, de forma integrada e interdisciplinar. Estas atividades práticas são denominadas Ensino Prático ou Ensino Clínico.

Estas disciplinas são desenvolvidas em três momentos que se interligam: o ensino teórico, o ensino teórico-prático e o ensino prático, correspondentes ao percentual equitativo de carga horária, que garantem a associação da aula teórica com a prática.

Esta estrutura das atividades de ensino não está dissociada da atividade de extensão e pesquisa, uma vez que as atividades práticas são realizadas em ambientes externos e prestando serviços à comunidade, expresso na execução de cuidados vinculados aos conteúdos programáticos, e este serviço prestado a comunidade gera um relatório que caracteriza a atividade de extensão ou de pesquisa.

Estas disciplinas assim estruturadas permitem através do ensino prático o desenvolvimento de atividades de análise crítica e aplicação do aprendizado teórico à prática. Inicialmente, o ensino prático aproxima o estudante dos usuários supostamente saudável, o escolar, o adolescente, o trabalhador e o idoso, ofertadas durante todo curso. No ensino prático mantemos o número de alunos por professor, respeitando as especificidades de cada setor dos serviços de saúde.

A avaliação do ensino prático das disciplinas do ciclo profissional será feita pelo somatório das notas de cada professor das respectivas disciplinas e divididas pelo quantitativo de docentes, incluindo também, as notas de trabalhos do Ensino Teórico-Prático e Prático, os quais podem ser apresentados sob forma de: estudos de caso, apresentação escrita e oral de relatórios científicos, dentre outros.

O ensino prático será desenvolvido inicialmente com usuários "sadios" ou nos laboratórios do Curso de Graduação em Enfermagem. O estudante adentra nos ambientes, nas unidades de saúde coletiva e de internação hospitalar, atendendo a clientela com possíveis agravos ou que necessita de proteção específica. O ensino prático - "o espaço formativo" - permite ao estudante concretizar o "treinamento" em situações reais, acompanhado por um docente que direciona e supervisiona seus "passos".

Neste "espaço formativo" o estudante adota comportamento de superação, busca um diálogo aberto com o professor, que adota uma postura de vigilância e incentivo, auxiliando na identificação de problemas, na busca por soluções, na incorporação de novas formas de agir adequadas ao exercício profissional.

O planejamento do ensino prático é amplamente discutido, cabendo ao professor e ao aluno organizar a atividade nos cenários compatíveis, a debater as práticas a serem executadas e a avaliação. Com esta dinâmica a cada semestre os cenários e as formas de ação podem ser alterados adequando-se aos problemas emergentes do contexto. O ensino prático é desenvolvido sob supervisão direta docente.

O ensino prático envolve o conhecimento do cenário e da clientela, a identificação dos problemas e as propostas de formas de intervenções. Com o desenvolvimento dos conteúdos de ensino prático há um preparo gradual do estudante para o estágio curricular supervisionado.

3.9.4 Ações implementadas em função dos processos de autoavaliação e de avaliação externa

O Curso de Graduação em Enfermagem da UNIR seguindo as avaliações do ENADE desenvolverá ações de caráter informativo e orientativo aos professores e alunos quanto aos menores índices de aproveitamento com o intuito de sanar as dificuldades descritas no documento ENADE e outros que se fizerem necessários seguindo às orientações do MEC. No

ano de 2010 o Curso de Graduação em Enfermagem da UNIR obteve na prova do ENADE o conceito cinco, no entanto, o conceito preliminar de curso foi quatro.

No que tange aos processos de autoavaliação, o curso elencará dispositivos aos docentes e alunos para avaliar o desempenho e as ações desenvolvidas no mesmo, seguindo as orientações do plano de desenvolvimento institucional da Fundação Universidade Federal de Rondônia.

No conjunto, esses processos avaliativos constituirão um sistema que permitirá a visualização integrada das diversas dimensões enfocadas pelos instrumentos aplicados, oferecendo elementos para a reflexão, análise e planejamento institucional, visando subsidiar o alcance dos objetivos estabelecidos pelo Curso de Graduação em Enfermagem.

3.9.5 Plano de acompanhamento de egresso

O Plano de Acompanhamento do Egresso (PAE) tem como objetivo caracterizar o perfil sociodemográfico e de formação do egresso do curso de graduação em enfermagem da UNIR e sua inserção no mercado de trabalho. Obter informações dos ex-alunos possibilita um feedback acerca do desempenho do curso, e obter subsídios para o desenvolvimento e adequação do currículo, e da oferta de cursos, em especial de pós-graduação, retroalimentando o processo e mudanças na formação.

Este plano permitirá ao DENF a composição de um banco de dados pessoais, acadêmicos e profissionais. Com isso poderá verificar a inserção dos ex-alunos no mercado de trabalho, obter indicadores confiáveis sobre a adequação dos conteúdos curriculares às necessidades do mundo do trabalho, conhecer propostas dos egressos para o Curso de Graduação em Enfermagem, sendo de grande importância na composição de novo currículo e para obter informações que orientem a implantação de cursos e programas de pós-graduação. O PAE será desenvolvido por meio das seguintes estratégias metodológicas:

- Criação do link “Egressos DENF/UNIR” e divulgação para os alunos ainda no processo de formação, no site do departamento (http://www.denf.unir.br/);

- Pesquisa de Acompanhamento do Egresso, por meio do Questionário do Egresso do Curso de Graduação em Enfermagem da UNIR (Apêndice 4) a ser aplicado durante dois anos consecutivos a partir do desligamento do acadêmico, sendo a periodicidade de aplicação

anual. O questionário será aplicado por meio virtual, disponibilizado no site do DENF/UNIR, respondido e enviado pelo egresso ao email do departamento (denf@unir.com.br);

- Análise quanti e qualitativa do material coletado, com disponibilização de resultados no link “Egressos DENF/UNIR”;

- Para fins de operacionalização do PAE são considerados egressos do DENF/UNIR os acadêmicos do curso de graduação que tenham colado grau, portanto, portadores do diploma de enfermeiro; desistentes, ou que abandonaram o curso e transferidos.

4 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO

4.1 Gestão administrativa e acadêmica do curso

Quadro 3 - Dados da Chefia e Vice Chefia do Departamento de Enfermagem

CHEFE **CPF**	DAIANA EVANGELISTA RODRIGUES CPF 700297252-91
E-MAIL **ENDEREÇO** **TELEFONE**	daianaunir@gmail.com Rua Principal, nº 460, casa 16, Bairro Novo Horizonte CEP 76810160, Porto Velho, RO (69) 9247 0127
TITULAÇÃO, A FORMAÇÃO, O PERFIL E A TUAÇÃO	Mestrado em Ensino em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Rondônia (2014). Especialização em Gestão de Serviços de Saúde pela Universidade Federal de Rondônia (2008), Graduação em Enfermagem pela Universidade Federal de Rondônia (2005), Atuou como enfermeira no Hospital Estadual de Pronto Socorro João Paulo II e na Unidade de Saúde da Família Meu Pedacinho de Chão no município de Porto Velho. Tem experiência na área de Enfermagem hospitalar, com ênfase em emergência e enfermagem médico-cirúrgico e na Estratégia de Saúde da Família. Atualmente, atua como docente no Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Rondônia.
VICE CHEFE **CPF**	MARIA DO SOCORRO BANDEIRA DE JESUS 115842113-34

E-MAIL ENDEREÇO TELEFONE	sbandeiraufro@gmail.com Rua Edson Granjeiro Filho, nº 4525. Bairro Agenor de Carvalho. Porto Velho-RO Fone Fixo (69) 3222 5484 Móvel: (69) 9252 9256
TITULAÇÃO, A FORMAÇÃO, O PERFIL E A ATUAÇÃO	Doutorado em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários pela Universidade Federal do Pará (2013), mestrado em Doenças Tropicais pela Universidade Federal do Pará (2002), especialização em Enfermagem em Saúde Comunitária pela Fundação Universitária de Apoio ao Ensino Pesquisa e Extensão (1985) e Graduação em Enfermagem e Obstetrícia (1982). Atuou como enfermeira supervisora na Clínica Santa Clara, na cidade de Campina Grande-PB; Enfermeira no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro e no Centro de Medicina Tropical de Rondônia (CEMETRON) em Porto Velho-RO. Tem experiência na área de enfermagem hospitalar com ênfase em Saúde do Adulto e Idoso, e de Saúde Coletiva com ênfase na Assistência em Doenças Infectocontagiosas. Atuou como chefe de enfermagem do ambulatório do CEMETRON e Coordenadora dos Programas de Tuberculose e Hanseníase do CEMETRON. Atualmente, atua como Professora adjunta do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Rondônia.

4.1.1 Composição do núcleo docente estruturante do curso de graduação em enfermagem da UNIR

O NDE é o órgão consultivo, responsável pela concepção do PPC e tem por finalidade, sua atualização e revitalização. Foi criado pela Portaria nº 030/NUSAU de 16 de abril de 2014, pelo período 09/04/2014 a 08/04/2017, composto pelas titulares: Profª. Msc. Mônica Pereira Lima Cunha, Profª. Drª. Rosely Valéria Rodrigues, Profª. Drª. Maria do Socorro Bandeira, Profª. Drª. Kátia Fernanda Alves Moreira e Profª. Msc. Daniela Oliveira Pontes. E as suplentes: Profª. Msc. Priscilla Perez da Silva Pereira, Profª. Msc. Daiana Evangelista Rodrigues Fernandes, Profª. Esp. Adriana Tavares Hang e Profª. Msc. Sônia Dias Lima.

Atribuições do NDE: PPC definindo sua concepção e fundamentos, de acordo com as diretrizes emanadas do CNE e do MEC; estabelecer o perfil profissional do egresso do curso; atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso de graduação em enfermagem; conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no colegiado de curso, sempre que necessário; supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso definidas pelo regimento da UNIR; analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos estabelecidos pelas DCN para o ensino de enfermagem e o PPC; indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências de mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso; zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no currículo.

4.1.2 Corpo Docente

Os quadros 5 e 6 apresentam os dados pessoais, de formação, regime de trabalho, atuação no curso e experiência profissional dos docentes lotados no departamento de enfermagem que totalizam 18 docentes. Considerando a carga horária total que cada docente deve cumprir e a necessidade de reserva técnica para atender os afastamentos legais, faz-se necessário um total de 32 professores.

Quadro 4 - Relação dos docentes do Departamento de Enfermagem da UNIR, dados pessoais, formação e regime de trabalho.

Nome completo	CPF	E-mail	Tel. (69)	Titulação máxima	Função - Docente Docente/ Tutor	Regime de trabalho (integral – DE ou T40) (parcial - T20)	Vínculo empregatício - Estatutário CLT Outros
1. Adriana Tavares Hang	656.657.082-91	adrikkas@hotmail.com	9231 1291	Especialista	Docente	DE	Estatutário
2. Adriana Dias Silva	870.138.194-68	adsdias@hotmail.com	81216806	Mestre	Docente	T 20	Estatutário
3. Aldrin de Sousa Pinheiro	796764302-00	drin.guajara@gmail.com	92686607	Mestre	Docente	DE	Estatutário
4. Daniela Ferreira Borba Cavalcante	735178522-87	danielaferreiraborba@yahoo.com.br	92014143	Especialista	Docente	DE	Estatutário
5. Daniela Oliveira Pontes	001.935.481-94	danielaopontes@hotmail.com	9214-8815	Mestre	Docente	DE	Estatutário
6. Daiana Evangelista Rodrigues Fernandes	70029725291	daianaunir@gmail.com	9247-0127	Mestre	Docente	DE	Estatutário
7. Cristiano Lucas de Menezes Alves	08877105739	Cristiano.alves@gmail.com	8151-5085	Graduação	Docente	DE	Estatutário
8. Elen Petean	02850975125	elenpetean@yahoo.com.br	84897385	Mestre	Docente	DE	Estatutário
9. Fabíola Mara Gonçalves de Siqueira Amaral	696774921-87	bilamt@hotmail.com	8464-8993 3225-1376	Especialista	Docente	DE	Estatutário
10. Katia Fernanda Alves Moreira	331136104-00	katiaunir@gmail.com	8421-4440	Doutor	Docente	DE	Estatutário

11. Jeanne Lúcia Gadelha Freitas	28550110353	jeannegadelha@yahoo.com.br	92071071 81314550 99747596	Doutor	Docente	DE	Estatutário
12. Maria do Socorro Bandeira de Jesus	11584211334	sbandeiraufro@gmail.com	3222 5484 9252 9256	Doutor	Docente	DE	Estatutário
13. Mauricio Viana Gomes de Oliveira	78505593200	mauricio.unir@gmail.com mauricio_enf@hotmail.com	81000877	Mestre	Docente	DE	Estatutário
14. Mônica Pereira Lima Cunha	51870746287	monicapl@bol.com.br	84313370	Mestre	Docente	DE	Estatutário
15. Priscilla Perez da Silva Pereira	01417799692	Priperez83@gmail.com	9258 6851	Mestre	Docente	DE	Estatutário
16. Soraya Nedeff De Paula	373921900-91	soraya_nedeff@hotmail.com	9981-1500	Doutor	Docente	DE	Estatutário
17. Sonia Maria Dias De Lima	42530369453	sdlima43@yahoo.com.br	99813541	Mestre	Docente	T 40	Estatutário
18. Vivian Susi de Assis Canizares	534841779-34	viviansusi@yahoo.com.br	92297646	Doutor	Docente	DE	Estatutário

Quadro 5 - Relação dos docentes do Departamento de Enfermagem da UNIR, atuação no curso e experiência profissional.

Nome e SIAPE	Depto. de origem	Disciplina que ministra no Curso	Experiência Profissional, excluída as atividades de magistério. (anos)	Experiência no exercício da docência na educação básica. (anos)	Experiência de magistério superior (anos)	Link do Currículo Lattes

Adriana Tavares Hang SIAPE 2078783	DENF	Enfermagem ao Adulto e Idoso I Enfermagem ao adulto e idoso em doenças tropicais Semiologia e Semiotécnica de enfermagem	11 anos	2 anos curso técnico	6 anos	lattes.cnpq.br/5774396688106275
Adriana Dias Silva SIAPE 2352214	DENF	Enfermagem em Saúde da Criança Enfermagem em Saúde Mental	20 anos	03 anos	08 anos	lattes.cnpq.br/0529388486637904
Aldrin de Sousa Pinheiro SIAPE 2147796	DENF	Enfermagem ao adulto e idoso em doenças tropicais Estagio Supervisionado em Enfermagem I e II	7 anos Vigilância em saúde; Pronto socorro, UTI, gestão, doenças infectocontagiosas e parasitárias.	1 ano curso técnico	3 anos	http://lattes.cnpq.br/4459817564560167
Daniela Ferreira Borba Cavalcante SIAPE 2147530	DENF	Enfermagem ao Adulto e Idoso I Enfermagem à Saúde da Mulher Enfermagem em Saúde Coletiva Administração em enfermagem II	7 anos		5 anos	lattes.cnpq.br/1033266282433249
Daniela Oliveira Pontes SIAPE 1485523	DENF	Tópicos em enfermagem III (Matemática aplicada a Enfermagem) Semiologia e Semiotécnica de enfermagem Enfermagem ao Adulto e Idoso II Estagio Supervisionado em Enfermagem I e II	Saúde da Família (1ano e 4meses) Centro de material e esterilização (8meses)		9 anos	lattes.cnpq.br/8199201715655441

Daiana Evangelista Rodrigues Fernandes SIAPE 76810160	DENF	Enfermagem à Saúde da Mulher Enfermagem em Saúde Coletiva Administração em enfermagem I e II	Saúde da Família (6 anos); Pronto Socorro (1 ano); Centro Cirúrgico (6 anos);		> 1 ano	lattes.cnpq.br/4735533503754813
Cristiano Lucas de Menezes Alves SIAPE 1523776	DENF	Enfermagem ao Adulto e Idoso II Enfermagem ao adulto e idoso em doenças tropicais Introdução a Saúde Coletiva Semiologia e Semiotécnica de enfermagem	Pronto Socorro João Paulo II - 2 anos Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena 1 ano		8 anos	buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4771359Z7
Elen Petean SIAPE 2078739	DENF	História, legislação e ética de Enfermagem Enfermagem à Saúde da Mulher Enfermagem ao Adulto e Idoso II Teorias e processos de enfermagem Enfermagem em Saúde Coletiva Administração em enfermagem II			> 1 ano	lattes.cnpq.br/0771767703903083
Fabíola Mara Gonçalves de Siqueira Amaral SIAPE 2887433	DENF	Enfermagem à Criança e Adolescente Enfermagem em Saúde Mental	9 anos		1 ano	lattes.cnpq.br/0882879624402523
Katia Fernanda Alves	DENF	Introdução à Saúde Coletiva;	8 anos		25 anos	lattes.cnpq.br/37247488389

Moreira SIAPE 0396825		Enfermagem em Saúde Mental Enfermagem em Saúde Coletiva Estágio Supervisionado I e II Metodologia da pesquisa em saúde e na enfermagem; Trabalho de conclusão de curso				46483
Jeanne Lúcia Gadelha Freitas SIAPE 2352305	DENF	Enfermagem à Criança e Adolescente Metodologia da pesquisa em Enfermagem Trabalho de Conclusão de Curso Enfermagem ao Adulto e Idoso II Estágio Supervisionado I Administração em enfermagem I	14 anos	16 anos	12 anos	lattes.cnpq.br/6524062621786289
Maria do Socorro Bandeira de Jesus SIAPE 1149830	DENF	Enfermagem ao adulto e idoso em doenças tropicais Estágio Supervisionado I e II Administração em enfermagem II	10 anos	3 anos	19 anos	http://lattes.cnpq.br/7616259998453983
Mauricio Viana Gomes de Oliveira SIAPE 1974199	DENF	Enfermagem ao adulto e idoso em doenças tropicais Enfermagem em Saúde Mental Epidemiologia	---------	--------	18 meses	http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4742429D0
Mônica Pereira Lima Cunha SIAPE 2440330	DENF	Enfermagem à Saúde da Mulher Estagio Supervisionado II Teorias e processos de enfermagem	10 anos	--------	8	http://lattes.cnpq.br/7304754015970927
Priscila Perez da Silva Pereira	DENF	Teorias e processos de enfermagem Semiologia e Semiotécnica	1 ano e 8 meses	1 ano e 6	4 anos	http://lattes.cnpq.br/4795413903156030

SIAPE 1825696		de enfermagem Enfermagem à Saúde do Adulto e Idoso I Estágio Supervisionado I		meses		
Soraya Nedeff De Paula SIAPE 0396609	DENF	Administração em Enfermagem II Enfermagem ao adulto e idoso em doenças tropicais Enfermagem ao adulto e idoso II Estagio Supervisionado I	7 anos	--------	26 anos	http://lattes.cnpq.br/7532356627244185
Sonia Maria Dias De Lima SIAPE 3135384	DENF	Enfermagem à Saúde do Adulto e Idoso I Enfermagem à Saúde do Adulto e Idoso II Enfermagem ao adulto e idoso em doenças tropicais Estagio Supervisionado I	Vigilância Em Saúde - 17 Anos Área Hospitalar Pediatria e Berçário07 Anos UBS 10 Anos	--------	14 anos 1 ano na Tutoria Fiocruz	http://lattes.cnpq.br/6999803505111304
Vivian Susi de Assis Canizares SIAPE 0396690	DENF	Teorias e processos de enfermagem Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem Estágio Supervisionado II Adullto e Idoso I Adulto e Idoso II Enfermagem à Saúde da Mulher	Maternidade, Sala de Parto e Berçário – 2anos Clínica Médico Cirúrgica – 1 ano UBS – 2 anos	--------	24 anos	http://lattes.cnpq.br/6847087990177030

4.2 Recursos humanos

4.2.1 Corpo discente

Atualmente o Curso de Graduação em Enfermagem tem 82 alunos regularmente matriculados. Os discentes em condições de vulnerabilidade social e econômica, e regularmente matriculados contam com diversos auxílios que visam à permanência deles na IES. A UNIR dispõe das seguintes ações:

Auxílio alimentação - São ofertados 500 auxílios, válidos por um ano, podendo ser renovado durante toda a graduação, no valor de R$ 132,00 mensais. Dos alunos matriculados no Curso de Graduação em enfermagem, 19 (23%) recebem esse benefício.

Auxílio transporte - O auxilio transporte é o auxilio financeiro pago, para subsidiar as despesas com transporte dos discentes. São ofertados 500 auxílios, válidos por um ano, podendo ser renovado durante toda a graduação, no quantitativo de 40 créditos mensais, 18 alunos (22%) recebem esse benefício.

Auxílio moradia - São ofertados 100 auxílios, válidos por um ano, podendo ser renovado durante toda a graduação, no valor de R$ 250,00 mensais. Atualmente cinco (5) alunos (6%) recebem esse benefício.

Auxílio permanência - São ofertados 150 auxílios, válidos por um ano, podendo ser renovado durante toda a graduação, na quantia de R$ 400,00 mensais. No Curso de Graduação em Enfermagem atualmente dois alunos (2%) recebem esse benefício.

Auxílio creche - O auxilio creche é o auxilio financeiro pago, para subsidiar as despesas com transporte dos discentes em condições de vulnerabilidade social e econômica com filhos ou menores sob guarda ou tutela com idade até cinco anos e 11 meses. Atualmente são ofertados 80 auxílios, válidos por 1 ano, podendo ser renovado durante toda a graduação, no valor de R$ 200,00 mensais. Dois alunos (2%) recebem esse benefício.

4.2.3 Técnicos administrativos

O DENF atualmente não possui técnicos administrativos em seu quadro de lotação. Para que a coordenação do Curso de Graduação em Enfermagem possa ser exercida com maior eficiência e presteza é imprescindível que seja disponibilizada no

mínimo uma vaga de técnico administrativo para o departamento. Em relação aos técnicos de laboratório atualmente o DENF conta com três, conforme a descrição a seguir:

Quadro 6 - Relação dos técnicos de laboratório do DENF/UNIR.

	NOME	**FORMAÇÃO/ ANO**	**DATA INGRESSO UNIR**
01	Núbia Cristina Marques	Graduação em Enfermagem / 2009	13/02/2014
02	Kelly Maria Barros de Alencar	Técnico em Enfermagem / 2006 Graduação em Enfermagem / 2012	30/04/2014
03	Raimunda da Silva	Técnica em Enfermagem	

5 INFRAESTRUTURA

5.1 Descrição da estrutura administrativa do curso

O Curso de Graduação em Enfermagem possui sua estrutura administrativa conforme previsto no Regimento Geral e Estatuto da UNIR. Assim, o departamento de enfermagem congrega, conforme descrito no Art. 25 do Estatuto da UNIR, docentes responsáveis, dentro da própria área de conhecimento, pelas atividades de ensino de graduação e pós-graduação dos diversos cursos ofertados pela instituição, pelas atividades de pesquisa e extensão.

O departamento de enfermagem é administrado conforme o Art. 26 do Estatuto da Universidade, conforme descrito a seguir:

- em nível executivo, pelo Chefe de Departamento;

- em nível deliberativo, pelo Conselho de Departamento;

De acordo com o Regimento Geral da UNIR no Art. 40. o chefe de departamento de enfermagem e seu vice-chefe são eleitos pelo Conselho de

Departamento, com precedida consulta à comunidade do Curso de Graduação em Enfermagem, com mandato de dois anos, permitida a recondução.

Ao Conselho do Departamento de Enfermagem compete o descrito no regimento Geral da UNIR na Seção IV Art. 41:

- deliberar sobre as propostas de políticas e diretrizes do departamento, em consonância com as políticas e orientações dos conselhos superiores;

- deliberar sobre propostas de desenvolvimento didático, científico e administrativo dos docentes lotados no departamento;

- deliberar sobre atribuições de encargos de ensino, pesquisa e extensão ao pessoal docente e técnico-administrativo lotado no departamento;

- deliberar, em seu nível, sobre questões referentes à vida funcional dos docentes;

- declarar vago o cargo de chefe de departamento;

- deliberar sobre propostas e normas relativas à monitoria;

- deliberar sobre escala de férias do pessoal docente e técnico-administrativo lotado no departamento;

- propor ações para a melhoria da qualidade do ensino;

- estabelecer medidas de acompanhamento e avaliação de execução dos planos de trabalho do pessoal docente e técnico-administrativo;

- emitir parecer sobre o oferecimento dos cursos de pós-graduação "*lato*" e "*stricto sensu*" encaminhando-o ao Conselho de Campus ou Núcleo correspondente;

- deliberar sobre a compatibilização dos programas, cargas horárias e planos de ensino das disciplinas da estrutura curricular dos cursos a ele vinculados com o perfil do profissional objetivado pelo curso;

- deliberar sobre mudanças nas políticas do departamento;

- propor sistemas de seleção e avaliação de discentes e de acompanhamento do desempenho profissional dos docentes;

- acompanhar a vida acadêmica dos discentes, especialmente no que se refere à integralização de currículos;

- promover programas de orientação dos candidatos ao processo seletivo no que se refere ao campo profissional do curso;

- deliberar quanto aos aspectos da vida acadêmica do discente;

- acompanhar a execução do currículo quanto a diretrizes e objetivos do curso, avaliando, controlando e verificando as relações entre as diversas disciplinas e propondo as medidas cabíveis;

- analisar e avaliar os resultados obtidos pela estrutura curricular definidora do perfil profissional;

- acompanhar a execução das normas e procedimentos referentes ao aproveitamento de estudos;

- organizar e elaborar a programação acadêmica do calendário acadêmico específico e do horário das aulas;

- deliberar sobre solicitação de vaga e aproveitamento de disciplinas oriundas de outras instituições;

- deliberar sobre recursos e representações de discentes, em matéria didática e disciplinar;

- propor ao Campus ou Núcleo os currículos dos cursos a ele vinculados, bem como as alterações curriculares;

- iniciar e instruir processo de destituição de coordenador de curso de pós-graduação ou de projeto especial e encaminhar ao Conselho de Campus ou Núcleo para deliberação;

- declarar vago o cargo de Coordenador de Pós-Graduação e de Coordenador de Projeto Especial;

- desenvolver outras atribuições que lhe forem atribuídas por força da legislação vigente.

Parágrafo único. Das decisões do Conselho de Departamento cabe recurso ao Conselho de Campus ou Núcleo.

As competências do chefe do Departamento de Enfermagem são previstas no Regimento Geral da UNIR, Art. 42, conforme a seguir:

- cumprir e fazer cumprir as deliberações do CONDEP;

- convocar, estabelecer pauta, presidir e providenciar os registros das reuniões do CONDEP;

- elaborar e submeter ao CONDEP o Plano de Ação do Departamento;

- decidir, nos casos de urgência, "ad referendum" do CONDEP, devendo submeter sua decisão à apreciação deste, em reunião extraordinária realizada no prazo máximo de setenta e duas horas;

- fazer cumprir os Planos de Atividades dos docentes e técnicos lotados no Departamento;

- designar banca de revisão de prova dos discentes quando solicitado pelo CONDEP;

- propor ao CONDEP normas e critérios para monitoria;

- executar ações com vistas à melhoria da qualidade do ensino;

- acompanhar e controlar a frequência e o aproveitamento dos docentes em cursos de pós-graduação;

- coordenar os cursos de graduação e pós-graduação sendo-lhe facultado o direito de indicar os assessores para tal função;

- desenvolver outras atribuições que lhe couberem por força da legislação vigente;

- manter controle didático-pedagógico das disciplinas do curso, respeitando os objetivos explícitos nas propostas pedagógicas do Departamento e da UNIR;

- orientar os discentes quanto aos aspectos de sua vida acadêmica;

- solicitar à Direção do Campus ou Núcleo respectivo, assessoramento didático-pedagógico.

Parágrafo único. Dos atos do Chefe de Departamento cabe recurso ao CONDEP.

As atribuições do Conselho do Departamento de Enfermagem atendem ao referido no Estatuto Geral da UNIR ,no Art. 27, é o órgão consultivo e deliberativo e compõe-se:

- de todos os docentes lotados no departamento;

- de representantes estudantis, na proporção estabelecida em lei, matriculados regularmente nos cursos vinculados ao departamento, com mandato de um ano, permitida a recondução;

- e representante dos técnico-administrativos.

§ 1º A Presidência e Vice-Presidência do Conselho Departamental serão exercidas, respectivamente, pelo Chefe e Sub-Chefe do Departamento.

§ 2^0 O presidente tem direito ao voto de qualidade.

§ 3º Nas ausências ou impedimentos do Presidente e do Vice-Presidente, a Presidência será exercida pelo membro docente do departamento mais antigo na carreira do magistério superior da UNIR.

§ 4º O voto dos professores visitantes e substitutos tem peso de 50% (cinquenta por cento) dos votos dos docentes da carreira do magistério superior lotados no departamento.

O Curso de Graduação em Enfermagem possui comissões que visam apoiar CONDEP/DENF e chefia de departamento na organização administrativa bem como na tomada de decisões. Estas comissões são:

- Comissão de Avaliação de Programa de Disciplina: visa avaliar os programas de disciplinas à luz dos conteúdos propostos no PPC, a filosofia do Curso de Graduação em Enfermagem e a realidade regional de campos de prática e de processo de trabalho da enfermagem;

- Comissão de Progressão Funcional: visa orientar os professores e o CONDEP/DENF quanto aos processos de progressão funcional;

- Comissão de Monitoria: promove a seleção e acompanhamento de monitores para os laboratórios de: semiologia e semiotécnica da enfermagem, e materno infantil e saúde pública;

- Comissão de Laboratórios: visa organizar os laboratórios de semiologia e semiotécnica da enfermagem, e materno infantil e saúde pública no que se refere à infraestrutura; previsão de materiais; elaborar regulamentos normas e rotinas; fomentar o ensino; pesquisa e extensão; e orientar e supervisionar as atividades dos técnicos em laboratório;

- Comissão de Avaliação de Projetos: visa orientar os professores do departamento na elaboração de projetos institucionais bem como apoiar o CONDEP/DENF na avaliação e aprovação dos mesmos por meio de pareceres com recomendações;

- Comissão de Estágio: objetiva estreitar os laços entre o Curso de Graduação em Enfermagem e campos de prática na atenção primária, secundária e terciária.

Atualmente os laboratórios do Curso de Graduação em Enfermagem contam com duas técnicas de laboratório responsáveis por cumprir e fazer cumprir os regulamentos, normas e rotinas instituídas pela Comissão de Laboratório/Departamento de

Enfermagem; zelar pelos bens permanentes e de consumo dos laboratórios; preparar o ambiente físico e dispor os materiais para as aulas/atividades previamente agendadas; auxiliar o docente durante o transcorrer das aulas práticas; acompanhar, presencialmente, todas as atividades dos discentes dentro dos laboratórios; manter o ambiente limpo e organizado; utilizar e orientar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI); fazer controle de estoque e, informar ao Coordenador do Laboratório a necessidade de aquisição de algum material, antes de seu término; fazer levantamento patrimonial anualmente e realizar o controle dos bens dos laboratórios; fazer previsão anual de compra de materiais e insumos; dar suporte aos alunos em momentos de treinamentos individuais.

5.2 Descrição do suporte administrativo do núcleo

O suporte administrativo do Curso de Graduação em Enfermagem é proveniente NUSAU, o qual congrega os departamentos dos Cursos de Enfermagem, Medicina, Educação Física e Psicologia, atualmente (julho de 2014) o núcleo conta com 86 docentes ativos com graduação na área da saúde. O NUSAU é responsável pela coordenação das funções de ensino, pesquisa e extensão, tanto em termos de planejamento quanto de execução e avaliação.

A Secretaria do NUSAU é composta atualmente, por dois servidores e uma estagiária. As atribuições da secretaria de núcleo encontram-se dispostas no artigo 12 da Resolução nº 011/CONSAD, de 25 de abril de 2001, que são:

- Prestar apoio na elaboração e revisão de textos oficiais;
- Prestar apoio logístico na realização de encontros seminários e eventos sociais;
- Distribuir os expedientes recebidos aos órgãos vinculados ao Núcleo;
- Arquivar os expedientes recebidos após serem despachados pelo Diretor do Núcleo;
- Enviar aos Conselheiros do Conselho de Núcleo a convocação de reunião;
- Participar da Reunião dos Conselhos de Núcleo;
- Preparar a pauta da reunião dos Conselhos de Núcleo;
- Colaborar na elaboração de planos de Ação do Núcleo;

- Executar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Diretor do Núcleo.

O Conselho do Núcleo de Saúde, segundo a Resolução nº 011/CONSAD de 25 de abril de 2001, obedece a seguinte composição:

- do diretor, seu presidente;

- dos Chefes de Departamentos, diretamente integrados ao Núcleo (Departamentos de Enfermagem, Medicina, Educação Física, Psicologia e Saúde Coletiva);

- de três representantes dos coordenadores de projetos especiais e de pesquisa, vinculados ao Núcleo, escolhido por seus pares; (atualmente, compõem os representantes do Centro de Pesquisa em Saúde Coletiva (CEPESCO); Mestrado Profissional em Ciências da Saúde; e Mestrado Acadêmico em Psicologia;

- de representantes estudantes, na forma da lei, dos cursos de graduação e pós-graduação;

- de dois representantes docentes, eleitos pelos seus pares, com mandato de dois anos, permitida a recondução – atualmente preenchidas por duas docentes do Curso de Graduação em Enfermagem;

- de um representante da comunidade com mandato de dois anos, eleitos pelos membros do próprio Conselho, sendo permitida a recondução (atualmente vaga em aberto);

- de um representante dos técnicos administrativos, com mandato de dois anos, permitida a recondução.

A atividade decisória do NUSAU ocorre conforme a Resolução nº 011/CONSAD de 25 de abril de 2001 de duas formas: via executiva, por meio dos atos do Diretor; via deliberativa, por meio do Conselho de Núcleo de Saúde. A matéria é distribuída a um relator (dentre os membros do Conselho), que apresenta parecer na reunião do Conselho, que depois de deliberada, é encaminhada aos setores competentes.

Até o mês de julho de 2014, existe no CONSAU uma Comissão permanente, em decorrência de disposição regimental - Comissão de Estágio Probatório. As comissões especiais são constituídas mediante as demandas necessárias.

5.3 Equipamentos e laboratórios

A UNIR conta 21 laboratórios da área da saúde. O uso dos laboratórios baseia-se em alguns princípios normativos: a) organização de núcleos ativos de pesquisa e sua relação com a pós-graduação em disciplinas específicas; b) a presença de pesquisadores com capacidade de conduzir autonomamente programas de pesquisa; c) a valorização social das atividades de desenvolvimento do conhecimento ao longo prazo. Os laboratórios são:

- Laboratório de Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem;
- Laboratório Materno-Infantil;
- Laboratório de Habilidades Clínicas;
- Laboratório de Anatomia;
- Laboratório Anatomopatológico Anatomia, Patologia e Medicina Legal;
- Laboratório de Técnica Cirúrgica Cirurgia Geral;
- Laboratório de farmacologia;
- Laboratório de Microbiologia e Parasitologia Bioquímica, Microbiologia e Parasitologia;
- Laboratório de Bioquímica e Imunologia;
- Laboratório de Bioquímica e Produtos Naturais;
- Laboratório de Química (Produtos naturais);
- Laboratório de Biologia (Microscopista);
- Laboratório de Geoquímica;
- Laboratório de Morfologia Anatomia Patologia Medicina Legal;
- Laboratório de Histologia e Citologia;
- Laboratório Planejamento Ambiental e Desenvolvimento Regional;
- Laboratório de Biogeoquímica Ambiental Wolfgang Christian Pfeiffer;
- Laboratório de Psicologia Experimental;
- Laboratório de Fisiologia do Exercício;
- Centro de Estudos e Laboratório de Aptidão Física;
- Laboratório de Fisiologia;
- Laboratório de Habilidade Clínicas.

O Curso de Graduação em Enfermagem dispõe de dois laboratórios para suas aulas práticas do tronco profissional, que são: laboratório de semiologia e semiotécnica de enfermagem (LABSEMIO) desde 1.990, situado no térreo do Bloco 2K e o laboratório materno-infantil (LABSMATI) desde 2006, localizado no 1° piso do Bloco 2K, ambos no Campus José Ribeiro Filho. Possuem iluminação adequada, centrais de ar condicionado e extintores de incêndio próximos.

O LABSEMIO conta com materiais didático-pedagógicos que são utilizados nas aulas práticas de diversas disciplinas do tronco profissional da Enfermagem. Possui três salas e um pequeno corredor de passagem com as respectivas metragens:

- Sala 1: 5,86 x 5,25 – totalizando aproximadamente 30,76 m2;
- Sala 2: 2,85 x 4,26 – totalizando aproximadamente 12,14 m2;
- Sala 3: 5,86 x 5,25 – totalizando aproximadamente 30,76 m2;
- Corredor: 2,85 x 1,15 – totalizando aproximadamente 3,27 m2.

Nas salas um e três estão disponibilizados mobiliário hospitalar como cama, mesa de cabeceira, cadeira, suporte para soro, mesa auxiliar, carrinhos de curativos além de modelos anatômicos e bonecos específicos para o aprendizado das técnicas de enfermagem. Existem ainda armários devidamente fechados para o armazenamento de materiais de consumo hospitalar, EPI, instrumentais e materiais de consumo utilizados nas atividades práticas. Nestas salas existem pias com dispensador de sabonete líquido e papel toalha para a lavagem das mãos. Estão disponíveis para utilização durante as práticas 40 cadeiras empilháveis.

A sala dois, para apoio técnico do laboratório, contém uma bancada para computadores com acesso à internet, e prateleiras para armazenamento dos materiais de consumo uso hospitalar. No corredor do laboratório, existem dois armários fechados para a guarda de medicamentos e álcool. Também estão disponíveis neste local um frigobar e um bebedouro.

O LABSMATI dispõe de instrumentais e simulares, assim como materiais didático-pedagógicos voltados para o aprendizado de técnicas relacionadas à Enfermagem à Saúde da Criança e Adolescente, Enfermagem à Saúde da Mulher e Enfermagem em Saúde Coletiva. O laboratório possui duas salas com as seguintes

metragens: Sala um: 5,85 x 5,12 – totalizando 29,95 m^2 e Sala dois: 5,12 x 2,87 – totalizando 14,69 m^2.

A sala um do LABSMATI possui mobiliário hospitalar para gestante/parturiente, recém-nascido e criança, modelos obstétricos e pediátricos, instrumentais, materiais diversos para realização de educação em saúde, além de armários para a guarda do material, mesas e cadeiras. Também possui central de ar condicionado e extintores de incêndio. Este laboratório permite o ensino-aprendizagem de situações específicas de atuação do enfermeiro como realização do pré-natal, coleta de material para preventivo de colo uterino, acompanhamento do trabalho de parto e parto, cuidados ao recém-nascido, assistência ao crescimento e desenvolvimento da criança, entre outras. A sala dois serve como sala de apoio às atividades do técnico em laboratório e possui mesas, cadeiras, armários, frigobar, bebedouro e dois computadores com acesso à internet.

A prática em laboratório é um recurso instrucional potencialmente válido de apoio às atividades práticas, pois permite aos alunos desenvolverem as habilidades necessárias para o seu exercício profissional, como destreza manual, segurança, habilidades psicomotoras cognitivas e afetivas. O uso do laboratório, enquanto estratégia de ensino é sem dúvida fundamental, pois permite ao aluno melhores condições para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem e consequentemente, melhora da qualidade na prestação da assistência, quando da realização do ensino prático nas disciplinas do ciclo profissional. Neste aspecto, ressalta-se que o LABSEMIO e o LABSMATI dispõem de simuladores pedagógicos insuficientes para garantir o desenvolvimento das habilidades práticas. Faz-se necessário ao curso de enfermagem contar com o apoio pedagógico do Laboratório de Habilidades Clinicas, vinculado ao departamento de Medicina, que dispõe de seis salas e 53 manequins de baixa e alta fidelidade que são capazes de simular pacientes em diversas situações clínicas e com diferentes necessidades.

Outro aspecto importante a ser ressaltado, é que ao permitir maior contato dos alunos com materiais, equipamentos de uso constante na práxis, e a execução repetida de alguns procedimentos, espera-se que ocorra uma diminuição do nível de estresse dos alunos e professores, no desenvolvimento das atividades de ensino prático.

5.4 Biblioteca

A biblioteca central da UNIR tem natureza científica, cultural e técnica e compreende a Biblioteca Roberto Duarte Pires (em Porto Velho) e seis Bibliotecas Setoriais dos *Campi*. O horário de funcionamento é das 8h às 22h. Atualmente, a diretoria do Sistema de Bibliotecas da UNIR é composta por duas bibliotecárias e uma equipe técnica de oito bibliotecárias e duas estagiárias.

O quadro funcional da Biblioteca Central "Prof. Roberto Duarte Pires" é composto por 18 servidores, conta com 3.270,12m², salas de estudo em grupo, sala de treinamento, cabines de estudo individual, área de leitura, acervos geral, de coleção especial e de periódicos, além de guarda-volumes e espaço para pesquisa na internet. Oferece 487 assentos com 121 mesas e 20 cabines de estudo individual e sete salas de estudo em grupo com um acervo de geral de 99.089 bibliografias e sistema de comutação. Foram realizados em 2013, 62.794 empréstimos dos títulos bibliográficos.

A Biblioteca Central possui aproximadamente 33.000 mil títulos nas áreas da saúde e ciências sociais, sendo Ciências da Saúde 5.687 exemplares, Ciências Biológicas 2.899 exemplares, Ciências Sociais e Aplicadas 30.510 exemplares e Ciências Ambientais 748 exemplares. Em relação aos periódicos, possui 14 fascículos da área das Ciências da Saúde, quatro das Ciências Biológicas e 87 fascículos e periódicos das Ciências Sociais Aplicadas.

O número de periódicos é pequeno, mas tal deficiência é compensada com o acesso irrestrito ao portal da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES) e o funcionamento da Biblioteca Digital que pode ser utilizado pelos acadêmicos e professores do Curso de Graduação em Enfermagem. A UNIR possui aceso ao portal CAPES, com possibilidade de uso em qualquer computador, da instituição, interligado à rede.

5.5 Infraestrutura básica utilizada no ensino

O Curso de Graduação em Enfermagem possui cinco salas de aulas climatizadas com 30 cadeiras e mesas, uma mesa com cadeira para o professor e quadro branco.

São disponibilizados três laboratórios de informática com as seguintes dimensões: 122,720 m^2, 45,00 m2, 45,00 m^2. Estes laboratórios possuem cada um, 15 computadores e atendem aos cursos de pós-graduação e graduação. Encontra-se em construção o laboratório de informática do NUSAU com recursos do Pró-saúde. Os recursos teleinterativos disponíveis na UNIR são a Plataforma Moodle, a web conferência e a videoconferência.

Possui sala da pós-graduação e de apoio aos projetos de pesquisa e extensão metragem de 5,12 x 2,87m^2, com área total de 14,69 m^2 e situa-se no 1º piso do Bloco 2K. Nela encontram-se mesas, cadeiras, armários e um computador com acesso à internet. É utilizada para a realização da parte administrativa dos cursos de especialização, residência e futuramente pós-graduação *strictu sensu*. Também serve de apoio para os projetos de pesquisa e extensão realizados por docentes lotados no Departamento de Enfermagem juntamente com os alunos do referido curso.

O CEPESCO é um centro de pesquisa do Departamento de Enfermagem vinculado ao CNPq e institucionalizado na UNIR desde 2002. Tem como principal objetivo promover e realizar pesquisas e extensão, por uma equipe de trabalho multiprofissional na área da Saúde Coletiva. Sua estrutura física contempla uma sala de convivência, salas de reuniões, uma secretaria, um laboratório de informática, dois banheiros e uma copa cozinha.

O CEPESCO conta, atualmente, com 10 docentes-pesquisadores. Desses, sete são doutores, dois são mestres e uma especialista. Desenvolve projetos de pesquisa de iniciação científica CNPq/UNIR, envolvendo alunos ligados aos cursos de enfermagem e medicina. O CEPESCO é apoiador institucional para a Atenção Básica na Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia e na Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho.

O CEPESCO já desenvolveu vários cursos de especialização, duas residências multiprofissional em Saúde da Família e uma residência em Saúde Mental. Todos financiados pelo Ministério da Saúde. Além disso, também executou o projeto de extensão do VER-SUS, financiado pela Organização Panamericana de Saúde e Ministério da Saúde. Participaram 35 alunos extensionistas e 12 docentes entre CEPESCO, Laboratório de Laboratório de Bioquímica Ambiental Wolfgang C. Pfeiffer

e Educação Física. O projeto intitulado “Calama - Ribeirinhos do rio Madeira” foi executado em um período de doze meses.

A infraestrutura do CEPESCO é composta por cadeiras, mesas, armários e arquivos de aço, quatro computadores no laboratório, dois computadores entre a secretaria e sala de reuniões, duas impressoras na secretaria, três data show, três notebook, quatro ar condicionado e uma pequena biblioteca com 100 títulos na área de enfermagem e saúde coletiva.

5.6 Acessibilidade

O conceito de acessibilidade refere-se ao acesso por meio da diversificação da oferta de cursos em consonância com as necessidades do mundo do trabalho, otimização da capacidade instalada das estruturas física, de recursos humanos e promoção de pesquisa, ensino e extensão visando à qualidade e acesso a universidade.

A estrutura física das salas de aulas do bloco do Curso de Graduação em Enfermagem possui rampa de acesso e banheiro para cadeirantes. Porém, esta rampa não atende a todas as limitações físicas, fazendo-se necessária a providência de um elevador no prédio de aulas para, assim garantir o acesso a todos os acadêmicos, professores/servidores e comunidade em geral. Acrescenta-se também a necessidade de adaptação do prédio dos departamentos por possuir rampa de acesso ou elevador.

No que se refere à formação de recursos humanos, neste PPC estão previstas disciplinas como libras que visam contribuir para minimizar as barreiras na comunicação.

No Relatório de Gestão do exercício de 2013 da UNIR (UNIR, 2014) foram estabelecidos como objetivos estratégicos para o período, 17 propostas, e entre elas a de garantir condições de acessibilidade em todos os *Campi*.

REFERÊNCIAS

ANASTASIOU, L. G. C. A docência no ensino superior: desafios e possibilidades. **ForGRAD em Revista**, v. 1, n. 1, p. 5-8, 2006.

ARDOINO, J.; BARBIER, R.; GIUST-DESPRAIRIES, F. Entrevista com Cornelius Castoriadis. In: BARBOSA, J. G (Coord.). **Multirreferencialidade nas ciências e na educação**. São Carlos: Editora da UFSCar, 1998. p. 50-72.

ASMMANN, H. **Reencantar a educação rumo à sociedade aprendente**. Petrópolis: Vozes, 1998.

BLOMM, B. S.; HASTINGS, J. T.; MADAUS, G. F. **Evaluación del aprendizaje**. Buenos Aires: Troquel, 1993.

BRASIL. Congresso Nacional. **Lei complementar nº 41, de 22 de dezembro de 1981.** Cria o Estado de Rondônia, e dá outras providências. Brasília: Congresso Nacional, 1981.

_____. Congresso Nacional. **Lei nº 7.011, de 8 de Julho de 1982.** Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade Federal de Rondônia. Brasília: Congresso Nacional, 1982.

_____. Congresso Nacional. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília: Congresso Nacional, 1996.

_____. Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno. **Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004**. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Brasília: MEC, 2004.

_____. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior. **Resolução CNE/CES N° 02/2007**. Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial. Brasília: MEC, 2007.

_____. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior. **Resolução CNE/CES nº 3, de 7 de novembro de 2001**. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem. Brasília: MEC, 2001a.

_____. Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES). **Resolução Nº 01, de 17 de junho de 2010**. Normatiza o Núcleo Docente Estruturante e dá outras providências. Brasília: MEC, 2010.

_____. Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno. **Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de maio de 2012**. Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Brasília: MEC, 2012.

_____. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas emendas Constitucionais nos 1/1992 a 68/2011, pelo Decreto legislativo nº 186/2008 e pelas

emendas Constitucionais de Revisão n. 1 a 6/1994. 35 ed. Brasília: Câmara dos Deputados, edições Câmara, 2012.

_____. **DATASUS**. 2009a. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/obt10ro.def>. Acesso em: 30 mar. 2014.

_____. **Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987**. Regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 09 jun. 1987. p. 8.853-8.855.

_____. **Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004**. Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 03 dez. 2004.

_____. **Decreto N° 5.626 de 22 de dezembro de 2005**. Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 2005.
-
_____. **Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002**. Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 jun. 2002.

_____. IBGE. **Indicadores 2010**. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 30 mar 2014.

_____. **Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990**. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF,1990.

_____. **Lei Nº 9.795, de 27 de abril de 1999**. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF,1999.

_____. **Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008**. Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida Provisória no 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 set. 2008.

_____. **Lei nº 7.498 de 25 de junho de 1986**. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1990. p. 9.273 a 9.275.

_____. **Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990**. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 set. 1990. p. 018055.

_____. **Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012**. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o §3 o do art. 98 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Diário Oficial da União, Brasília, 28 set. 2012.

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação Câmara de Educação Superior. **Resolução nº 4, de 6 de abril de 2009**. Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação em Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia Ocupacional, bacharelados, na modalidade presencial. Brasília: MEC, 2009b.

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Parecer nº. CNE/CES 1.133/2001.** Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Enfermagem, Medicina e Nutrição. Brasília: MEC, 2001b.

CHARLOT, B. **Da relação com o saber**: elementos para uma teoria. Porto Alegre: Artmed, 2000.

DEPRESBITERIS, L. Avaliando competências na escola de alguns ou na escola de todos? **Boletim Técnico do Senac**, São Paulo, v. 27, n.3, set./dez. 2001.

FAGUNDES, N. C; BURNHAM, T. F. Transdisciplinaridade, multirreferencialidade e currículo. **Revista da FACED**, n. 5, p. 39-55, 2001.

HAGER, P.; GONCZI, A.; ATHANASOU, J. General issues about assessment of competence. **Asses. Eval. High. Educ**., v. 19, n. 1, p. 3-15, 1994.

HOFFMANN, J. M. L. **Avaliação mediadora**: uma prática em construção da pré-escola a universidade. Porto Alegre: Mediação, 2003.

HOFMANN, J. M. L. **Avaliação**: mito e desafios – uma perspectiva construtivista. Porto Alegre: Mediação, 2005.

LUCKESI, C. C. **Verificação ou avaliação**: o que pratica a escola. In: Gestão e avaliação da educação pública – Gestão do currículo. Governo do Estado do Ceará,

2010. Disponível em: <http://www2.ccv.ufc.br/newpage/conc/seduc2010/seduc_dir/download/avaliacao1.pdf >. Acesso em 25 jul 2014.

LUCKESI, C. C. **Filosofia da educação**. São Paulo: Cortez, 1993.

MACEDO, E. Currículo e competência. In: LOPES, A. R. C.; MACEDO E. (Org.). **Disciplinas e integração curricular**: história e políticas. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. p. 115-144.

MORIN, E. **A cabeça bem-feita**: repensar a reforma, reformar o pensamento. Trad. Eloá Jacobina. 8. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.

_____. **O paradigma perdido**: a natureza humana. 4. ed. São Paulo: Europa América, 1988.

OLIVEIRA, O. A. de. **História, desenvolvimento e colonização do Estado de Rondônia.** 5. ed. Porto Velho: Dinâmica editora, 2005.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDADS (ONU). **IDH dos estados brasileiros, 2010**. Disponível em: <http//www. onu.org.br/rdh2010>. Acesso em: 11 ago 2014.

SANTOMÉ, J. **Globalização e Interdisciplinaridade**: o currículo integrado. Porto Alegre: Artmed, 1998.

SÃO PAULO. Faculdade de Medicina de Marília. **Manual FAMEMA 2004**, Marília, 2004.

TREZZA, M. C. A. F.; SANTOS, R. M.; LEITE, J. L. Enfermagem como prática social – um exercício de reflexão. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 61, n. 6, p. 904-908, 2008.

UNIR. Relatório de Gestão do exercício de 2013. Março de 2014. Disponível em: < http://www.proplan.unir.br/submenu_arquivos/925_unir_relatorio_gestao_2013_final_tcu__30_04_14.pdf>. Acesso em: 30 mar 2014.

VASCONCELLOS, C. dos S. **Avaliação da aprendizagem**: práticas de mudança – por uma práxis transformadora. 5. ed. São Paulo: Libertad, 2003.

ZEFERINO, A. M. B.; PASSERI, S. M. R. R. Avaliação da aprendizagem do estudante. **Cadernos da ABEM**, São Paulo, n. 3, p. 39-43, 2007.

APÊNDICES

Apêndice 1 – Plano de adaptação curricular ao novo currículo do curso de graduação em enfermagem da UNIR

Plano de Adaptação Curricular ao Novo Currículo do Curso de Graduação em Enfermagem da UNIR

Do estudo comparativo entre as duas matrizes a adaptação curricular dos discentes do curso será feita da seguinte forma:

1) Os alunos que ingressarem no curso a partir da aprovação deste PPC, cumprirão a nova matriz curricular;
2) Os alunos do 3º, 5º, 6º e 7º períodos, referente a 2014/2º semestre, cumprem as cargas horárias e os créditos das disciplinas da estrutura curricular estabelecida pela Resolução n. 181/CONSEA, de 27 de setembro de 2007 quanto ao Bacharelado em Enfermagem.
3) Os alunos que hoje estão nas turmas do 7º, 6º e 5º períodos caso sejam reprovados, ingressarão automaticamente na turma menos adiantada, respectivamente, permanecendo na matriz curricular estabelecida pela resolução 181/CONSEA até a integralização do curso. Cumprirão as disciplinas, objeto de reprovação, quando do oferecimento destas de acordo com a matriz curricular a qual pertencem.
4) Os alunos que hoje estão na turma do terceiro período ou que ingressarem nesta, caso sejam reprovados, passarão a cumprir disciplinas da nova matriz curricular equivalentes as do currículo antigo (com as novas cargas horárias, créditos e nomenclaturas), quando do oferecimento destas na matriz curricular.
5) Alunos que forem reintegrados enquanto há turmas cursando disciplinas do currículo antigo, poderão ingressar nestas turmas, desde que não tenham pendências nos períodos anteriores aos que estiverem acontecendo em currículo antigo. Nos casos de pendências por disciplinas ou períodos, terão que ingressar no novo currículo para integralização do curso.
6) Alunos que reintegrarem após o término do oferecimento das disciplinas do currículo antigo procederão da maneira descrita no item 4.

7) Alunos remanescentes de matrizes que contemplam licenciatura deverão cursar Psicologia da Educação, Didática Geral e Legislação Educacional e Gestão Escolar em cursos da área de educação. Quanto às disciplinas Prática de Ensino I e Prática de Ensino II serão oferecidas de maneira especial.
8) Os casos omissos ou isolados de adaptação à nova Estrutura Curricular do Curso serão objeto de apreciação pelo Conselho de Departamento de Enfermagem.

Abaixo apresentamos o quadro demonstrativo de equivalência entre as disciplinas do currículo 2007 e as disciplinas do novo currículo, para fins de adaptação de alunos remanescentes do currículo antigo ao novo.

Quadro 1 - Demonstrativo de equivalência entre a nova matriz curricular e a matriz curricular de 2007

CURRÍCULO ANTIGO		**CURRÍCULO NOVO**	
	CH		CH
Anatomia Humana	80	Anatomia Humana	60
Bioquímica	60	Processos Bioquímicos Vitais	60
Citologia, Embriologia	60	Citologia, Embriologia	60
Psicologia Aplicada à Saúde	60	Psicologia em Saúde	60
Metodologia Científica	40	Introdução à Metodologia Científica	40
Filosofia	60	Introdução à Filosofia	60
Sociologia Geral	60	Sociologia Geral	60
Introdução à Saúde Coletiva	60	Enfermagem em Saúde Coletiva I	60
Antropologia da Saúde	60	SUPRIMIDA	
Tópicos em	40	Saúde Ambiental	40

Enfermagem I			
Fisiologia e Biofísica	100	Fisiologia; Biofísica	80/40
Parasitologia	60	Parasitologia	60
História, Legislação e Ética em Enfermagem	100	História e Introdução à Enfermagem; Legislação e Ética em Enfermagem; Prática Integrativa em Enfermagem I; Prática Integrativa em Enfermagem II	60/ 20/80/ 100
Histologia	60	Histologia	60
Genética e Evolução	60	SUPRIMIDA	
Psicologia da Educação	60	SUPRIMIDA	
Estatística da Saúde	40	Estatística aplicada à Saúde	60
Tópicos em Enfermagem II	40	Leitura e produção textual	40
Patologia Geral	60	Processos Patológicos	60
Farmacologia Aplicada à Enfermagem	80	Farmacologia	80
Administração em Enfermagem I	40	Bases teóricas da Gestão de Saúde e da Enfermagem nos Serviços de Saúde I; Prática Integrativa em Enfermagem II	40 /100
Microbiologia, Imunologia	60	Microbiologia , Imunologia	80
Didática Geral	80	SUPRIMIDA	
Legislação Educacional e Gestão Escolar	60	SUPRIMIDA	
Teorias e	60	Fundamentos e práticas para o cuidado de	60 /

Processo de Enfermagem		Enfermagem I; Prática Integrativa em Enfermagem I	80
Tópicos em Enfermagem III	40	Matemática aplicada à Enfermagem; Prática Integrativa em Enfermagem II	20 / 100
Epidemiologia	60	Epidemiologia; Prática Integrativa em Enfermagem III	40 / 200
Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem	240	Fundamentos e práticas para o cuidado de Enfermagem II; Fundamentos e práticas para o cuidado de Enfermagem III; Prática Integrativa em Enfermagem II; Prática Integrativa em Enfermagem III	60/80/ 100/ 200
Enfermagem em Saúde Mental	140	Enfermagem no cuidado a Saúde Mental; Prática Integrativa em Enfermagem VI	40/ 240
Metodologia da Pesquisa em Enfermagem	60	Pesquisa em Saúde e na Enfermagem; Prática Integrativa em Enfermagem III	20/ 200
Prática de Ensino I	120	SUPRIMIDA	
Enfermagem ao Adulto e ao Idoso I	180	Enfermagem na atenção à saúde do adulto I: abordagem clínica; Enfermagem no processo de cuidar em urgência e emergência; Prática Integrativa em Enfermagem IV; Enfermagem na atenção integral à saúde do idoso.	60/60/ 240/ 40
Enfermagem ao Adulto e ao Idoso II	180	Enfermagem na atenção à saúde do adulto II: abordagem cirúrgica; Prática Integrativa em Enfermagem IV	80/ 240
Prática de Ensino II	100	SUPRIMIDA	
Enfermagem ao Adulto e Idoso em	140	Enfermagem em doenças tropicais e transmissíveis; Prática Integrativa em Enfermagem VII	40/ 280

Doenças Tropicais			
Enfermagem à Saúde da Mulher	200	Enfermagem à saúde da mulher I; Enfermagem à saúde da mulher II; Prática Integrativa em Enfermagem V	40/ 100/ 280
Enfermagem em Saúde Coletiva	140	Enfermagem em saúde coletiva II; Prática Integrativa em Enfermagem III; Enfermagem em saúde coletiva III; Prática Integrativa em Enfermagem VII	20/ 200/ 40/ 280
Enfermagem em Saúde da Criança e Adolescente	140	Enfermagem na atenção à saúde da criança e adolescente; Prática Integrativa em Enfermagem V	40/ 280
Administração em Enfermagem II	120	Bases teóricas da Gestão de Saúde e da Enfermagem nos Serviços de Saúde II; Prática Integrativa em Enfermagem III; A gerência do processo de trabalho da Enfermagem na gestão, rede básica e rede hospitalar/ambulatorial; Prática Integrativa em Enfermagem VII	40/ 200/ 60/ 280
Planejamento em Saúde	60	A gerência do processo de trabalho da Enfermagem na gestão, rede básica e rede hospitalar/ambulatorial	60
Estágio Supervisionado em Enfermagem I	400	Estágio Curricular Supervisionado I	400
Trabalho de Conclusão de Curso	60	Trabalho de conclusão de curso I; Trabalho de conclusão de curso II	20/20
Estágio Supervisionado em Enfermagem II	420	Estágio curricular supervisionado II	420
		Informática Aplicada à Saúde*	40

		Enfermagem, Educação e Saúde*	20
		Saúde Indígena (optativa)*	40
		Libras (optativa)*	60
		Prevenção e controle de Infeções relacionadas à assistência à saúde*	20
		Enfermagem e a saúde do trabalhador (optativa)*	40
		Relações humanas no processo de trabalho da Enfermagem*	60
		Práticas educativas em Saúde/Enfermagem*	60

Legenda: * não possui disciplina equivalente no currículo antigo.

Apêndice 2 – Regulamentação do trabalho de conclusão de curso – TCC

REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO

Art. 1º. O Trabalho de Conclusão do Curso - TCC de Graduação em Enfermagem será uma prática investigativa e/ou assistencial elaborada individualmente pelo acadêmico, em consonância com o grupo de pesquisa em que o professor do Departamento de Enfermagem da Fundação Universidade Federal de Rondônia se insere aprovado pelo CONDEP/DENF.

Art. 2º. O TCC deverá abordar temas da área da saúde relacionados à enfermagem, sendo este uma proposta que tenha relação com a realidade dos serviços, ressaltando o compromisso da Universidade em contribuir para a concretização dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

Art. 3º. O TCC é uma contribuição ao conhecimento e deve ser de nível publicável e científico, segundo os parâmetros da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Art. 4º. Os objetivos gerais do Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em Enfermagem é o de proporcionar aos alunos à oportunidade de demonstrar o grau de conhecimento adquirido, o aprofundamento do recorte temático, a sistematização das atividades, o ensaio teórico e/ou exposição dos resultados de uma pesquisa.

CAPÍTULO II
ATRIBUIÇÕES DO ACADÊMICO NO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

Art. 5º. O acadêmico para início das atividades deve:

I – Comparecer as orientações pré-agendadas com o orientador e cumprir o cronograma proposto pelo professor-orientador;

II – Manter uma boa comunicação com orientador;

III - Respeitar o cronograma de atividades estabelecidas em comum acordo com o professor orientador;

IV - Buscar todas as informações necessárias para desenvolver o Trabalho de Conclusão do Curso;

V – Redigir o Trabalho de Conclusão de Curso dentro das Normas da ABNT;

VI - Encaminhar três cópias do projeto para a Coordenação do TCC.

VII – Entregar as etapas do seu TCC nas datas estabelecidas pelo professor-orientador.

VIII - Cumprir com as normas do TCC de Enfermagem;

Parágrafo Único - Nenhum tema de Trabalho de Conclusão de Curso poderá ser mudado após a qualificação.

CAPÍTULO III
ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR/ORIENTADOR DE TCC DE ENFERMAGEM

Art. 7º. O Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Enfermagem é desenvolvido mediante orientação de um professor pertencente ao Departamento de Enfermagem com titulação mínima de mestre e dedicação exclusiva, de acordo com as linhas e os projetos institucionais do grupo de pesquisa em que o docente se insere.

Parágrafo Único – A forma de apresentação do TCC será monografia, sendo os resultados apresentados no formato de artigo científico.

Art. 8º. Cabe ao aluno escolher o professor orientador, de acordo com a linha de pesquisa, devendo, para esse efeito, realizar o convite levando em consideração:

1. A aceitação do convite pelo professor que dar-se-á mediante a assinatura de termo de compromisso;

2. O aluno poderá contar com a colaboração de um coorientador, pertencente ao quadro de docentes da UNIR ou de outra instituição, devendo este possuir minimamente titulação de mestre, vínculo com ensino de graduação, conhecimento específico na área

afim, sem ônus para a Instituição, desde que obtenha a aprovação do seu orientador e do Conselho de Departamento de Enfermagem.

Parágrafo Único: A substituição do orientador somente poderá ocorrer desde que solicitada e aprovada pelo Conselho de Departamento, por meio de requerimento acompanhado de justificativa.

Art. 9º. Cada professor poderá ter no máximo três (3) alunos para efeito de orientação.

Art. 10. São deveres do professor orientador:

I – Ter a titulação mínima de mestre e orientar os trabalhos de acordo com sua área de formação ou de pesquisa;

II – Orientar e acompanhar o processo de construção dos trabalhos acadêmicos que estiverem sob sua responsabilidade;

III - Orientar e indicar fontes bibliográficas e outros instrumentos de coleta de dados e informações para seus orientandos;

IV - Frequentar as reuniões convocadas pelo Coordenador do TCC:

V - Atender seus alunos orientados, em horário previamente fixado;

VI - Comunicar por escrito ao Coordenador do TCC os casos dos alunos que não comparecerem a três encontros consecutivos de orientação;

VII - Entregar as fichas de frequência, e avaliação devidamente preenchidas e assinadas para o Coordenador do TCC;

VIII - Assinar, juntamente com os demais membros das bancas examinadoras, as atas finais das sessões de defesa;

IX - Presidir a banca examinadora;

X – Autorizar exclusivamente mediante instrumento próprio, a protocolização do TCC pelo acadêmico, assumindo que o mesmo está em condições de apresentação pública;

XI - Assumir o compromisso de entregar no ato da defesa e qualificação o trabalho com sugestões e apontamentos;

XII - Preencher as fichas de avaliação do trabalho escrito e oral, além da ata no momento da apresentação do TCC.

CAPÍTULO IV

ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DE TCC DE ENFERMAGEM

Art. 11. A coordenação de TCC do Curso de Graduação em Enfermagem fica a cargo do professor responsável pela disciplina de TCC I e TCC II designado pelo Conselho de Departamento, com carga horária semanal de 2 h/a por semestre.

Art. 12. São atribuições do Coordenador de TCC de Enfermagem:

I – Coordenar e supervisionar todas as fases de desenvolvimento do TCC;

II – Providenciar e manter atualizados os instrumentos de registros de atividades desenvolvidas durante a fase de elaboração do TCC;

III – Acompanhar todo o processo avaliativo do TCC e encaminhar os resultados finais à Chefia do Departamento para os devidos registros e publicação;

IV – Coordenar encontros periódicos com professores-orientadores para organização, planejamento, desenvolvimento e avaliação do TCC;

V - Estabelecer datas e prazos para cada momento de realização e apresentação do TCC;

VI – Proceder, quando for o caso, à substituição de orientadores, ouvido o Conselho de Departamento;

VII – Coordenar a constituição das bancas examinadoras, cronograma de apresentação dos trabalhos, divulgando-os no meio acadêmico com uma semana de antecedência da data marcada para a apresentação dos trabalhos;

VIII – Receber os trabalhos escritos e encaminhá-los à banca e/ou comissão avaliadora para avaliação da Banca Fechada;

IX – Reservar sala e equipamentos audiovisuais para apresentação dos trabalhos na defesa Pública;

X – Providenciar declarações de orientador e/ou avaliador aos membros da banca examinadora.

CAPÍTULO V
DO PROJETO DE MONOGRAFIA

Art. 13 – O aluno deve elaborar seu projeto do TCC de acordo com este Regulamento e com as orientações do seu Professor Orientador, ainda no 9º período do curso.

§**1º**- O TCC só poderá ser cursado pelo acadêmico de enfermagem que tiver **sido aprovado em** todos os componentes curriculares constantes até o VIII período do Curso de Graduação em Enfermagem.

§**2º** - O projeto de pesquisa ou plano de trabalho deverá conter entre 10 e 15 laudas incluindo-se, nesse total, somente a parte textual;

§**3º** – A estrutura formal do projeto deve seguir os critérios técnicos estabelecidos nas normas da ABNT sobre documentação, no que forem eles aplicáveis.

A estrutura do **projeto de monografia** compõe-se de:

I – Folha de rosto;

II – Identificação;

III – Tema;

IV – Delimitação do tema;

V – Formulação do problema (pergunta básica);

VI – Hipótese (não obrigatória);

VII – Objetivos (geral e específicos);

VIII – Justificativa;

IX – Metodologia;

X – Cronograma de atividades e orçamento;

XI – Referências

XII – Instrumentos de pesquisa (quando houver pesquisa de campo);

XIII – Parecer de admissibilidade do professor orientador.

§ **3º** – Caso o aluno seja vinculado a um Grupo de Pesquisa cujo orientador do DENF tenha um projeto institucionalizado na UNIR, com a devida aprovação pelo CEP/UNIR, o aluno só deverá apresentar seu plano de trabalho com base no projeto matriz do orientador.

Art. 14. O projeto de Trabalho de Conclusão de Curso ou o Plano de Trabalho deve ser entregue ao Coordenador do TCC no final do 9º período.

Art. 15. O Coordenador do TCC encaminhará os projetos à Banca Fechada que avaliará o projeto ou plano de trabalho.

Art. 16. O Coordenador de TCC agendará com o orientador do aluno, a data da qualificação do projeto, cuja Banca será a mesma da defesa do TCC.

Art. 17. Se o projeto não for aprovado pela Banca Fechada, retornará para o aluno através do orientador, que terá 30 dias para refazê-lo.

CAPÍTULO VI
DA BANCA DE QUALIFICAÇÃO DO PROJETO DE TCC

Art. 18. A banca de qualificação tem como finalidade avaliar o projeto de TCC nos aspectos teórico-metodológicos e atribuir uma nota de zero (0) a 100 pontos contemplando os aspectos do projeto e defesa oral.

Art. 19. A banca de qualificação será realizada com a presença dos professores e aluno e constará somente das arguições dos membros da banca.

Art. 20. O projeto deverá ser encaminhado para os professores da banca de qualificação no mínimo com sete (7) dias úteis de antecedência.

Art. 21. Para a aprovação do projeto do TCC, deve ser levada em consideração a sua exequibilidade e a existência ou não de monografia já apresentada e defendida com base em projeto idêntico**.**

§1º – O projeto reprovado deve ser devolvido ao aluno no prazo de até 30 dias úteis, para que seja reformulado ou refeito e possa ser entregue novamente a Banca Examinadora.

§2º – Aprovado o projeto do TCC, que este seja entregue à Chefia do DENF em cópia digitalizada que confeccionará um CD em um único arquivo.

§3º – O aluno que incorrer na prática de plagio no projeto do TCC será automaticamente reprovado na disciplina, e ainda enfrentará sanção administrativa a ser imposta pelo Conselho de Departamento.

Art. 22. A banca de qualificação será constituída por: professor orientador; um professor indicado pelo aluno e orientador, respeitando as linhas de pesquisa; um professor indicado pelo Conselho de Departamento de Enfermagem e seus suplentes, devendo estes possuírem minimamente titulação de mestre e vínculo com ensino de graduação.

CAPÍTULO VII
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO TCC

Art. 23. Dos procedimentos quanto ao processo de elaboração de TCC, o qual se dará no décimo período do curso.

I - O aluno só poderá entregar seu TCC para a banca avaliadora, mediante carta de encaminhamento assinada pelo orientador, na data estabelecida pela coordenação de TCC;

II - O acadêmico que não entregar o TCC na data estabelecida pela coordenação de TCC deverá registrar justificativa via Protocolo ao Departamento;

III - Para as justificativas fundamentadas será deferido pela Chefia do Departamento de Enfermagem;

IV - Para as justificativas não fundamentadas o pedido será avaliado pela coordenação de TCC ouvido o Conselho de Departamento de Enfermagem;

V – O TCC deverá conter até 40 laudas, incluindo-se, as referências, excluindo os elementos pré e pós-textuais.

VI – O TCC deverá conter os seguintes elementos constantes na ABNT.

Parágrafo Único – O aluno só poderá encaminhar seu TCC para a Banca Fechada quando apresentar o documento de envio do artigo a um periódico indexado.

Art. 24. A avaliação do TCC consiste do trabalho escrito e da comunicação oral.

Art. 25. O resultado da avaliação feita pela banca fechada recebe os conceitos: suficiente ou insuficiente.

§1º- Nos casos em que a Banca julgar necessário, o TCC deverá ser reformulado, ficando estabelecido um período máximo adicional que não poderá ultrapassar o prazo máximo de 30 dias úteis para realização dos ajustes necessários.

§2º - A reelaboração do trabalho com as correções sugeridas pela Banca deverá ser entregue em três (3) vias digitadas, sem encadernação à Chefia do Departamento, que encaminhará aos membros da Banca Examinadora para outra avaliação. Após a nova avaliação, a Banca emitirá o conceito final da versão escrita.

§3º - Se reprovado na re-apresentação, o acadêmico deverá refazer o TCC e apresentá-lo por ocasião da próxima turma de concluintes do curso.

CAPÍTULO VIII
DA DEFESA DA MONOGRAFIA

Art. 26. As sessões de defesa das monografias são públicas.

§ Único – Não será permitido aos membros das bancas examinadoras tornarem público o conteúdo das monografias antes das defesas.

Art. 27. A Banca Examinadora será a mesma da banca de qualificação.

Art. 28. Os TCC aprovados pela Banca Examinadora deverão ser apresentados em sessão pública, com a presença da Banca, conforme a data definida pelo Coordenador.

Art. 29. Na defesa, o aluno tem 20 minutos para apresentar seu trabalho e cada componente da banca examinadora até 10 minutos para sua argumentação, dispondo ainda o discente de outros 10 minutos para responder a cada um dos examinadores.

Art. 30. O resultado final da avaliação feita pela banca examinadora é expresso por meio de notas na escala de 0 (zero) a 100 (cem).

I - É considerado aprovado o aluno que obtiver nota mínima igual a 60 (sessenta) pontos;

II - A nota final é resultante da avaliação do trabalho escrito e da comunicação oral;

III - A atribuição das notas em ata dar-se-á após o encerramento da comunicação oral e da etapa de arguição, e manifestação dos membros da banca examinadora;

IV - Para a atribuição das notas será utilizada a ata de avaliação individual;

V - A nota obtida será comunicada ao acadêmico imediatamente após a definição da banca;

VI - A versão final do TCC deverá encaminhada ao DENF, com revisão ortográfica e gramatical, contemplando as recomendações da banca, sendo necessária no ato da entrega do trabalho final a assinatura do orientador.

VII – A versão final do TCC será encaminhada pelo coordenador do TCC à PROPesq.

CAPÍTULO IX
VÍNCULO E QUEBRA DE VÍNCULO DO ACADÊMICO COM O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

Art. 31. O Orientador, com anuência do Conselho de Departamento, poderá solicitar desligamento da orientação de TCC quando o acadêmico não cumprir o plano e o cronograma de atividades.

I - O desligamento não poderá ocorrer se faltar menos de 20 (vinte) dias da data fixada para entrega do trabalho para a banca examinadora fechada e deve ter a ciência por escrito do acadêmico;

II - O Coordenador do TCC pode indeferir o pedido se julgar insuficiente a justificativa apresentada ou se entender não haver mais tempo hábil para a conclusão do trabalho sob orientação do outro docente;

III - O Orientando pode apresentar, nos três (3) dias seguintes à ciência do desligamento, justificativa perante o Coordenador de TCC e solicitar novo Orientador.

Art. 32. O acadêmico, mediante justificativa encaminhada à Coordenação de TCC, pode solicitar a substituição de Orientador.

I - O pedido de substituição deve ser protocolado na Secretaria do Departamento, no mínimo 20 (vinte) dias antes da data fixada para entrega do trabalho e deve ter a ciência por escrito do orientador;

II - O Coordenador do TCC pode indeferir o pedido se julgar insuficiente a justificativa apresentada ou se entender não haver mais tempo hábil para conclusão do trabalho sob orientação de outro docente.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 33. Compete ao Conselho de Departamento de Enfermagem propostas de alteração deste Regulamento, apreciado pelo Conselho de Núcleo de Saúde e pelo CONSEA/UNIR.

Art. 34. Os casos omissos e as interpretações deste Regulamento devem ser resolvidos pela Coordenação do TCC e pelo Conselho de Departamento de Enfermagem, observadas as disposições regimentais.

Art. 35. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Velho, ____ de _____ de 2015.

APÊNDICES

FICHA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA OU PLANO DE TRABALHO

TÍTULO:		
ALUNO (A):		
HORÁRIO DA APRESENTAÇÃO	DATA DE DEFESA:	
1. ASPECTOS FORMAIS	40	
1.1. O Sumário do projeto de pesquisa está como o requerido. (Introdução, Problematização, Objetivos, Justificativa, Revisão de literatura, Metodologia, Cronograma, Orçamento e Referências).	10	
1.2. A formatação e os aspectos gráficos do trabalho estão corretos. (Margem, tamanho da fonte, paragrafação, espaçamento, recuos, notas de rodapé, citações diretas e indiretas, títulos e subtítulos); citações no corpo do texto estão de acordo com o padrão ABNT. Caso não haja, indicar se houver problema com algum desses elementos.	10	
1.3. As referências ao longo do texto (autor-data) foram colocadas de maneira correta. Se não, indicar.	10	
1.4. O texto apresenta linguagem adequada, ideias concatenadas e claras, coesão e coerência.	10	
2. ASPECTOS DE CONTEÚDO	30	
2.1. INTRODUÇÃO: O tema está indicado claramente? O problema está formulado de maneira clara e precisa? Há delimitação do problema com indicações dos referenciais teóricos?	10	
2.2. OBJETIVOS: Os objetivos geral e específicos estão claros e coerentes com a metodologia?	10	
2.3. JUSTIFICATIVA: Há justificativa para o tema escolhido? Apresentou a relevância política, social e acadêmica do tema?	10	
3. METODOLOGIA	10	
3.1. O tipo de abordagem de pesquisa está clara? Há adequação entre o tipo de abordagem e o tipo de técnica apresentada? Apresenta coleta de dados, variáveis do estudo e análise dos dados? Apresenta os aspectos éticos?	10	
4. ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, REFERÊNCIAS (PADRÃO ABNT), APÊNDICES (TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO GESTOR E TCLE)	20	

FICHA DE AVALIAÇÃO – TCC

TÍTULO:		
ALUNO (A):		
HORÁRIO DA APRESENTAÇÃO	DATA DE DEFESA:	
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO I	MÁXIMO	NOTA
1. ASPECTOS FORMAIS	30	
1.1. Elementos pré-textuais: capa, folha de rosto, errata (s/n), folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo em português, *abstract*, listas de gráficos, tabelas e siglas, listas de ilustrações, abreviaturas e símbolos e sumário.	10	
1.2. Elementos textuais: Introdução, desenvolvimento e conclusão.	10	
1.3. Elementos pós-textuais: bibliografia, glossário, apêndice, anexo, índice. Formatação conforme ABNT: títulos e subtítulos, citações, numeração de páginas, referências.	10	
2. ASPECTOS LÓGICOS	30	
2.1 Coerência entre objetivos, o problema e o título com o conteúdo do trabalho. Eficácia na utilização do tempo da apresentação (máximo 20 min). Correlação com o referencial teórico. Sequência lógica na apresentação.	15	
2.2 Contextualização, questões de pesquisa, categorias teóricas. Formulação e delimitação do problema e formulação dos objetivos.	15	
3. ASPECTOS LINGÜÍSTICOS	20	
3.1 Correção, clareza e precisão: na introdução, na expressão e na linguagem.	10	
3.2. Segurança na exposição das ideias.	10	
4. ASPECTOS METODOLÓGICOS	20	
4.1 Método, instrumentais, critérios e procedimentos. Habilidade e qualidade na utilização de técnicas e materiais de apoio (ilustração, diagramas, tabelas e gráficos). Qualidade da apresentação gráfica.	10	
4.2 Clareza: na redação, na estrutura e na organização do texto. Apresentação da metodologia empregada no trabalho. Adequação dos recursos tecnológicos utilizados.	10	
SUBTOTAL I	100	
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO II	MÁX	NOTA
5. ASPECTOS PRÁTICOS	100	
5.1 Apresentação: Capacidade de síntese, principais resultados e encaminhamentos de outros aspectos para futuras pesquisas.	5	
5.2 Segue sequência lógica conforme metodologia?	5	
5.3 Fundamenta o trabalho utilizando citações bibliográficas?	5	
5.4 Utiliza equipamentos audiovisuais adequados?	5	
5.5 Respeita o tempo previsto pela Comissão avaliadora?	5	
5.6 Respeita prazo de entrega do trabalho?	5	

5.7 Contextualização: Apresentação da justificativa para realização do estudo. Contextualizou o trabalho?	10	
5.8 Arguição: Domínio, segurança e qualidade das argumentações e das respostas.	20	
5.79 Nível de profundidade do assunto. Apresentou análise dos dados coerente com as conclusões e os objetivos traçados?	20	
5.10 Clareza na apresentação dos resultados do trabalho e no encerramento da apresentação. Postura ética.	20	
SUBTOTAL II	100	
NOTA FINAL = (SUBTOTAL I + SUBTOTAL II): 2		
TOTAL DE PONTOS		

OBS: * pontos a serem somados ou subtraídos com o artigo 12 – no processo de desenvolvimento do projeto

ASSINATURAS DOS MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA:
_____ Presidente e Professor(a) Orientador(a) _____ Membro e Primeiro(a) Examinador(a) _____ Membro e Segundo(a) Examinador(a) _____ Aluno(a)/Autor(a) Porto Velho, _____de dezembro de 20__.
PARECER FINAL
( ) Aprovado(a). ( ) Reprovado.
OUTRAS OBSERVAÇÕES:

DECLARAÇÃO DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Declaro para os devidos fins que aceito orientar o discente _____ _____, no seu Trabalho de Conclusão de Curso. A orientação se dará de acordo com o Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Enfermagem.

Nome do orientador: _____
Título provisório do TCC: _____
_____

_____
Assinatura do(a) professor(a) orientador(a)

Eu acadêmico acima mencionado declaro que tenho conhecimento do Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Enfermagem, e assumo os compromissos da elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso.

_____
Assinatura do(a) discente
Data de entrega da declaração de orientação: ___/___/___

_____
Assinatura do(a) Coordenador(a) do TCC do Curso de Graduação em Enfermagem

FICHA DE SUBSTITUIÇÃO DE ORIENTADOR
(modelo do professor)

Eu,_____
solicito o desligamento da orientação do(a) acadêmico(a) _____
_____
O motivo que desencadeou este desligamento foi _____
_____
_____
_____
_____
_____

Eu, acadêmico(a) _____,
declaro estar ciente dos motivos pelos quais está havendo o desligamento do orientador acima citado(a).

_____
Assinatura do(a) acadêmico(a)

_____
Assinatura do(a) professor(a) orientador(a)

Data: ___/___/___

_____
Assinatura do(a) Coordenador(a) do TCC do Curso de Graduação em Enfermagem
Data: ___/___/___

FICHA DE SUBSTITUIÇÃO DE ORIENTADOR(A)
(modelo do(a) acadêmico(a)

Eu,_____
solicito o desligamento da orientação do(a) professor(a) _____
_____
_____.

O motivo que desencadeou este desligamento foi
_____
_____
_____
_____
_____

Eu professor(a) _____,
declaro estar, ciente dos motivos pelos quais está havendo o desligamento do(a) acadêmico(a) acima citado(a).

_____
Assinatura do(a) acadêmico(a)

_____
Assinatura do(a) professor(a) orientador(a)
Data: ___/___/___

_____
Assinatura do(a) Coordenador(a) do TCC do Curso de Graduação em Enfermagem

Data: ___/___/___

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Atividade	Data de orientação	Horário	Duração prevista

_____
Assinatura do(a) acadêmico(a)

_____
Assinatura do(a) orientador(a)

PLANILHA DE HORÁRIO DE ORIENTAÇÃO DE TCC

DOCENTE: _____

DIA: ___/___ - Dia da semana: _____
Horário
Acadêmico(a)
Assunto

DIA: ___/___ - Dia da semana: _____
Horário
Acadêmico(a)
Assunto

DIA: ___/___ - Dia da semana: _____
Horário
Acadêmico(a)
Assunto

CARTA DE ENCAMINHAMENTO PARA ENTREGA DO PROJETO DE TCC

ACADÊMICO(A):

_____

ORIENTADOR(A):

Informamos à Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso que o Projeto intitulado_____

_____

_____enco ntra-se finalizado, sendo, portanto autorizada sua entrega e o seu encaminhamento para a Banca Avaliadora.

Orientador(a):_____

Nome do membro da banca 1:

_____

Nome do membro da banca 2:

_____

ATA DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

ATA nº. _____

No dia ___/___/20__, as ___h____min, reuniu-se na Universidade Federal de Rondônia - UNIR, Curso de Graduação em Enfermagem, a Comissão Examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, para avaliar o(a) acadêmico(a) _____ _____.

Após dar a conhecer, aos presentes, o teor e normas regulamentares do TCC intitulado _____ _____ _____

passou a palavra ao(a) acadêmico(a), para apresentação de seu trabalho.

Seguiu-se a arguição pelos examinadores, com a respectiva defesa do candidato. Logo após, a comissão se reuniu, para avaliação e expedição do resultado final. A banca avaliadora concede um prazo de 30 dias para o aluno efetuar as correções sugeridas e apresentar o trabalho em sua redação definitiva. Foram atribuídas as seguintes indicações, pelos senhores examinadores:

Orientador _____ Nota: _____
Examinador 1 _____ Nota: _____
Examinador 2 _____ Nota: _____
Média:_____

_____ Orientador – Presidente da Banca	
_____ Examinador 1	_____ Examinador 2
_____ Chefe de Departamento	

Porto Velho _____ de _____ 20__.

OBS: A Comissão avaliadora lavra a ata conferindo ao acadêmico o requisito parcial para obtenção do grau de Enfermeiro oferecendo um prazo de trinta dias para as correções.

RELATÓRIO FINAL DE TCC DO PROFESSOR ORIENTADOR

Professor (a) Orientador (a):

Ano Letivo: Semestre:

1. Atividades Desenvolvidas

2. Acadêmicos Orientados

Acadêmico (a): Período:

RELATÓRIO INDIVIDUAL DO ORIENTANDO

3. Relatório do orientador referente ao andamento do TCC no decorrer do semestre, sugestões, críticas, pontos positivos e negativos, etc.

_____

Assinatura do (a) Prof. Orientador (a)

RELATÓRIO FINAL DE TCC DO ACADÊMICO

O acadêmico deverá relatar por tópicos ou em forma de texto tudo o que considerar relevante referente: Orientador, Coordenador de TCC, Dificuldades encontradas, Pontos positivos, Pontos negativos, Sugestões, Avaliação pessoal de seu desenvolvimento acadêmico, etc...

A avaliação, feita com veracidade e seriedade, é de suma importância para amadurecimento das condutas adotadas no TCC, portanto, você poderá utilizar o número de páginas necessárias para sua avaliação.

_____

Acadêmico (a) – Nome e Assinatura

_____

Orientador (a) – Nome e Assinatura

_____

Coordenador de TCC – Nome e Assinatura

Data: ___/___/___

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA AS BANCAS DE TCC

(AOS ORIENTADORES)

SENHORES PROFESSORES, SOLICITAMOS QUE OS PROCEDIMENTOS ABAIXO SEJAM OBSERVADOS PARA A CONDUÇÃO DAS BANCAS DE TCC:

- CUMPRIMENTAR A TODOS OS PRESENTES E AGRADECER O COMPARECIMENTO
- FAZER A ABERTURA DA SESSÃO DE TRABALHOS
- FORNECER INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A CONDUÇÃO DOS TRABALHOS
- CRONOMETRAR E CONTROLAR O TEMPO DAS ATIVIDADES
- CADA ACADÊMICO TERÁ 15 MIN PARA A SUA APRESENTAÇÃO DE PROJETO
- CADA ACADÊMICO TERÁ 20 MIN PARA A SUA APRESENTAÇÃO DO TCC
- INFORMAR AO ACADÊMICO QUANDO ESTIVER FALTANDO 2 MIN
- INFORMAR AO ACADÊMICO QUANDO O TEMPO ESTIVER ESGOTADO
- SOLICITAR QUE O ACADÊMICO SENTE-SE E FAÇA ANOTAÇÕES SOBRE AS RECOMENDAÇÕES DA BANCA
- CADA MEMBRO AVALIADOR TERÁ 5 MIN PARA QUESTIONAMENTOS
- AO FINAL DA ARGUIÇÃO A BANCA DEVE SE REUNIR EM UMA SALA EM SEPARADO PARA PREENCHER A ATA
- EM SEGUIDA A BANCA VOLTA À SALA DE ORIGEM E ENTREGA OS TRABALHOS COM AS ANOTAÇÕES AO ACADÊMICO
- AS NOTAS SERÃO PUBLICADAS PELA DIRCA APENAS APÓS A ENTREGA DA VERSÃO FINAL COM AS SUGESTÕES DA BANCA EXAMINADORA
- INFORMAR A DATA DE ENTREGA DA VERSÃO FINAL CORRIGIDA INFORMAR AO ACADÊMICO QUE ESTE DEVERÁ ENTREGAR 2 CD

− CUMPRIMENTAR O ACADÊMICO PELO SEU TRABALHO

− ENCERRAR A SESSÃO DE APRESENTAÇÃO DE TCC

Apêndice 3 – Regulamento do estágio curricular obrigatório



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

REGULAMENTO DE ESTÁGIOS CURRICULARES SUPERVISIONADOS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

Este regulamento normatiza as ações dos Estágios Curriculares Supervisionados presentes na matriz curricular do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Rondônia – UNIR.

O Estágio Curricular Supervisionado é realizado no 9º e 10º períodos com carga horária de 840 h/a o que perfaz um total máximo de 20% da carga horária do curso de acordo com o Art. 1º parágrafo único da Resolução CNE/CES nº 4, aprovada em 6 de abril de 2009, que institui carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração do cursos de graduação em Enfermagem.

CAPÍTULO I

Da concepção do Estágio Curricular Supervisionado

Art. 1º - Entende-se por Estágio Curricular Supervisionado o período de caráter obrigatório ao desenvolvimento de atividades assistenciais, gerenciais, educativas e de pesquisa em Enfermagem e saúde em campos de prática, que possam contribuir para o desenvolvimento e qualificação do futuro profissional Enfermeiro. Tem o objetivo de preparar o discente para o trabalho por meio do aprendizado teórico-prático interdisciplinar e do desempenho de atividades de investigação, interpretação e

intervenção na realidade de saúde do indivíduo, família e comunidade, sob supervisão docente indireta.

CAPÍTULO II

Da Legislação

Art. 2º - O presente regulamento visa orientar o estágio dos discentes, atendendo ao disposto na Resolução do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação superior n° 3, de sete de novembro de 2001, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem; bem como a Resolução nº 4, de seis de abril de 2009, que dispõe sobre a carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de Enfermagem entre outros. O presente regulamento também atende a Lei do Estágio nº 11.788 de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes nos diversos níveis de escolaridade, assim como no Regulamento do Exercício Profissional do Enfermeiro (Lei 7.498/86 e Decreto 94.406/87).

CAPÍTULO III

Dos objetivos

Art. 3º - O Estágio Curricular Supervisionado tem como objetivo:

I - Possibilitar a vivência da prática profissional e de pesquisa nas áreas de atenção primária, secundária e terciária, além da vivência junto à comunidade e à gestão do sistema e serviços de saúde;

II - Oportunizar ao discente a vivência de problemáticas do trabalho em Enfermagem através de uma prática crítico-reflexiva da realidade com articulação entre teoria e prática;

III - Fortalecer o processo de integração do discente com a realidade social e profissional;

IV - Adquirir competência e aprimorar habilidades técnico-científicas requeridas para o exercício do futuro profissional;

V - Estimular o discente para o desenvolvimento da assistência, norteada pelos preceitos do Sistema Único de Saúde - SUS, assegurando a integralidade da atenção, a qualidade e humanização do atendimento;

VI - Propiciar a reflexão sobre os aspectos éticos e legais inerentes ao exercício profissional;

VII - Sensibilizar o discente para promover transformações necessárias como resultado da reflexão e da ação sobre a realidade;

VIII - Oportunizar ao discente a prática de atividades de ensino, pesquisa e extensão;

IX - Propiciar ao discente o aprofundamento teórico-prático, oportunizando uma vivência assistencial para o aprimoramento da capacidade de interpretação e de crítica.

X. Contribuir para a consolidação do Curso de Graduação em Enfermagem da Fundação Universidade Federal de Rondônia voltado à busca de soluções para os problemas regionais e/ou nacionais.

XI. Fortalecer relações de parcerias permanente e continuada nos locais dos campos de estágio.

CAPÍTULO IV

Dos campos de estágio

Art. 4º - O Estágio Curricular Supervisionado poderá ser desenvolvido em estabelecimentos assistenciais de saúde como hospitais gerais e especializados, ambulatórios, rede básica de saúde, gestão de serviços programas e sistemas de saúde, instituições de ensino, organizações industriais e comunitárias, sendo que as referidas instituições podem ser de direito público ou privado, atendendo aos seguintes requisitos:

a) Possibilidade de aprofundamento dos conhecimentos teórico-práticos;

b) Vivência efetiva de situações concretas de vida e trabalho, dentro do campo profissional;

c) Existência de estrutura física, material e humana mínima para o adequado desempenho das atividades;

d) Celebração do Termo de Compromisso de Estágio entre a instituição concedente onde o aluno desenvolverá o estágio curricular supervisionado, a instituição de ensino e o discente;

e) Existência de demanda de clientela e infraestrutura compatíveis com os objetivos de estágio;

f) Existência de Termo de Cooperação Técnico-Científica ou convênio interinstitucional.

Parágrafo único: o Estágio Curricular Supervisionado somente poderá iniciar após celebração do Convênio/Termo de Cooperação técnico-científica bem como da celebração do Termo de Compromisso de Estágio.

CAPÍTULO V
Da metodologia dos estágios

Da duração

Art. 5º - A carga horária do estágio curricular supervisionado encontra-se disposta na matriz curricular do Curso, sendo que esta deverá ser cumprida em sua totalidade, respeitando os pré-requisitos estabelecidos e distribuída em cronograma que deverá ser apresentado pelos docentes envolvidos ao Conselho do Departamento de Enfermagem e ao local de estágio a cada início de disciplina, seguindo critérios definidos neste regulamento.

Da estrutura organizacional

Art. 6º - A estrutura organizacional do Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Graduação em Enfermagem da UNIR compreende:

a) Chefe de Departamento;

b) Docente Coordenador pela disciplina de Estágio Curricular Supervisionado lotado no Departamento de Enfermagem/UNIR;

c) Docente Supervisor - lotado no Departamento de Enfermagem/UNIR, responsável pela supervisão indireta do aluno em campo de estágio;

d) Preceptor (Enfermeiro/gerentes) da instituição de saúde, responsável pelo campo de estágio.

Da operacionalização

Art. 7º - As etapas para a operacionalização do Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Graduação em Enfermagem da UNIR compreendem:

1. Seleção do local onde o Estágio Curricular Supervisionado será desenvolvido, devendo este ser deliberado pelo Conselho de Departamento (CONDEP/DENF) e confirmada pela instituição e preceptor que acompanhará o aluno;
2. Celebração de Termo de Compromisso de Estágio entre o discente, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino;
3. Celebração do Termo de Preceptoria entre o Enfermeiro/Gerente para o acompanhamento do aluno nos serviços de saúde;
4. Formação dos grupos de discentes, conforme especificidade do campo do Estágio Curricular Supervisionado;
5. O Plano de Atividades de Estágio Obrigatório deve ser elaborado de acordo com as três partes envolvidas (acadêmico, docente do DENF/UNIR e preceptor da Unidade Concedente). A elaboração do Plano de Ensino da disciplina e do cronograma das atividades é atribuição do Docente Coordenador dos Estágios Curriculares Supervisionados, enquanto que a supervisão indireta, o acompanhamento e a avaliação do discente são de responsabilidade do professor supervisor e preceptor.
6. Após o término do Estágio Curricular Supervisionado deverá ser realizada a avaliação do estágio entre discentes, docentes supervisores e enfermeiros dos serviços de saúde.
7. A avaliação de desempenho dos alunos será realizada pelos preceptores e professores, os preceptores com valor de 30% e os professores com valor de 70% do total de 100 pontos.

Art. 8º - A efetivação do Estágio Curricular Supervisionado é realizada observando-se:

a) Matrícula na disciplina;

b) Frequência e Aprovação;

c) Convênio/Termo de Cooperação técnico-científica entre instituições que ofereçam locais para o desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado e a UNIR;
d) Termo de Compromisso de Estágio com o campo do Estágio Curricular Supervisionado.
e) Termo de Preceptoria devidamente institucionalizado

Da matrícula

Art. 9º - O discente poderá matricular-se na disciplina Estágio Curricular Supervisionado desde que tenha cumprido todas as disciplinas teóricas, teórico-práticas e práticas da estrutura curricular do curso.

Da frequência e Aprovação

Art. 10 - A frequência do discente no Estágio Curricular Supervisionado segue os critérios da normativa acadêmica da UNIR, bem como do plano de ensino da disciplina.
Parágrafo Único - O aluno que deixar de cumprir as atividades nas datas previstas no Calendário Acadêmico e nos cronogramas previamente estabelecidos, perderá o direito de conclusão da disciplina naquele período letivo.

Da prática assistencial/gerencial

Art. 11 - Serão realizadas atividades relacionadas ao desenvolvimento de competências e habilidades, visando à formação do discente em diferentes graus de complexidade como:
I. Atuar profissionalmente, respeitando os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão, a natureza humana em suas dimensões, expressões e diferentes fases evolutivas;
II. Estabelecer relações com o contexto social, reconhecendo a estrutura e as formas de organização social, bem como, compreender a política de saúde dentro das políticas sociais;
III. Reconhecer o perfil clínico e epidemiológico da comunidade intervindo estrategicamente nos níveis de prevenção na perspectiva da integralidade da assistência à saúde;

IV. Desenvolver conhecimento técnico-científico que confiram qualidade ao exercício profissional;

V. Reconhecer a saúde e condições dignas de vida como direito ao indivíduo;

VI. Atuar de forma a garantir a integralidade da assistência através de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, em todos os níveis de complexidade do sistema e em programas direcionados à saúde nos diferentes ciclos da vida;

VII. Ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de comunicar-se, de tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe e de enfrentar situações em constante mudança;

VIII. Reconhecer as relações de trabalho e sua influência na saúde;

IX. Comprometer-se ética, humanística e socialmente com o trabalho multiprofissional, integrando as ações de enfermagem às ações multiprofissionais;

X. Promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades dos usuários, famílias e comunidade, atuando como agente de transformação social;

XI. Utilizar adequadamente novas tecnologias;

XII. Intervir no processo de saúde-doença, responsabilizando-se pela qualidade da assistência de enfermagem em seus diferentes níveis de atenção à saúde;

XIII. Compreender e coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos e demandas de saúde;

XIV. Desenvolver habilidades voltadas ao planejamento, implementação e participação em programas de educação permanente dos trabalhadores de enfermagem e de saúde;

XV. Participar, desenvolver e aplicar pesquisas e outras formas de produção do conhecimento que objetivem a qualificação da prática profissional;

XVI. Contribuir com a dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo-se como agente desse processo;

XVII. Estimular a participação nas estruturas consultivas e deliberativas do Sistema Único de

Saúde;

XVIII. Desenvolver o cuidado da própria saúde física e mental visando o seu bem-estar durante a vida acadêmica e de futuro profissional;

XIX. Desenvolver atividades gerenciais nos serviços de enfermagem, em todos os níveis de complexidade do sistema bem como nos Programas de saúde.

CAPÍTULO VI

Das formas de acompanhamento

Art. 12 - Entende-se por orientação de Estágio Curricular Supervisionado a atividade destinada a acompanhar e avaliar o discente de forma a garantir a execução dos objetivos estabelecidos no plano de ensino da disciplina;

Parágrafo 1º - A orientação de estágio é realizada por docente lotado no Departamento de Enfermagem da UNIR, sendo assegurando a efetiva participação do enfermeiro/gerente do serviço de saúde (preceptor);

Parágrafo 2° - A orientação do discente em Estágio Curricular Supervisionado será realizada por meio do acompanhamento e da supervisão indireta do docente em campo de estágio, bem como da realização de reuniões sistemáticas programadas previamente e estabelecidas no plano da disciplina entre docente, discente e preceptor do serviço de saúde.

Do coordenador de Estágio

Art. 13 - Ao coordenador da disciplina compete as seguintes atribuições:

I. Atuar na seleção dos campos onde serão desenvolvidos os estágios curriculares supervisionados, juntamente com o coordenador de curso;

II. Ir às instituições solicitar autorização para o início do Estágio Curricular Supervisionado;

III. Solicitar os Termos de Compromisso de Estágio ao departamento e encaminhar para os alunos providenciarem os documentos necessários;

IV. Assegurar que o processo de avaliação seja realizado através do instrumento definido e aprovado pelo CONDEP/DENF.

V. Coordenar todas as atividades relacionadas ao desenvolvimento do estágio;

VI. Elaborar juntamente com os docentes supervisores o plano da disciplina, que além do conteúdo programático e objetivos deverá conter o cronograma das atividades com os campos de estágio e distribuição de alunos/campo;

VII. Informar ao enfermeiro preceptor qualquer alteração que possa influenciar no andamento das atividades pré-estabelecidas no cronograma;
VIII. Proporcionar reuniões/contatos frequentes com os docentes supervisores visando a troca de informações, o aprimoramento e solução de problemas relativos ao desenvolvimento do estágio.
Parágrafo único: cabe à Chefia do Departamento de Enfermagem a designação do docente responsável pela coordenação da disciplina Estágio Curricular Supervisionado.

Do docente responsável pela supervisão do discente em campo de estágio

Art. 14 - É função do docente responsável pela supervisão indireta do discente em campo de estágio:
I. Executar o plano da disciplina conforme aprovado pelo CONDEP/DENF e estabelecido por este regulamento.
II. Realizar reuniões de planejamento, organização e avaliação com o preceptor do serviço de saúde responsável pelo campo de estágio, visando à integração ensino-serviço;
III. Orientar e acompanhar o desenvolvimento do discente através da supervisão indireta em campo de estágio;
IV. Informar o docente coordenador fatos relacionados ao desenvolvimento de suas atividades e/ou do discente quando estes necessitarem de providências superiores;
V. Participar ativamente do processo ensino/aprendizagem do acadêmico co responsabilizando-se pelas orientações e avaliações.

Do preceptor da instituição de saúde, responsável pelo campo de estágio

Art. 15 - Ao preceptor da instituição de saúde, responsável pelo campo de estágio, compete:
I. Receber o discente designado para o campo de estágio, mostrando as normas e rotinas da instituição, facilitando a inclusão do mesmo nas atividades;
II. Acompanhar a frequência do discente durante o Estágio Curricular Supervisionado;
III. Participar da avaliação juntamente com o docente responsável pela supervisão indireta do discente em campo de estágio, atribuindo 30% do valor da nota do aluno;

IV. Comunicar possíveis intercorrências no andamento do Estágio Curricular Supervisionado ao docente supervisor da UNIR;

V. Favorecer o processo educativo teórico-prático do discente durante o Estágio Curricular Supervisionado;

VI. Favorecer a integração do discente junto à equipe multiprofissional.

VII. Supervisionar e orientar o acadêmico nas atividades assistenciais sempre que for necessário;

Do discente

Art. 16 - Ao discente compete as seguintes atribuições:

I. Assinar o Termo de Compromisso de Estágio;

II. Cumprir rigorosamente os horários determinados para o estágio e a programação estabelecida;

III. Apresentar-se devidamente uniformizado e identificado, segundo as normas do Curso de Graduação em Enfermagem da UNIR, da instituição de saúde onde realizará o estágio, observando as normas universais de biossegurança para os serviços de saúde;

IV. Portar e utilizar adequadamente o material básico exigido pela disciplina, além do material de biossegurança sempre que houver a necessidade (equipamentos de proteção individual como jaleco, gorro, máscara, luvas, óculos, etc);

V. Dedicar-se ao desenvolvimento do estágio;

VI. Desenvolver as atividades propostas pelo docente supervisor e pelo enfermeiro da instituição de saúde;

VII. Não se ausentar do local onde está realizando o Estágio Curricular Supervisionado sem o prévio consentimento do docente supervisor e/ou do enfermeiro da instituição de saúde;

VIII. Participar de reuniões promovidas pelo docente supervisor e preceptor da instituição de saúde;

IX. Agir dentro da ética e de acordo com os preceitos legais da profissão, respeitando o docente, a equipe multiprofissional e o ser humano a quem presta o cuidado de enfermagem;

X. Zelar pelo bom nome da instituição que representa e da instituição conveniada;

XI. Preservar os materiais e equipamentos das instituições;

XII. Desenvolver uma postura crítica e construtiva em benefício de sua formação profissional;

XIII. Buscar aperfeiçoamento contínuo;

XIV. Cumprir as disposições das normas de estágio, bem como as demais contidas nas normas acadêmicas da UNIR;

XV. Cumprir com assiduidade as atividades constantes no plano da disciplina com orientação e supervisão do docente da UNIR e do enfermeiro preceptor do serviço;

XVI. Comunicar ao docente supervisor situações que ocorram em campo de estágio e que necessitem de sua interferência para garantir a qualidade do serviço oferecido e do processo ensino-aprendizagem.

CAPÍTULO VII

Do processo de avaliação

Art. 17 - A avaliação é parte integrante do processo pedagógico, sendo sistemática e contínua.

I. A ficha de avaliação é específica da disciplina, devendo conter as competências, habilidades e atitudes esperadas, nas várias áreas de atuação;

II. O discente deverá tomar conhecimento dos critérios de avaliação e do processo de acompanhamento antes do início do estágio;

III. Diariamente durante o estágio, o discente deverá fazer anotações referentes às atividades desenvolvidas e seu desempenho no formulário específico da disciplina;

IV. A ficha de avaliação deve ser assinada pelo docente supervisor, pelo preceptor e pelo discente, no decorrer do período de estágio;

V. Ao final do estágio curricular o discente deverá apresentar o relatório de acordo com o modelo estabelecido pelos docentes da disciplina ou deixar um produto específico para o serviço de acordo com as necessidades do setor/instituição em que se insere.

CAPÍTULO VIII

Das disposições finais

Art. 18 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Departamento do Curso de Graduação em Enfermagem/UNIR;

Art. 19 - O discente estará assegurado pelo seguro contra acidentes pessoais, o que não o exime de sua responsabilidade com a segurança individual e coletiva.

Apêndice 4 – Questionário do plano de acompanhamento de egresso DENF/UNIR

QUESTIONÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS

Parte I – Dados de Identificação

Caracterização dos egressos

Data de nascimento: __/__/___ Sexo: [ ] F [ ] M

Estado Civil: _____ Nº de filhos: _____

Faixa Etária do egresso: - Entre 21 e 25 anos [ ]
- Entre 26 e 30 anos [ ]
- 31 anos e acima [ ]

Você: - concluiu o curso de Graduação em Enfermagem [ ]
- desistiu / abandonou o curso [ ]
- foi transferido(a) [ ]

Ano de desligamento do Curso: _____

Tempo utilizado para a conclusão do Curso, em semestres:_____

Qual o seu conhecimento de línguas estrangeiras?

-Inglês: [ ] básico [ ] intermediário [ ] avançado

-Espanhol: [ ] básico [ ] intermediário [ ] avançado

-Francês: [ ] básico [ ] intermediário [ ] avançado

-Outras: Qual?_____ [ ] lê [ ] escreve [ ] fala

Ao concluir o Curso de Bacharelado em Enfermagem, cursou pós-graduação?

[ ] Especialização 1. Qual _____

Instituição_____ Em Curso_____ Ano de Conclusão _____

[ ] Especialização 2. Qual _____

Instituição_____ Em Curso_____ Ano de Conclusão _____

[ ] Especialização 3. Qual _____

Instituição_____ Em Curso_____ Ano de Conclusão _____

[ ] Mestrado. Área_____

Instituição_____ Em Curso_____ Ano de Conclusão _____

[ ] Doutorado. Área_____

Instituição_____ Em Curso_____ Ano de Conclusão _____

[ ] Não fez nenhum curso.

[ ] Outros. Especificar: Tipo_____ Área_____,

Instituição_____ Em Curso_____ Ano de Conclusão _____

Trabalha atualmente? [ ] Sim [ ] Não

Em caso afirmativo, responda

Emprego 1

Tipo de instituição [ ] Pública [ ] Privada Outras [ ] especificar

_____

[ ] UBS [ ] CAPS [ ] PSF

[ ] Hospital [ ] Assistência domiciliar [ ] Laboratório

[ ] Ensino profissionalizante [ ] Ensino superior

[ ] Outro_____

Há quanto tempo nesta instituição: _____data de ingresso ___/___/_____
Cargo que ocupa _____
Salário/renda mensal: _____ (em reais)
Emprego 2 [ ] Sim [ ] Não
Tipo de instituição [ ] Pública [ ] Privada Outras [ ] especificar
_____
[ ] UBS [ ] CAPS [ ] PSF
[ ] Hospital [ ] Assistência domiciliar [ ] Laboratório
[ ] Ensino profissionalizante [ ] Ensino superior
[ ] Outro_____
Há quanto tempo nesta instituição: _____ data de ingresso __/__/___
Cargo que ocupa _____
Salário/renda mensal: _____ (em reais)
Emprego 3 [ ] Sim [ ] Não
Tipo de instituição [ ] Pública [ ] Privada Outras [ ] especificar
_____
[ ] UBS [ ] CAPS [ ] PSF
[ ] Hospital [ ] Assistência domiciliar [ ] Laboratório
[ ] Ensino profissionalizante [ ] Ensino superior
[ ] Outro_____
Há quanto tempo nesta instituição: ____ data de ingresso __/__/___
Cargo que ocupa _____
Salário/renda mensal: _____ (em reais)
Aponte três áreas de interesse na formação em pós-graduação – especialização:
1- _____
2- _____
3- _____
Parte II – Perguntas
1) A formação no DENF/UNIR contribuiu para a sua inserção no mercado de trabalho?
[ ] Sim [ ] Não
2) Se SIM, em que aspectos a formação como enfermeiro no DENF/UNIR contribuiu para a sua inserção no mundo/mercado de trabalho?
3) O que não foi abordado no curso durante a sua formação no DENF/UNIR que dificultou a sua inserção e/ou permanência no mundo/mercado de trabalho?
4) Para a sua inserção e permanência no mundo do trabalho, quais competências foram requeridas? Assinale sim ou não para cada alternativa abaixo.
Domínio de conhecimento técnico-científico [ ] Sim [ ] Não
Tomada de decisões [ ] Sim [ ] Não
Comunicação [ ] Sim [ ] Não
Liderança [ ] Sim [ ] Não
Administração [ ] Sim [ ] Não
Educação de equipes [ ] Sim [ ] Não
Relacionamento interpessoal [ ] Sim [ ] Não
Pensamento / visão crítico-reflexivo [ ] Sim [ ] Não
Conhecimentos interdisciplinares [ ] Sim [ ] Não
Ética [ ] Sim [ ] Não

Outras. Quais? _____
5) Estas competências foram desenvolvidas durante a graduação? Assinale as opções Sim ou Não ou Em parte para as alternativas abaixo e Justifique-as.
Domínio de conhecimento técnico-científico[ ] Sim [ ] Não [ ] Em parte
Justifique: _____
Tomada de decisões [ ] Sim [ ] Não [ ] Em parte
Justifique: _____
Comunicação [ ] Sim [ ] Não [ ] Em parte
Justifique: _____
Liderança [ ] Sim [ ] Não [ ] Em parte
Justifique: _____
Administração [ ] Sim [ ] Não [ ] Em parte
Justifique: _____
Educação de equipes [ ] Sim [ ] Não [ ] Em parte
Justifique: _____
Relacionamento interpessoal [ ] Sim [ ] Não [ ] Em parte
Justifique: _____
Pensamento / visão crítico-reflexivo [ ] Sim [ ] Não [ ] Em parte
Justifique: _____
Conhecimentos interdisciplinares [ ] Sim [ ] Não [ ] Em parte
Justifique: _____
Ética [ ] Sim [ ] Não [ ] Em parte
Justifique: _____
Outras. Quais? _____
Justifique: _____
6) Que sugestões você daria para:
- Formação de futuros enfermeiros?
- Cursos de pós-graduação Latu Sensu?
- Cursos de pós-graduação Strictu Sensu?

ANEXOS